科普资料汇编 · V0.2

精神分裂症资料库

模块内容与延伸专题

阅读提示：本资料仅供学习科普，不能替代精神科专业评估、诊断或处方。请勿据此自行判断病情或增减、停用药物；遇到迫切安全风险，请联系当地急救或急诊服务。

目录

资料库总目录

目录

模块1：基础定义与疾病概况

1. 疾病正式名称
2. 疾病本质
3. 发病流行病学
4. 疾病分型演变
5. 常见名词释义

模块2：病因与发病机制

1. 遗传因素
2. 大脑生物学机制
3. 环境诱因
4. 心理社会因素
5. 目前研究局限

模块3：临床表现

3.1 阳性症状

3.2 阴性症状

3.3 认知损害

3.4 情绪相关表现

3.5 疾病分期

模块4：诊断与鉴别诊断

1. 诊断标准
2. 诊断流程
3. 鉴别诊断
4. 评估量表简介

模块5：治疗方案

5.1 药物治疗

5.2 心理社会干预

模块6：预后、复发风险与康复管理

1. 影响预后的因素
2. 复发预警信号
3. 长期康复管理
4. 社会功能康复
5. 风险内容

模块7：社会议题、误区与污名

1. 常见谣言澄清
2. 家属照护难点
3. 法律与权益
4. 大众科普方向

模块8：参考文献、资源与研究进展

1. 权威来源标注
2. 区分证据等级
3. 延伸阅读与求助资源
4. 资料库备注栏

可选附加小模块

共病专题

患者康复视角

照护手册

精神分裂症资料库（自建整理方案）

> 重要前置提醒：**本资料库仅作科普、知识学习用途，绝对不能替代临床诊断、用药方案、面诊治疗；严禁用于自行判断病情、调整药物。所有内容标注信息来源，区分【临床共识/研究结论/个人经验/争议观点】。**

整体建议分成**8大模块**，下面列出每个模块可以收集整理的具体内容，你可以按需删减。

模块1：基础定义与疾病概况

核心：是什么病，基本概念，容易混淆的名词

1. 疾病正式名称（精神分裂症，ICD-11、DSM-5诊断名称）
2. 疾病本质：大脑神经发育/神经递质相关的慢性重性精神障碍；**不是人格分裂**（重点澄清大众误区）
3. 发病流行病学：发病高峰年龄、男女差异、患病率、复发率、致残特点
4. 疾病分型演变：旧的分型（偏执型、青春型、紧张型等），DSM-5/ICD11不再强调传统亚型的说明
5. 常见名词释义：阳性症状、阴性症状、认知症状、前驱期、发作期、缓解期、残留状态

模块2：病因与发病机制（多因素，无单一病因）

1. 遗传因素：家族风险、同卵双生子研究，**不是“父母有就一定会遗传”**
2. 大脑生物学机制：多巴胺假说、谷氨酸假说；脑结构（海马、前额叶）影像学发现
3. 环境诱因：孕期风险（感染、缺氧）、童年创伤、长期高压、物质滥用（大麻是明确高危）、重大应激事件
4. 心理社会因素：只作为诱因，**不是“想不开、性格差导致”**（纠正常见污名化误区）
5. 目前研究局限：病因没有完全破译，各种假说的证据强弱区分

模块3：临床表现（症状系统，重点区分阳性/阴性/认知）

3.1 阳性症状（“多出”的体验）

幻觉（幻听最常见，幻视、幻嗅等）、妄想（被害、关系、夸大、钟情妄想等）、思维破裂、行为紊乱、紧张症

3.2 阴性症状（“失去”能力）

情感淡漠、意志减退、社交退缩、言语贫乏、快感缺失

3.3 认知损害（很多患者长期核心困扰）

注意力差、工作记忆下降、执行功能受损、决策困难，很多时候阴性+认知症状更影响长期生活

3.4 情绪相关表现

抑郁、焦虑、易激惹；区分是疾病本身，还是药物副作用、心理应激

3.5 疾病分期

- 前驱期（发病前，微妙变化，很难识别）
- 急性发作期（明显精神病性症状）
- 巩固期（症状控制，防复发）
- 维持期（长期稳定康复）

模块4：诊断与鉴别诊断

> 注意：**诊断权仅限精神科执业医师**，资料库写明：不能自测诊断

1. ICD-11、DSM-5 两套诊断标准原文摘要
2. 诊断流程：病史采集、精神检查、躯体检查、抽血/影像（排除器质性问题）
3. 鉴别诊断（非常重要，很多情况会被误判）

- 双相情感障碍伴精神病性症状
- 重度抑郁伴精神病性症状
- 脑器质性疾病：脑炎、脑肿瘤、脑梗、脑外伤

- 物质所致精神病（毒品、部分药物诱发）
- 解离障碍、妄想性障碍、自闭症等

1. 评估量表简介：PANSS阳性阴性量表、SAPS/SANS，说明量表**仅辅助评估，不等于诊断**

模块5：治疗方案（循证医学为主）

5.1 药物治疗（一线核心）

- 抗精神病药分类：第一代（传统）、第二代（非典型，现在首选）
- 常见药物清单，各自特点、常见不良反应（体重增加、泌乳素升高、锥体外系反应、嗜睡等）
- 长效针剂：适用场景、优势（解决漏服，降低复发）
- 重要内容：减药、停药原则；**严禁自行突然停药**，撤药反应、复发风险
- 辅助用药：合并抗焦虑、抗抑郁、情绪稳定剂的适用情况
- 特殊治疗：MECT（无抽搐电休克）：适应症、流程、疗效、常见顾虑与不良反应

5.2 心理社会干预（药物之外康复核心）

认知行为治疗CBTp、家庭干预、社交技能训练、职业康复、支持性心理治疗

> 说明：单纯心理咨询**不能治愈**急性精神病发作，仅作为药物基础上的辅助康复手段

模块6：预后、复发风险与康复管理

1. 影响预后的因素：起病年龄、前驱期长短、是否尽早规范治疗、家庭支持、坚持服药、认知损害程度
2. 复发预警信号（重点实用内容）：睡眠变差、多疑加重、社交退缩、情绪反常、旧症状复现
3. 长期康复管理：复诊规律、药物依从性、作息、戒酒戒毒品、压力管理
4. 社会功能康复：居家生活、社交、就业、学习的支持方案
5. 风险内容：自伤、伤人风险评估，危机处理原则

模块7：社会议题、误区与污名

1. 常见谣言澄清：

- 不是“疯子”，不是暴力犯罪者（患者暴力风险并不高于普通人群，急性发作期才存在风险）
- 不是“被鬼神附身”、不是单纯心理问题
- 不等于终身完全丧失劳动能力；部分人可以维持稳定生活、工作

1. 家属照护难点：家属心理压力、沟通技巧、如何避免对立
2. 法律与权益：精神障碍患者的民事、监护，残疾证申请，医保政策，就业保护、隐私保护
3. 大众科普方向：如何减少歧视

模块8：参考文献、资源与研究进展

1. 权威来源标注：《中国精神分裂症防治指南》最新版、ICD/DSM原文、权威医学期刊、国内精神医学学会资料
2. 区分证据等级：指南推荐（强证据）、前沿研究（初步证据）、假说（待验证）
3. 延伸阅读、正规公益求助渠道、专业机构
4. 资料库备注栏：所有未定论研究要标明“尚在研究，未用于常规临床”

可选附加小模块（看你需求）

- 【患者康复视角】：康复者自述（注明是个人体验，不能代表全部患者）
- 【照护手册】：家属实操沟通、危机应急清单
- 【共病专题】：精神分裂症常共病抑郁、焦虑、物质依赖、代谢综合征（药物带来高血脂高血糖）

资料库建设的2个关键规则（强烈建议写在资料库首页）

1. 免责声明：**资料库为知识整理，不能作为诊断、用药依据；任何症状务必前往正规精神卫生中心/医院精神科就诊。**
2. 来源标注原则：每一条关键结论尽量标注来源，区分临床指南、综述、个案、科普文章，避免混杂网络传言。

1. 疾病正式名称

> 本页用于说明"精神分裂症"在现行诊断分类系统中的正式名称、编码、历史由来，以及大众容易混淆的叫法。**核心提醒：名称里的"分裂"指的是心理功能之间的联系紊乱，绝不是"一个人身体里住着好几个灵魂"。** 诊断权仅限精神科执业医师，本页仅作名词科普，不能用于自我诊断。

1.1 现行正式名称与编码

项目	内容
中文正式名称	精神分裂症
英文正式名称	Schizophrenia
ICD-11 分类章节	"精神、行为或神经发育障碍"（Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders）
ICD-11 类别代码	**6A20**（Schizophrenia）
DSM-5 / DSM-5-TR 名称	Schizophrenia（DSM-5 于 2013 年发布，DSM-5-TR 于 2022 年修订，名称沿用未变）

【临床共识】ICD（国际疾病分类）由世界卫生组织维护，全球用于健康信息记录、医保结算与统计；DSM（《精神障碍诊断与统计手册》）由美国精神医学学会（APA）编制，主要用于临床描述与研究。两套系统的条目、诊断病程要求和编码用途并不完全相同，例如 ICD-11 允许在诊断后附加发作次数、病程模式和症状特征的描述性标注，而 DSM-5 使用严重程度标注与亚型/标注符体系。各国采用 ICD 版本有时间差（ICD-11 于 2018 年由世界卫生大会通过，成员国陆续实施），因此不能仅凭一个国际编码推断当地病历、医保或行政事务实际使用的编码。

1.2 名称的历史：从"早发性痴呆"到"精神分裂症"

【研究结论】 现代意义上对这组疾病的系统描述，通常追溯到 19 世纪末德国精神科医生 **Emil Kraepelin（克雷丕林）**。他把一组多在青少年晚期至成年早期起病、病程迁延、逐渐出现社会功能衰退的患者归为一类，命名为 **Dementia praecox**，拉丁文意为"早发性痴呆"（premature dementia）。需要强调：这里的"痴呆"是 19 世纪的历史术语，描述的是"心智功能较早地走向衰退"，**完全不等于今天所说的阿尔茨海默病等老年期神经认知障碍**，也不意味着患者智力必然低下。

20 世纪初，瑞士精神科医生 **Eugen Bleuler（布鲁勒）** 认为 Kraepelin 描述的范围偏窄、且"痴呆"一词过于悲观。他于 1908 年前后提出 **Schizophrenia**（德文 Schizophrenie）一词，词源来自希腊语 *schizein*（分裂）+ *phren*（精神、心智）。Bleuler 用这个词想表达的是：患者的**思维、情感、感知、意志等心理功能之间原本协调统一的"联结"出现了断裂**——比如内心没有相应情绪体验，却在不该哭的时候哭、不该笑的时候笑；想到亲人去世却毫无波澜。

【临床共识】 Bleuler 本人在提出这个词时就反复澄清："分裂"是指心理功能内部的脱联结，**不是指一个人具有多个彼此独立的人格。**这一原意与后世大众望文生义产生的"人格分裂"想象相去甚远。由于"精神分裂症"这个中文译名中"分裂"二字极具误导性，它客观上加剧了公众误解和病耻感。

1.3 简称、俗称与不推荐使用的称呼

称呼	性质	说明
分裂症	非正式简称	偶见于口语或潦草病历，不宜替代完整诊断名称
精神病 / 发神经	范围过宽	"精神病"可泛指一切精神病性状态或多种重性精神障碍，不是精神分裂症的同义词
疯子 / 癫子	贬损、污名	非医学诊断，带有歧视色彩，不应用于称呼患者
神经病	含义混乱	日常中文里既可被理解为神经系统疾病（如中风、神经炎），又被当作骂人的话，医学上极不推荐
人格分裂 / 双重人格 / 多重人格	错误对应	对应的是"解离性身份障碍"，与精神分裂症是完全不同的两种疾病（详见 1.4）

【临床共识】使用中性、准确的语言（如"精神分裂症患者""一位康复中的朋友"）既是对患者的尊重，也是减少污名的第一步。

1.4 容易混淆、但并非同一诊断的名称

诊断名称	与精神分裂症的关系	关键区别
分裂样障碍（Schizophreniform disorder）	同属精神病性障碍谱系	症状可与精神分裂症相似，但病程时长要求不同（DSM-5 要求症状持续 1–6 个月；精神分裂症要求 ≥6 个月），并非"轻型精神分裂症"
分裂情感性障碍（Schizoaffective disorder）	与之相邻、需重点鉴别	既有显著的心境（躁狂/抑郁）发作，又有精神病性症状；关键在于精神病性症状是否在没有心境发作时仍持续存在 ≥2 周
解离性身份障碍（Dissociative identity disorder, DID）	**最常被误当成"精神分裂症"**	核心是存在两个或更多彼此分离的身份状态、伴随记忆断层；旧称"多重人格障碍"。它与思维、感知紊乱为主的精神分裂症不是一回事
妄想障碍（Delusional disorder）	另一独立诊断	以持续、固定的妄想为核心，缺乏精神分裂症典型的思维破裂、幻觉（尤其评论性幻听）和明显功能衰退
短暂精神病性障碍	病程更短	精神病性发作持续 1 天至 1 个月内可完全缓解

【临床共识】**名称相近 ≠ 疾病相同。** 这些诊断之间的界限，需要精神科医生结合完整病史、症状组合、持续时间、功能损害和病程演变来判断，患者和家属不能仅凭"症状有点像"自行对号入座。

1.5 台湾地区译名"思觉失调症"

【研究结论】由于"精神分裂症"这一名称长期被公众误解为"人格分裂""精神已经裂开"，并带来强烈病耻感，台湾地区于 2014 年由台湾精神医学会倡议，将 Schizophrenia 的中文译名调整为 **"思觉失调症"**，取"思考、知觉等心智功能失调"之意，希望弱化"分裂"二字带来的恐怖联想。香港部分专业文献也采用类似立场。

【临床共识】中国大陆目前仍沿用"精神分裂症"作为规范诊断名称。面向大陆读者写作时，本资料库统一使用"精神分裂症"，但会主动说明它**不等于解离性身份障碍（多重人格）**，以减少误解。这是一个译名与科普策略问题，不是疾病本身发生了变化。

1.6 一句话澄清最重要的误区

> **精神分裂症的"分裂"，是指一个人自己的思维、情绪、感知之间协调关系的断裂；而不是一个人身体里住着两个或更多轮流掌权的人格。** "多重人格"在医学上叫解离性身份障碍，是另一种病。把两者混为一谈，既不利于精神分裂症患者，也不利于解离障碍患者。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 疾病分类与编码（6A20 Schizophrenia）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR），2024
- American Psychiatric Association：DSM-5-TR 官方页面
- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet.* 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-6)01121-6)

2. 疾病本质

> **核心结论：**精神分裂症是一种与大脑神经发育和神经递质调节相关的**慢性、重性精神障碍**，本质是感知、思维、情感、意志和行为等心理功能出现紊乱，并伴随**现实检验能力受损。**它是可以治疗的医学疾病，**不是人格分裂，不是"想不开"，更不是"心眼小、意志薄弱"。**但它常呈慢性、反复发作的病程，需要长期规范管理。

2.1 它到底是一种什么病

【临床共识】从现代医学视角看，精神分裂症属于**重性精神疾病（severe mental illness, SMI）**范畴，世界卫生组织将其列入"精神、行为或神经发育障碍"。它的本质特征可以概括为以下几点：

1. **大脑层面的功能紊乱**：与神经发育轨迹、神经递质（多巴胺、谷氨酸等）调节、脑网络连接异常有关（详见模块2）。
2. **心理功能的广泛受累**：不是单一情绪问题，而是同时影响感知（如幻觉）、思维内容（如妄想）、思维形式（如言语散漫）、情感表达（如情感淡漠）、意志行为（如退缩、紊乱）和认知（如注意力、工作记忆）。
3. **现实检验能力受损**：患者在疾病活跃期难以区分"内心体验"与"外部现实"——例如把幻听当成真实存在的声音，把妄想当成不容置疑的事实。这是它与一般心理困扰最关键的区别之一。
4. **社会功能明显受损**：学业、职业、人际、自我照料能力可能显著下降，这也是它被归为"重性"的原因。

2.2 三组核心症状维度

【临床共识】现代观点不再把精神分裂症看成"一组单一症状"，而是按"多出来的体验"和"失去的能力"两个方向拆分：

症状维度	通俗理解	典型表现
阳性症状	正常心理功能"多出"了异常内容	幻觉（尤其评论性、命令性幻听）、妄想（被害、关系、被控制感等）、思维形式紊乱、行为紊乱或紧张症
阴性症状	正常心理功能"减退或缺失"	情感淡漠、言语贫乏、意志减退、社交退缩、快感缺失（体验快乐的能力下降）
认知症状	信息加工能力下降	注意力难以集中、工作记忆下降、执行功能（计划、判断、抑制冲动）受损

【研究结论】大量随访研究提示，**对患者长期社会功能影响最大的，往往不是时好时坏的阳性症状，而是持续存在的阴性症状与认知损害。**这也是为什么治疗目标不能只停留在"消除幻觉妄想"。

2.3 三个必须澄清的误区

误区一："精神分裂症就是人格分裂 / 多重人格"

【临床共识】这是公众最普遍、也最伤害患者的误解。

- 精神分裂症：一个人的**统一自我**还在，只是这个自我的思维、情绪、感知之间协调关系出了问题；
- 解离性身份障碍（旧称"多重人格障碍"）：一个人内部出现多个彼此分离、互相不知道对方存在的身份状态，常与严重童年创伤相关。

两者在病因、症状、治疗上都完全不同。把精神分裂症患者说成"人格分裂"，既不准确，又会加剧恐惧和污名。

误区二："就是想不开、钻牛角尖、性格太内向才得病"

【临床共识】这是另一类典型污名。精神分裂症有明确的生物学基础（遗传易感性、神经发育异常、神经递质失调），**性格内向、多愁善感既不是病因，也不是"罪证"。**一个人性格开朗、事业有成，同样可能患病；病后性格变化，很多时候是疾病本身或药物副作用的结果，而不是原因。

误区三："得了这个病就一辈子完了、治不好"

【研究结论】这是过度悲观。规范治疗（抗精神病药为核心 + 心理社会康复）可以使绝大多数患者的急性症状得到控制，相当比例的患者可以回到学校、工作岗位和家庭生活。预后与起病年龄、是否早治、是否坚持服药、家庭支持等密切相关（详见模块6）。"慢性、易复发"是客观事实，但"慢性"≠"不可逆"，更不等于"没有尊严地活着"。

2.4 病程：为什么说它"慢性、易复发"

【临床共识】精神分裂症的自然病程通常不是"一直疯"，而是呈**发作—缓解—部分残留—再发作**的波动模式：

- **前驱期**：首次明显发作前数月到数年，可能出现睡眠变差、社交退缩、学习工作效率下降、敏感多疑等非特异性变化，常被误认为"青春期叛逆""抑郁"。
- **急性发作期**：出现明显幻觉、妄想、行为紊乱，现实检验能力严重受损，多需积极药物治疗。
- **巩固期 / 维持期**：症状逐渐控制，但需继续服药预防复发。
- **复发**：擅自停药、漏服、遭遇重大应激、物质滥用等都可能诱发。经典研究显示，**停药后 1 年内复发比例可高达约 80%**，而坚持维持治疗者复发率显著降低（详见模块6）。

【研究结论】需要客观说明的是：部分患者在多次发作后可能残留阴性症状和认知损害，社会功能难以完全回到病前水平；但也有相当比例的患者经规范治疗后可保持长期稳定。病程个体差异很大，不能用"一定会恶化"或"一定会痊愈"来概括任何人。

2.5 它是"病"，不是"错"

【临床共识】综合以上，理解精神分裂症最准确的方式是：

> 它是一种**有生物学基础、需要医学干预、可以规范治疗、需要长期管理**的大脑疾病；就像糖尿病需要长期控制血糖、高血压需要长期监测血压一样，精神分裂症需要长期坚持治疗与康复。患者不是"矫情"，家属也不是"教坏了孩子"。

这一立场既符合现代精神医学共识，也有助于去除笼罩在患者和家庭头上多年的羞耻感。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- American Psychiatric Association：Schizophrenia（DSM-5-TR 概要）
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet.* 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- 中华医学会精神医学分会. 中国精神分裂症防治指南（第二版）. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015.
- StatPearls. **Schizophrenia.** NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539864/

3. 发病流行病学

> **核心结论：**精神分裂症是一种相对少见（全球约每 300 人中 1 人）、但疾病负担沉重的重性精神障碍。发病高峰集中在青少年晚期到 30 多岁，男性起病平均早于女性；病程慢性、复发率高，并伴随预期寿命缩短和显著的社会功能损害。以下数字均为群体层面的统计估计，不能用来预测任何个人的命运。

3.1 全球与中国患病率

【研究结论】根据世界卫生组织最新更新的事实清单：

指标	估计值	来源
全球现患人数	约 2700 万人（早期版本约 2400 万）	WHO 事实清单（2026 年更新）
全球时点患病率	约 1/300，即 0.29%（早期版本为 0.32%）	WHO
20 岁以上成人患病率	约 1/206，即 0.49%（早期版本约 0.45%）	WHO
终身患病风险	约 0.7%–1.0%（即一生中有约 1% 的概率被诊断）	多项流行病学综述
年发病率	约每万人 0.1–0.5 例（即每年每 1 万人新增 1–5 人）	McGrath 等系统综述

【临床共识】需要注意：

- 不同研究因诊断标准、调查方法、漏报程度不同，患病率数字会有差异（0.3%–1.5% 都可见于文献）；
- 由于病耻感、就医可及性差异，**发展中国家的实际患病人数常被低估**——WHO 指出全球约三分之二精神病性障碍患者没有获得专门的精神卫生服务；
- 中国流行病学调查（如 2019 年《Lancet Psychiatry》发表的中国精神卫生调查 CMHS）显示，包括精神分裂症在内的精神病性障碍终生患病率约为 0.6%–0.7% 量级，与全球数据大体一致。

3.2 发病年龄高峰与性别差异

【研究结论】精神分裂症的发病年龄有非常鲜明的"年轻化"特征，并且存在明确的性别差异：

维度	男性	女性
首次发病高峰	约 15–25 岁（青少年晚期到 20 多岁）	约 25–35 岁
平均起病年龄	偏早，约 18–25 岁	偏晚，约 25–35 岁
是否存在第二高峰	一般无明显第二高峰	约 45–50 岁前后可见一个较小的第二发病高峰
总体发病率	略高（男 : 女约 1.4 : 1）	略低
症状表现	阴性症状、认知损害常更突出，预后相对较差	情感症状、抑郁、躁狂样表现相对多见，预后相对较好

【临床共识】"青少年晚期到 30 多岁"正是一个人升学、就业、建立亲密关系的关键期，所以精神分裂症对人生轨迹的打击格外大。女性中年第二高峰的可能解释包括雌激素的神经保护作用、绝经后激素水平下降、以及中年期更多的社会应激事件等，目前尚无单一确定解释。

3.3 复发率与病程轨迹

【研究结论】精神分裂症的复发风险高，且与是否坚持治疗密切相关：

情境	1 年内复发比例（经典估计）	说明
自行停药 / 完全不维持治疗	**约 70%–80%**	经典停药研究中，停药组 1 年复发率可达 79%，5 年累计首次复发风险约 82%
规律服用维持剂量抗精神病药	**约 15%–25%**	Cochrane 系统综述显示，药物组 7–12 个月复发率约 24%，安慰剂组约 61%
首次发作后缓解者，停药策略	随访 6 个月平均复发率约 50%，维持治疗组约 16%	系统综述结论

【临床共识】这一组数字是临床上反复强调"**严禁自行突然停药**"的核心依据（详见模块5）。但需要说明：复发率是群体平均数，不是说"停药就一定复发"，更不是说"一辈子不能减药"——任何减停都必须在精神科医生评估下逐步、谨慎进行。

3.4 致残特点与疾病负担

【研究结论】精神分裂症虽然患病率不高，但**致残程度极重、疾病负担巨大**：

- **DALY（伤残调整生命年）**：WHO 和全球疾病负担研究（GBD）将精神分裂症列为导致青壮年残疾的主要原因之一；它不像心血管病、癌症那样广为人知，但在 15–44 岁年龄组的疾病负担中排名靠前。
- **预期寿命缩短**：多项大型随访研究一致显示，精神分裂症患者的**平均预期寿命比普通人群缩短约 10–20 年**（StatPearls 等资料约为缩短 15 年）。
- **早亡原因构成**：
- **自杀**：约 5%–10% 的患者最终死于自杀，多发生在疾病早期、共病抑郁或刚出院阶段；
- **躯体疾病**：心血管病、糖尿病、代谢综合征（部分由抗精神病药的代谢副作用 + 吸烟率高 + 就医不足共同造成）；

- **意外、暴力、社会因素**：相对次要但存在。

【临床共识】这意味着治疗精神分裂症，不只是"管住幻觉妄想"，还包括管理体重、血糖、血脂、吸烟、运动、抑郁情绪和自杀风险。

3.5 城乡、地区与社会差异

【研究结论】流行病学观察到一些有意义的相关性，但都不能简单归因为单一因素：

- **城市生活与移民**：多项跨国研究一致发现，**在大城市长期生活、以及从农村/发展中国家移民到发达国家的少数族裔群体**，精神分裂症（及精神病性障碍）的发病率偏高。可能的解释包括社会逆境、歧视、社会隔离、长期压力、城市空气污染等，但具体机制尚未完全阐明。
- **社会阶层**：与低社会经济地位存在相关性，但方向上更可能是"疾病导致社会下滑（social drift）"，而非"贫穷直接导致患病"。
- **季节与出生季节**：部分研究发现冬季/早春出生者风险略高，与孕期感染、维生素 D 缺乏等假说相关，但效应量很小。
- **城乡医疗可及性差异**：在中国，农村和偏远地区的精神卫生资源严重不足，就诊率、规范治疗率明显低于城市，这是公共卫生层面的重要问题。

3.6 数字之外：一个重要提醒

> 流行病学数字描述的是**一群人**的概率分布，不是**某一个具体的人**的判决书。某人有家族史、某人起病年龄落在高峰区间，都不意味着"一定会复发、一定会残疾"。规范治疗、家庭支持、早期干预，可以显著改善个体的预后轨迹。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. **Global, regional, and national burden of mental disorders in 204 countries and territories.** *Lancet Psychiatry*. 2022. doi:10.1016/S2215-0366(22)00228-200228-2)
- McGrath J, Saha S, Chant D, Welham J. **Schizophrenia: a concise overview of incidence, prevalence, and mortality.** *Epidemiologic Reviews*. 2008;30:67–76. doi:10.1093/epirev/mxn004
- Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. **Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study (CMHS).** *Lancet Psychiatry*. 2019;6(3):211–224. doi:10.1016/S2215-0366(18)30511-X30511-X)
- Leucht S, et al. **Maintenance treatment with antipsychotic drugs for schizophrenia.** *Cochrane Database Syst Rev*. 2020. PMID:32840872
- StatPearls. **Schizophrenia.** NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539864/

4. 疾病分型演变

> **核心结论：**精神分裂症过去按"主要症状"被划分为偏执型、青春型、紧张型等几个经典亚型；但 DSM-5（2013）和 ICD-11（2018）先后**取消了这种传统亚型划分**，因为研究发现亚型之间界限模糊、稳定性差、对治疗和预后的指导价值有限。现代临床改为用"症状维度 + 病程描述 + 严重程度标注"来刻画患者。

4.1 旧版分类中的传统亚型

【临床共识】在 ICD-10（1990）和 DSM-IV（1994）时代，教科书和病历常用以下亚型。它们至今仍能在旧文献、老病历和部分医生的口头描述中听到：

传统亚型	主要特征	大致预后倾向
偏执型（Paranoid type）	以妄想和幻觉为主，妄想内容常为被害、关系、嫉妒、夸大；思维形式和情感相对保留；起病较晚	相对较好，是最常见的亚型
青春型 / 紊乱型（Hebephrenic / Disorganized type）	思维破裂、言语杂乱、情感肤浅或不协调、行为幼稚愚蠢；起病多在青少年期	相对较差
紧张型（Catatonic type）	以动作行为异常为突出表现：可以是木僵（长时间不动、不言不语）、蜡样屈曲，也可以是兴奋躁动、刻板动作、模仿言语	波动大，部分可急性缓解
单纯型（Simple type / Simple schizophrenia）	缓慢起病、逐渐出现孤僻、懒散、社交退缩，**没有明显的幻觉妄想**，容易被当成"懒""不上进"	起病隐袭、发现晚、预后较差
未分化型（Undifferentiated type）	同时具备多型症状、无法归入上述任何一型	视具体症状组合而定
残留型（Residual type）	急性阳性症状缓解后，仍持续有轻度阴性症状或不典型妄想/幻觉	描述的是病程阶段，而非独立疾病

【临床共识】需要强调：这些亚型描述的是**某个时间点上的症状组合**，不是贴上去就一辈子不变的标签。

4.2 为什么 DSM-5 和 ICD-11 取消了传统亚型

【研究结论】过去 20 多年的临床随访研究发现，传统亚型存在几个根本问题：

1. **亚型之间边界模糊、重叠严重**：很多患者既像偏执型又带紊乱型表现，医生之间一致性（诊断一致性 κ 值）不高。
2. **纵向稳定性差**：同一个患者，今年诊断"偏执型"，明年症状变化后可能变成"未分化型"，几年后又成"残留型"——亚型随时间漂移，不像一个稳定的"疾病实体"。
3. **治疗指导价值有限**：不同亚型对同一种抗精神病药的反应并没有显著差别，按亚型选药的依据不足。
4. **"单纯型"等亚型的诊断标准可靠性差**，容易把抑郁症、人格障碍、孤独谱系障碍等误纳进来。

【临床共识】基于以上证据，**DSM-5（2013）正式删除了偏执型、青春型、紧张型、未分化型、残留型等传统亚型的正式编码**；ICD-11（2018）也采取了类似立场，不再把这些亚型作为独立分类。

4.3 现代分类如何描述患者：维度 + 病程 + 标注符

【临床共识】取而代之的，是一种更"立体"的描述方式：

- **按症状维度评分**：分别评估阳性症状、阴性症状、认知损害、抑郁/躁狂等心境症状、攻击敌意等，而不是给患者贴一个单一"型"的标签。
- **按病程描述**：首次发作、发作期 / 部分缓解 / 完全缓解；发作次数（单次发作、反复发作、持续状态等）。ICD-11 明确允许在 6A20 诊断后附加这些病程标注。
- **严重程度标注**：用轻度、中度、重度，或用量表（如 PANSS）量化。
- **标注符（Specifiers）**：用于提示有临床意义的特殊特征，例如"伴紧张症""伴焦虑""伴抑郁"等。

4.4 紧张症（Catatonia）的新处理

【研究结论】紧张症是一个比较特殊的概念。在传统分类里它是精神分裂症的一个亚型；现代观点则认为：

- 紧张症**不是精神分裂症独有**——它可以出现在重度抑郁、双相情感障碍、神经系统疾病、药物/物质反应中；
- 因此 **DSM-5 不再把紧张症作为精神分裂症的一个亚型，而是作为一个"标注符"**：可以附加在精神分裂症、双相障碍、重性抑郁障碍等多种诊断之后，写作"伴紧张症"；
- 治疗上，紧张症对苯二氮䓬类药物和 MECT（无抽搐电休克）反应常较好，识别它本身有治疗学意义。

【临床共识】这一调整的精神是：**先识别临床现象（紧张症），再判断它出现在哪种疾病背景下**，而不是反过来说"紧张症 = 精神分裂症的一型"。

4.5 临床实际中如何"描述"一位患者

【临床共识】既然不再有"型"，医生在病历里通常这样描述一位患者，更准确也更有用：

> "患者为首次发作，目前处于急性期，以妄想（被跟踪、被监视）和评论性幻听为主要表现，伴轻度情感淡漠和社交退缩，无明显冲动伤人行为；PANSS 评分示阳性症状重度、阴性症状中度；病程约 3 个月，既往无类似发作。"

这种描述方式包含了：**病程阶段 + 主导症状 + 严重程度 + 安全风险 + 既往史**，比单纯一句"偏执型精神分裂症"信息量大得多，也更能指导治疗。

4.6 给读者的提示

- 老病历、老文献里看到"偏执型""青春型"不必紧张，那是旧时代的语言；
- 听到医生不再说"你是哪一型"，不是"没诊断清楚"，而是现代分类本来就不这么分了；
- 关心的重点应该从"我是哪一型"转向"**我现在的症状维度有哪些、严重到什么程度、下一步治疗目标是什么**"。

参考来源

- American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR).** Washington, DC: APA, 2022. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 世界卫生组织：ICD-11 6A20 Schizophrenia
- Heckers S, Barch DM, et al. **Structure of the psychotic disorders classification in DSM-5.** *Schizophrenia Research*. 2013;150(1):11–16. doi:10.1016/j.schres.2013.04.039
- Tandon R, Gaebel W, Barch DM, et al. **Definition and description of schizophrenia in the DSM-5.** *Schizophrenia Research*. 2013;150(1):3–10. doi:10.1016/j.schres.2013.05.028
- 中华医学会精神医学分会. 中国精神分裂症防治指南（第二版）. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015.

5. 常见名词释义

> **核心结论：**本页把阅读精神分裂症相关资料时最常遇到的术语集中解释一遍。需要强调：**这些词是用来描述现象和病程阶段的工具，不是贴在患者身上的标签**；量表、分期、副作用术语都不能代替精神科医生的完整评估。

5.1 核心症状术语对照表

【临床共识】下表是最常被混淆的一组词：

术语	简明释义	容易误解的地方
阳性症状	相对于正常心理体验"多出来"的异常内容，如幻觉、妄想、思维紊乱、行为紊乱	"阳性"不是"好"，只是"出现了不该有的体验"
阴性症状	正常心理功能"减退或缺失"，如情感淡漠、意志减退、言语贫乏、社交退缩、快感缺失	"阴性"不是"消极"，而是"原本有的能力减弱了"；常被家人误以为"懒、不上进"
认知症状	注意力、工作记忆、信息处理速度、执行功能（计划/判断/抑制）等信息加工能力下降	常不被外人察觉，却是影响学业、职业的核心原因
精神病性症状	一组"现实检验能力受损"的症状总称，包括幻觉、妄想、明显思维紊乱、行为紊乱	不是只有精神分裂症才有；双相躁狂、重度抑郁、毒品中毒也可出现
现实检验能力	一个人区分"内心主观体验"和"外部客观现实"的能力	急性期受损时，患者真心相信幻听是真的、妄想是铁一般的事实，并非故意说谎
自知力（洞察力）	患者对自己疾病的认识和判断能力——是否承认自己病了、是否认识到症状是病态的	自知力缺乏是急性期常见表现，不等于"故意对抗"；随治疗好转可逐步恢复
依从性（遵医嘱性）	患者按医嘱服药、复诊、配合治疗的程度	依从性差常与副作用、病耻感、对疾病不认可有关，不能简单归因于"不听话"

5.2 幻觉与妄想：阳性症状的两大支柱

【临床共识】

- **幻觉**：在没有相应客观刺激时出现的类似感知体验。最常见的是**幻听**（听到声音），也可有幻视、幻嗅、幻味、幻触。精神分裂症的幻听常为**评论性幻听**（声音在评论患者的一举一动）或**命令性幻听**（命令患者做某事）——后者涉及安全风险，需认真对待。
- **妄想**：在客观证据充分相反的情况下，患者仍坚信不疑、且与其文化/宗教背景不符的错误信念。常见主题：
- **被害妄想**：坚信被跟踪、监视、下毒、迫害；
- **关系妄想**：把电视、新闻、路人的言行都觉得是针对自己；
- **夸大妄想**：坚信自己有超凡能力、特殊身份；
- **钟情妄想**：坚信某名人深深爱着自己；
- **被控制感 / 思维插入 / 思维被广播**：感到自己的思想、行为被外力控制。
- **注意**：不能因为一个信念听起来"奇怪"就断定是妄想，必须结合文化背景、证据强度和患者是否能被说服来判断。

5.3 病程分期术语

【临床共识】医生和家属沟通时，常按疾病进程把时间线分成几段：

阶段	大致时间窗	主要特征	处理重点
前驱期	首次明显发作前数月至数年	睡眠变差、社交退缩、学习/工作效率下降、敏感多疑、情绪波动；表现很不特异	早期识别、专业评估；但**不能仅凭自我观察贴"前驱期"标签**
急性期 / 发作期	首次或再次症状明显加重	幻觉、妄想、行为紊乱突出，现实检验能力受损，自知力常缺失	尽快就医、药物控制、必要时住院
巩固期	急性症状控制后约 3–6 个月	症状逐步减轻，但仍可能残留；易波动	继续治疗、密切随访、防复发
维持期	症状稳定后长期	阳性症状基本消失，可能仍有阴性症状和认知损害	坚持服药、康复训练、回归社会
缓解期	部分或大部分症状在一段时间内减轻	症状减轻 ≠ 完全痊愈；不代表可以自行停药	与医生共同讨论是否调整治疗
残留状态	急性发作缓解后仍残留部分症状	旧版分类用语，指残留的轻度阴性症状或不典型阳性症状	描述临床状态，不意味着"没希望"

【临床共识】分期是为了指导治疗节奏，不是机械的时间表；个体之间差异很大。

5.4 治疗相关术语

【临床共识】家属和患者最常听到的一组治疗名词：

术语	简明释义
抗精神病药	治疗精神病性症状的核心药物，分第一代（典型，如氯丙嗪、氟哌啶醇）和第二代（非典型，如利培酮、奥氮平、喹硫平、阿立哌唑等，目前作为一线选择）
锥体外系反应（EPS）	抗精神病药（尤其第一代）常见的神经系统副作用：震颤、肌肉僵硬、静坐不能（坐不住）、急性肌张力障碍（脖子歪、眼睛上翻）；长期可出现迟发性运动障碍（不自主咂嘴、吐舌）
泌乳素升高	部分第二代药（如利培酮、帕利哌酮）可升高泌乳素，导致女性月经紊乱、泌乳，男性乳房发育、性功能下降

术语	简明释义
代谢副作用	奥氮平、氯氮平等可引起体重增加、血糖升高、血脂异常，是长期管理的重点
长效针剂（LAI）	每月或每数月注射一次的抗精神病药制剂，血药浓度平稳，**特别适合漏服、依从性差的患者**，可显著降低复发率
MECT（无抽搐电休克治疗）	在麻醉和肌松下，通过短暂诱发脑放电来快速控制严重精神病性症状、抑郁木僵、强烈自杀意念；不是"电刑"，是现代麻醉下的安全治疗
CBTp	针对精神病性症状的认知行为治疗，作为药物之外的辅助康复手段，**不能替代药物治愈急性发作**

5.5 其他高频术语

术语	简明释义
病耻感（Stigma）	社会对精神疾病患者的偏见、歧视和回避，也包括患者内化的羞耻感；它比疾病本身更阻碍就医和回归社会
高情感表达（EE）	家庭环境中过高的批评、敌意、过度情感卷入；高 EE 环境与较高复发率相关，是家庭干预的重要靶点
社会功能	一个人完成自我照料、家庭生活、学习、工作、人际交往和社会参与的能力；是比"症状是否消失"更重要的长期预后指标
复发预警信号	再次发作前常先出现的细微变化：睡眠变差、多疑加重、社交退缩、情绪反常、旧症状复现等；早识别可早干预
DALY	伤残调整生命年，衡量疾病负担的国际通用指标，等于"早亡损失的健康年数 + 带病生存损失的健康年数"

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- American Psychiatric Association：Schizophrenia: Symptoms and Diagnosis
- 中华医学会精神医学分会. 中国精神分裂症防治指南（第二版）. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015.
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet.* 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）, 2024

1. 遗传因素

> **核心结论：**遗传因素确实参与精神分裂症的发病，家族中有患者会显著提高亲属的群体患病概率；但它是**多基因、概率性**的，**绝不是"父母有、孩子就一定得"**。基因检测目前**不能用于确诊或预测**精神分裂症，相关研究仍在前沿阶段。

1.1 家族聚集：风险随亲缘关系变化

【研究结论】大量家系研究反复证实，精神分裂症患者的生物学亲属，患病风险显著高于普通人群；亲缘关系越近，群体平均风险越高。下表是经典文献中常被引用的风险估计：

与患者的关系	群体平均终生患病风险（约）	与普通人群的对比
普通人群（无家族史）	约 1%	基线
二级亲属（姑、舅、祖父母等）	约 3%–5%	3–5 倍
一级亲属（父母、子女、兄弟姐妹）	**约 10%**	**约 10 倍**
异卵双生子（DZ）	约 10%–17%	与同胞相近
同卵双生子（MZ）	**约 40%–50%**	**约 40–50 倍**
父母双方均患精神分裂症	子女约 40%–50%	约 40 倍

【临床共识】这组数字说明了三件事：

1. **遗传有作用**：风险确实随亲缘远近而升高；
2. **但远非"注定"**：即使是同卵双生子（基因 100% 相同），一致率也只有 40%–50%，意味着约一半情况下一个患病、另一个不患病；
3. **家族史 ≠ 诊断**：这些是群体平均概率，不能直接换算成某个具体家庭成员"一定会得病"。

1.2 双生子研究：遗传与环境的"天然实验"

【研究结论】双生子研究通过比较同卵双生子（MZ，共享约 100% 基因）和异卵双生子（DZ，平均共享约 50% 分离出来的基因）的同病率，来估算遗传的贡献：

- 如果 MZ 同病率显著高于 DZ，说明遗传因素起作用；
- 但 MZ 同病率不是 100%，又说明**环境因素（包括孕期环境、生活经历、物质使用、意外事件等）同样重要。**

综合多项大型双生子研究的 meta 分析，精神分裂症的**遗传度（heritability）估计约为 70%–80%。**这个数字常被误读为"70%–80% 是基因决定的"。

【争议观点】更准确的理解是：**在被研究的这群人群中，人与人之间患病差异的约 70%–80% 可以归因于遗传差异**——这是一个群体层面的方差解释比例，不是说某个人的病有 70% 由基因决定、30% 由环境决定。对具体个人而言，基因和环境是交织在一起、无法简单切分的。

1.3 多基因遗传：没有一个"精神分裂症基因"

【研究结论】早期研究者曾期待找到一两个主效基因，但全基因组关联研究（GWAS）的结果彻底改变了这一图景：

- **常见变异的微效累加**：2014 年、2019 年、2022 年大型 GWAS（如 Psychiatric Genomics Consortium）先后识别出数百个与精神分裂症相关的基因位点，**每一个常见变异本身只带来非常微小的风险增加**（OR 多在 1.01–1.10 之间）。
- **多基因风险评分（PRS）**：把成千上万个常见变异的效应加权求和，可以得到一个人在群体中的"遗传风险相对位置"。PRS 在群体层面与患病风险有相关性，但**对个体的预测能力还很弱**——区分度（AUC）远达不到临床诊断或筛查的要求。
- **生物学通路**：GWAS 信号富集在**突触功能、谷氨酸能传递、NMDAR 复合物、钙通道、染色体 6p 的主要组织相容性复合体（MHC）**等通路上，提示突触可塑性和免疫相关过程可能参与发病。

【临床共识】PRS 目前**仅用于研究，不能用于临床咨询、生育决策或个体患病预测。**消费级基因检测公司（如某些商业测序服务）报告的"精神分裂症风险"，由于样本偏差、群体代表性不足和算法局限，解读价值非常有限，不建议据此做重大人生决定。

1.4 罕见、但效应较大的遗传变异（CNV）

【研究结论】除了大量常见微效变异，还有一类罕见但效应较大的基因组结构变异，称为**拷贝数变异（Copy Number Variation, CNV）**——即染色体上某一段 DNA 发生了缺失或重复：

罕见 CNV	在精神分裂症患者中的频率（约）	效应特点
22q11.2 缺失（DiGeorge 综合征）	约 1%–2%	是已知效应较大的风险 CNV；患者中约 25%–30% 发展为精神分裂症
1q21.1 缺失/重复	约 0.5%	也与孤独症、智力障碍相关
15q13.3 缺失	约 0.3%–0.5%	与多种神经发育障碍共享
NRXN1 缺失	约 0.5%–1%	突触黏附分子相关
末端 2p16.3（NRXN1）、17p12 等	<1%	同样与神经发育障碍交叉

【临床共识】这些 CNV 在普通人群中极罕见，但一旦携带，患病风险可上升数倍至数十倍。它们多数不是精神分裂症"独有"，而是**横跨精神分裂症、孤独症、双相障碍、智力障碍、注意缺陷多动障碍的共同遗传风险因素。**

1.5 基因与环境的交互："二次打击"模型

【研究结论】现代观点普遍认为，精神分裂症不是单纯由基因或单纯由环境造成，而是**遗传易感性 × 环境触发**的交互结果：

- 遗传决定了一个人"神经系统的敏感性基线"；
- 孕期感染、产科并发症、童年创伤、长期压力、大麻使用、城市生活等环境因素，在特定发育阶段"叠加"在易感性之上；
- 只有当易感性和环境暴露都达到一定程度，才可能表现出临床疾病。

这就是著名的"**二次打击（two-hit）**"或"素质—应激（diathesis-stress）"模型。它解释了为什么：

- 同卵双生子一个患病、另一个不患病；
- 有家族史的人多数并不发病；
- 没有家族史的人（约 2/3 患者的一级亲属其实并不患病）也可能患病。

1.6 给患者与家属的实际提示

【临床共识】

1. **不要互相归咎**：患病不是父母"遗传坏基因"的错，也不是患者本人"作"出来的；它是多因素交织的结果。
2. **不要因为有家族史就过度恐慌**：一级亲属 10% 的风险意味着**约 90% 的兄弟姐妹、子女并不会发展成精神分裂症。**
3. **也不要因此轻视**：有家族史的人，更应注意规律作息、避免大麻等物质滥用、学会压力管理、出现早期变化时早就医。
4. **基因检测不能确诊**：目前没有任何一种常规临床基因检测可以诊断或排除精神分裂症；如果医生建议做遗传咨询，那通常是为了排查 22q11.2 等明确综合征，而不是为了"预测会不会得病"。
5. **生育决策请个体化咨询**：是否生育、如何生育，应由患者/家属与精神科医生、遗传咨询师共同讨论，避免在恐慌中做出决定。

参考来源

- Trubetskoy V, et al. **Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia.** *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- Sullivan PF, Kendler KS, Neale MC. **Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies.** *Archives of General Psychiatry*. 2003;60(12):1187–1192. doi:10.1001/archpsyc.60.12.1187
- Sculley LD, et al. **Promising directions in polygenic risk score research for schizophrenia.** *World Psychiatry*. 2023.（PRS 临床转化局限综述）
- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单

2. 大脑生物学机制

> **核心结论：**精神分裂症不是"想出来的病"，它背后有可观测的大脑生物学异常。目前证据最充分的几条线索是：**多巴胺调节异常、谷氨酸 NMDA 受体功能低下、脑结构与连接的发育性改变。**但这些都是"机制假说"，**没有任何一种血液指标、脑影像或神经递质检测可以用来确诊**精神分裂症。

2.1 多巴胺假说：最经典、也最常被误解的模型

【研究结论】多巴胺假说的形成，主要来自两条相互印证的临床观察：

1. **抗精神病药的作用**：几乎所有第一代抗精神病药（如氯丙嗪、氟哌啶醇）的疗效强度，与它们对**多巴胺 D2 受体的阻断能力**高度相关；D2 阻断越强，控制幻觉妄想效果通常越好。
2. **多巴胺释放增多的观察**：正电子发射断层扫描（PET）研究发现，部分患者在纹状体区域的多巴胺合成与释放调节存在异常。

现代版本的多巴胺假说（Howes & Kapur, 2009 的"第三版"）将其细化为通路特异性模型：

脑区通路	多巴胺功能	与症状的关系
中脑—边缘通路（mesolimbic）	D2 功能**亢进**	与**阳性症状**（幻觉、妄想）相关；抗精神病药 D2 阻断主要作用于此
中脑—皮层通路（mesocortical）	D1 功能**低下**	与**阴性症状和认知损害**相关——这也是为什么单纯阻断 D2 常常不能改善阴性症状
黑质—纹状体通路	D2 阻断过度	引起**锥体外系副作用**（震颤、僵硬、静坐不能）
结节—漏斗通路	D2 阻断	引起**泌乳素升高**

【临床共识】**这绝不是"全脑多巴胺太多"这么简单。** 不同脑区、不同通路的变化方向并不一致；多巴胺模型能较好解释阳性症状，却难以解释阴性症状、认知损害和疾病的全部病程。把精神分裂症说成"多巴胺过多的病"是过度简化。

2.2 谷氨酸假说：NMDA 受体功能低下

【研究结论】第二条重要线索来自致幻药物的"反向实验"：

- **苯环己哌啶（PCP）** 和 **氯胺酮（Ketamine）** 是 NMDA（N-甲基-D-天冬氨酸）受体的非竞争性拮抗剂。
- 给健康人使用亚麻醉剂量的氯胺酮/PCP，可以**诱发类似精神分裂症的表现**：阳性症状（类妄想、幻觉）、阴性症状（情感淡漠、退缩）和认知损害。
- 这一观察直接提示：**NMDA 受体功能低下**可能参与精神分裂症的病理过程。

谷氨酸假说进一步提出：NMDA 受体功能低下，会通过 GABA 能中间神经元的去抑制，引起下游多巴胺、谷氨酸系统的连锁失调，最终导致皮层—边缘网络的信息处理紊乱。它在解释"为什么单纯阻断 D2 对阴性症状和认知效果差"方面，比多巴胺假说更有优势。

【争议观点】目前基于 NMDA 调节剂（如甘氨酸、D-丝氨酸、促谷氨酸释放药物）的临床试验，疗效结果并不一致，谷氨酸假说仍处于完善阶段，尚未转化为常规临床用药。

2.3 GABA、5-羟色胺与其他神经递质

【研究结论】

- **GABA（γ-氨基丁酸）**：作为脑内主要的抑制性神经递质，GABA 能中间神经元（尤其是表达小白蛋白 PV 的那一类）被发现在精神分裂症患者前额叶和海马中数量/功能异常，可能是皮层环路兴奋—抑制失衡的关键环节。
- **5-羟色胺（血清素，5-HT）**：第二代非典型抗精神病药（如氯氮平、利培酮）同时作用于 5-HT2A 和 D2 受体；5-HT 系统可能与阴性症状、认知、睡眠和情绪调节有关。
- **乙酰胆碱、神经肽、神经营养因子（BDNF）**：也在研究中，提示突触可塑性、神经发育过程异常。

【临床共识】这些系统不是互相排斥的"答案"，而是**相互交织的网络。**

2.4 脑结构与功能影像发现

【研究结论】过去 30 年的结构 MRI、功能 MRI 研究，在**群体层面**反复报告了以下平均差异：

影像发现	一致性	备注
侧脑室扩大	较一致	反映脑实质容积相对减少
海马体积减小	较一致	左右海马均可受累
前额叶灰质体积减少	较一致	与认知、阴性症状相关
丘脑体积减小、皮层变薄	中等	多项 meta 分析支持
默认网络、突显网络、中央执行网络连接异常	中等	反映大尺度脑网络通讯异常
皮层下结构（纹状体）变化	有争议	部分变化可能被药物影响

【临床共识】必须强调三点：

1. 这些是**群体平均差异**，个体之间重叠巨大——把某个具体人的脑片拿给医生看，**无法据此诊断或排除精神分裂症**；
2. 影像差异可能被病程、药物、吸烟、共病、住院时间等多重因素混淆；
3. 目前脑影像**不能用于临床诊断**，仅用于研究和鉴别诊断（排除脑肿瘤、卒中、脑炎等器质性问题）。

2.5 神经发育假说

【研究结论】把上述遗传和影像线索整合起来，**神经发育假说（neurodevelopmental hypothesis）**认为：

- 遗传易感性叠加孕期/围产期不良事件（感染、缺氧、营养不良等），影响了胎儿期神经元迁移、突触形成和环路搭建；
- 这些早期改变在童年和青春期可能表现得很轻微（学习困难、社交笨拙、轻微运动协调差）；
- 到了青春期，大脑突触修剪加速、多巴胺系统重塑、激素水平剧变，原本"潜伏"的发育异常在这一阶段显现为明显的精神病性症状。

这一假说很好地解释了"为什么高发年龄在青少年晚期到成年早期"，也解释了前驱期微妙变化的来源。

2.6 神经炎症与免疫假说

【争议观点】较新的研究方向：

- 部分患者存在轻度外周炎症指标（如 C 反应蛋白、IL-6）升高；
- GWAS 信号富集在 MHC（6p22–6p21）区域，与免疫相关；
- 孕期母亲感染（流感、风疹、弓形虫等）与后代患病风险轻度升高相关；
- 小胶质细胞（脑内免疫细胞）活化异常、突触修剪过度，被认为可能参与突触丢失。

但神经炎症假说目前证据强度中等，**抗炎治疗（如米诺环素、COX-2 抑制剂）作为辅助用药的临床试验结果不一致**，尚未成为常规推荐。

2.7 重要边界：机制 ≠ 诊断

【临床共识】读完这一页，请记住：

> 多巴胺假说、谷氨酸假说、神经发育假说、神经炎症假说，都是**用来理解疾病、研发药物的研究框架**，而不是贴在某个具体患者身上的"病因标签"。临床上**没有任何一项抽血、基因、脑影像检查**可以确诊精神分裂症；诊断依然靠精神科医生对症状、病程、功能损害的综合判断。

参考来源

- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- Howes OD, Kapur S. **The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway.** *Schizophrenia Bulletin*. 2009;35(3):549–562. doi:10.1093/schbul/sbp006
- Moghaddam B, Javitt D. **Revolution in glutamate circuit for schizophrenia.** *Nature Reviews Neuroscience*. 2012;13:42–57. doi:10.1038/nrn3137
- van Os J, Kapur S. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2009;374(9690):635–645. doi:10.1016/S0140-6736(09)60995-860995-8)
- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单

3. 环境诱因

> **核心结论：**精神分裂症的"因"在基因里，但"何时发病、以多重程度发病"很大程度上受环境因素调节。孕期与围产期风险、童年创伤、长期社会逆境、物质滥用（尤其青少年期高频使用高效能大麻）、重大应激事件，都是**已被研究证实的风险因素或触发因素**。环境因素不决定发病，但会与遗传易感性交互，构成"二次打击"。

3.1 孕期与围产期风险

【研究结论】流行病学队列研究发现，以下孕期/出生时期的暴露，与后代患精神分裂症的风险轻度升高相关：

暴露因素	风险升高幅度（约）	可能机制
孕期母亲感染（流感、风疹、弓形虫等）	约 1.5–3 倍	母体炎症因子影响胎儿神经发育
孕期营养不良（如饥荒暴露）	约 1.5–2 倍	胎儿脑发育关键期营养不足
孕期母亲妊娠期糖尿病、高血压	轻度升高	胎盘功能、宫内环境异常
产科并发症 / 出生缺氧	约 2 倍	围产期脑损伤
父亲高龄（≥45 岁生育）	约 1.5–2 倍	精子新生突变随父亲年龄累积
冬季/早春出生	轻度（约 1.05–1.1）	与季节性感染、维生素 D 缺乏相关

【临床共识】需要强调：

- 这些都是**群体层面的相关性**，效应量普遍较小；
- 即使暴露了这些因素，**绝大多数后代并不会发展为精神分裂症**；
- 它们是"风险背景"，不是"病因判决"。

3.2 童年创伤与逆境

【研究结论】大量回顾性和前瞻性研究一致发现，精神分裂症患者童年期经历以下创伤的比例显著高于一般人群：

- 躯体虐待、情感虐待、性虐待；
- 长期忽视、家庭暴力、父母离异或丧失；
- 校园霸凌、同伴长期孤立。

剂量—反应关系明显：**创伤越严重、持续越久、发生越早，患病风险越高。**可能机制包括：长期应激导致下丘脑—垂体—肾上腺（HPA）轴调节异常、慢性炎症、海马体积缩小、情绪调节环路发育受损。

【临床共识】这一发现再次说明：**早年环境不是"小事"**，但童年创伤也不必然导致精神分裂症——它提高的是风险概率，且保护因素（至少有一个稳定、温暖的照料者）可以显著缓冲。

3.3 长期高压、社会逆境与移民/城市效应

【研究结论】

- **社会逆境与移民**：跨国研究反复发现，**从发展中国家/少数族裔背景移民到发达国家的群体**，患精神分裂症的风险是当地出生人群的 2–4 倍，第二代移民风险更高。城市出生、城市长大的人风险也高于农村。
- **可能机制**：长期遭受歧视、社会隔离、归属感缺失、经济压力、城市生活的慢性感觉负荷等，被认为通过慢性应激和社会孤立通路起作用。
- **社会因果 vs 社会漂移**：低社会经济地位与精神病性障碍相关，但方向上更可能是"疾病导致社会下滑"（social drift）与"社会逆境提高风险"（social causation）并存。

【争议观点】城市效应究竟是由空气污染、昼夜节律紊乱、社会密度、还是社会经济混杂引起，目前没有定论。

3.4 物质滥用：大麻是最明确的高危因素

【临床共识】在所有可能诱发或加重精神病性障碍的物质中，**大麻是研究最充分、证据最一致的高危因素**：

物质	与精神病性障碍的关系	关键证据
大麻（尤其高效能、青少年期高频使用）	**已被多项前瞻队列研究证实为风险因素**	15 岁前开始高频使用，成年后患精神病性障碍风险可升高约 2–4 倍；剂量—反应关系明确
苯丙胺类（冰毒、安非他命）	可诱发、加重精神病性症状	中毒性谵妄和"苯丙胺精神病"
可卡因	类似兴奋剂效应	可诱发偏执状态
致幻剂（LSD、裸盖菇素）	可能触发易感个体首发精神病	长期使用与感知障碍相关
酒精	不是直接病因，但**戒断**和**长期酗酒**可伴精神病性症状	也加重疾病管理难度
合成卡西酮（"浴盐"等）	与严重兴奋、精神病性症状相关	毒性更强

【临床共识】

- **青少年大脑仍在发育**，这一时期高频使用高效能大麻（THC 含量高），对多巴胺系统和前额叶发育的影响最大；
- 物质滥用既可能是**触发首发**的环境因素，也会**显著增加复发率**；
- 对已有精神分裂症遗传易感性或前驱期迹象的人，**避免大麻和兴奋剂是明确的保护性措施。**

3.5 重大应激事件作为"扳机"

【研究结论】重大生活事件（丧亲、失恋、失业、重大羞辱、意外伤害、被欺凌、卷入暴力事件等）常出现在首次发作前数周到数月。它们更像是**"压垮骆驼的最后一根稻草"**——在已有神经发育易感性和累积环境暴露的基础上，触发了临床症状的显现。

【临床共识】但要注意：

- 应激事件**不能单独解释**为什么一个人会得精神分裂症；
- 把发病简单归因为"那次失恋"或"那次被骂"，是对疾病多因素本质的误解；
- 应激在复发阶段同样是触发因素，这也是为什么压力管理是长期康复的一部分。

3.6 "二次打击"模型：环境如何与基因交互

【临床共识】把前面所有线索整合起来，最被广泛接受的模型是"**素质—应激 / 二次打击**"：

1. **第一次打击**：遗传易感性 + 孕期/围产期不良事件，造成大脑发育的"易感基线"；
2. **第二次打击**：青春期激素剧变 + 童年创伤 + 慢性社会逆境 + 物质滥用 + 重大应激，叠加在已易感的大脑上，最终在成年早期表现出临床疾病。

这一模型解释了为什么：

- 同卵双生子并非 100% 同病；
- 没有家族史的人也可能患病；
- 早期干预、减少物质滥用、提供社会支持可以改善预后。

3.7 实际启示

【临床共识】

1. **对普通人**：避免青少年期高频使用大麻和兴奋剂，是已知最可操作的保护因素之一；
2. **对有家族史/早期迹象的人**：规律作息、避免长期高压、学会压力管理、维护至少一段稳定支持性关系；
3. **对已经患病的人**：戒酒、戒大麻、戒兴奋剂，是预防复发的基础措施；
4. **对家属**：理解环境因素的作用，不等于"怪环境"或"怪家属"——这些因素绝大多数是家庭无法完全控制的。

参考来源

| 参考来源 |

| --- |

| Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet.* 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6) |

| van Os J, Linscott RJ, Myin-Germeys I, et al. **A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum.** *Psychological Medicine.* 2009;39(3):341–356. doi:10.1017/S0033291708003814 |

| Marconi A, Di Forti M, Lewis CM, et al. **Meta-analysis of the association between cannabis use and schizophrenia.** *Schizophrenia Bulletin.* 2016;42(5):1262–1270. doi:10.1093/schbul/sbw013 |

| 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单 |

| 中华医学会精神医学分会. 中国精神分裂症防治指南（第二版）. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015. |

4. 心理社会因素

> **核心结论：**长期压力、家庭高情感表达、重大生活事件、社会隔离等心理社会因素，可以作为**诱因或复发触发因素**，但**它们不是精神分裂症的根本病因。**必须坚决纠正"想不开、心眼小、性格差才得病"这种污名化叙事。情绪冲突和家庭关系会影响病程，但疾病本身是大脑疾病，不是"心理脆弱"的结果。

4.1 心理社会因素在疾病中的位置

【临床共识】先把定位说清楚：

因素类型	在发病中的角色	举例
生物学病因（遗传、神经发育、神经递质）	**根本基础**——没有它们，疾病很难发生	多基因风险、22q11.2 缺失、神经发育异常
环境触发因素（孕期感染、产科并发症、大麻、移民逆境）	**触发/加速**——决定何时发病、病情多重	青少年期高频大麻、童年创伤
心理社会因素（长期压力、家庭关系、生活事件）	**调节病程、影响复发**——不是根本病因，但显著影响预后	家庭高 EE、失业、社会隔离

把心理社会因素放在"诱因/调节因素"这一层，既不否认它们的作用，也不把责任错误地推到患者或家庭身上。

4.2 哪些心理社会因素与发病/复发相关

【研究结论】

1. **长期慢性压力**：长期失业、经济困境、亲密关系冲突、照护负担、歧视等，通过 HPA 轴和慢性炎症通路影响大脑。
2. **家庭高情感表达（Expressed Emotion, EE）**：这是被研究最充分的心理社会变量之一。高 EE 家庭的特征是：

- **高度批评**：频繁指责、挑剔、否定患者；
- **敌意**：把患者症状当作"故意作对"，表达愤怒和厌恶；
- **过度情感卷入**：过度保护、过分担忧、事事替患者决定。

经典研究显示，**高 EE 环境中生活的患者，1 年内复发率显著高于低 EE 环境**（可达 2 倍以上）。

1. **重大生活事件**：丧亲、失恋、失业、迁居、被欺凌、家庭冲突等，常出现在首次发作或复发前数周—数月。
2. **社会隔离与孤独**：缺乏可信赖的支持性关系，既是发病风险因素，也让复发后更难恢复。
3. **病耻感**：自我污名（"我是个疯子，没希望了"）会显著降低就医依从性和康复动机。

【临床共识】需要注意相关性方向：

- 是高 EE 导致复发？还是患者病情波动让家属变得紧张挑剔？
- 研究普遍认为**两者互相强化**，形成恶性循环——这也是家庭干预能打断这一循环的原因。

4.3 必须纠正的三个污名化误区

误区一："就是想不开、钻牛角尖、太敏感才得的病"

【临床共识】这是最常见、也最伤人的误解。精神分裂症有明确的生物学基础（遗传、神经发育、神经递质），**心理压力是"扳机"，不是"枪"。**一个人性格开朗、事业成功、家庭和睦，同样可能在某个阶段发病；反过来，一个人再怎么"想开"，也不可能靠意志力消除幻觉妄想。

误区二："都是父母教养方式不对，把孩子逼成这样"

【临床共识】这是历史上（尤其 20 世纪中期"精神分裂症源性母亲"假说）曾流行、但早已被现代精神医学彻底否定的说法。把病因归咎于母亲或家庭，曾给无数家庭带来深重的羞耻和自责。

- 家庭关系会**影响病程和复发率**，但**不是根本病因**；
- 患者在急性发作期的行为（退缩、易怒、多疑）本身也会让家庭关系紧张，这是疾病的结果，不是原因；
- **请不要互相归咎。**

误区三："性格外向的人不会得，内向/孤僻的人才会得"

【临床共识】这同样是过度简化。发病与性格类型没有决定性关系；病后出现的退缩、沉默，很多是**阴性症状本身**或药物镇静副作用，不是"本来就内向"。

4.4 情绪冲突与疾病的关系：一个平衡的看法

【临床共识】不否认心理因素的作用，但要准确：

- 强烈的情绪应激可以**诱发或加重**症状，尤其在易感个体；
- 长期处于高冲突、高批评的家庭环境，复发率更高；

- 但**一般的情绪波动、失恋、压力，不会让一个"普通人"得上精神分裂症**——否则这病就太常见了；
- 心理治疗（CBTp、家庭干预、社交技能训练）作为**药物基础上的辅助康复手段**有明确证据，但**单纯心理咨询不能治愈急性精神病发作。**

4.5 建设性沟通方向：把高 EE 变成低 EE

【研究结论】家庭干预的目标，不是让家属"什么都忍着"，而是把高 EE 沟通调整为更有利于康复的模式：

高 EE 沟通（不推荐）	低 EE 沟通（推荐方向）
"你怎么又不出门了？就是懒！"	"我注意到你这几天好像不太想出门，要不要聊聊？"
"你那些声音都是瞎想的，别理它就行。"	"你听到声音一定很害怕吧？我们一起想想怎么让它不那么吓人。"
"你什么时候才能像个正常人？"	"今天感觉比昨天好一点吗？我们一步一步来。"
事事替患者决定、过度保护	在尊重患者自主的前提下，提供可及的支持
频繁批评、翻旧账	具体、就事论事，关注当下和下一步

【临床共识】低 EE 沟通的核心是：**既不否认症状的真实性（在患者主观体验里，幻听就是真的），也不附和妄想内容；既表达关心，又不把全部生活绑在患者身上；既期待进步，又接受康复是缓慢波动的过程。**

4.6 给患者和家属的一句话

> 得了精神分裂症，**不是谁的错**——不是父母的错，不是配偶的错，不是患者本人"想不开"的错。它是一种有生物学基础的大脑疾病，心理社会因素会影响它的轨迹，但不是它的根。把力气从"互相追责"转到"一起面对疾病、一起管理压力"上，对康复更有帮助。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- Butzlaff RL, Hooley JM. **Expressed emotion and psychiatric relapse: a meta-analysis.** *Archives of General Psychiatry*. 1998;55(6):547–552. doi:10.1001/archpsyc.55.6.547
- Philips N, et al. **Pschoosocial interventions in schizophrenia.** *Lancet Psychiatry*. 2020.（家庭干预与社会心理康复综述）
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- 中华医学会精神医学分会. 中国精神分裂症防治指南（第二版）. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015.

5. 目前研究局限

> **总体结论：**精神分裂症的病因**尚未被完全破译**，目前没有任何一种单一因素被公认为"根本病因"。各条研究路线（遗传、多巴胺、谷氨酸、脑影像、神经炎症）证据强度不一，互相补充而非互相替代。**理性看待"科学突破"新闻**——动物模型与人类疾病有差距、患者群体高度异质、缺乏可靠生物标志物，是当前研究的三大瓶颈。

5.1 为什么我们还没找到"根本原因"

【临床共识】精神分裂症病因研究之所以困难，是因为它同时具备以下特点：

1. **多因素、多通路**：遗传、神经发育、神经递质、免疫、环境、心理社会因素共同参与，没有"单点故障"；
2. **异质性极强**：被诊断为"精神分裂症"的人，症状组合、病程、预后差异巨大——它可能不是"一种病"，而是"一组疾病的总称"；
3. **无法直接观察人脑病理**：多数研究靠活体影像、血液、行为表型推断，死后脑样本研究数量有限；
4. **不能在人身上做受控的"病因实验"**：很多环境因素只能靠观察性研究，因果推断困难。

5.2 各主要假说的证据强弱对比

【研究结论】下表把模块 2 提到的主要机制假说放在一起，做一个诚实的证据强度评估：

假说/方向	核心主张	支持证据	主要局限	临床转化现状
多巴胺假说	中脑边缘 D2 亢进 → 阳性症状	抗精神病药 D2 阻断疗效、PET 研究	不能解释阴性/认知症状；不是"全脑多巴胺过多"	**已转化**：所有一线抗精神病药均基于此
谷氨酸/NMDA 低下假说	NMDA 受体功能不足 → 多系统失调	PCP/氯胺酮拟精神病效应、GWAS 富集	辅助用药临床试验结果不一致	研究阶段，尚无常规临床药物
遗传（多基因 + CNV）	数百微效常见变异 + 少数大效应 CNV	大型 GWAS、双生子、家系研究	PRS 个体预测力弱；不能确诊	**仅研究用**；22q11.2 可临床排查
神经发育假说	早期发育异常 + 青春期显现	影像学、出生队列、前驱期研究	难以直接验证"发育轨迹"	指导早期干预思路
脑结构影像	脑室扩大、海马/前额叶灰质减少	多项 meta 分析一致	群体平均差异、个体重叠大、受药物/病程混淆	**不能用于诊断**
神经炎症/免疫假说	小胶质细胞活化、MHC 区域 GWAS 信号	部分外周炎症指标、孕期感染研究	抗炎药物临床试验不一致	研究阶段
社会逆境/移民/城市	慢性社会压力提高风险	跨国流行病学一致	混杂因素多、机制不清	指导公共卫生预防

【临床共识】从上表可以看到：**多巴胺假说是唯一已经"成功转化"为常规临床用药的理论**；其他方向要么仍在研究，要么只能提供背景性理解，**没有任何一个可以独立用来解释或诊断某个具体患者的疾病。**

5.3 动物模型与人类疾病的鸿沟

【争议观点】实验室研究大量依赖动物模型：

- 给动物使用苯丙胺或 NMDA 拮抗剂，观察其多动/刻板行为；
- 基因敲除小鼠模拟某个风险基因；
- 早期社会隔离饲养模型。

这些模型能帮助我们理解突触、环路和药物作用，但存在根本局限：

1. **动物没有"思维"**：幻觉、妄想、自知力这些人类独有的主观体验，动物模型无法真正复制；
2. **行为学终点很粗糙**：小鼠的刻板行为不等于人类的妄想；
3. **很多在动物身上"有效"的候选药，在人身上失败**——这正是转化医学的困境。

因此，**动物实验里的"突破"不能直接等同于"人类找到治愈方法"。**

5.4 异质性问题：可能不是"一种病"

【研究结论】一个越来越被接受的观点是：**"精神分裂症"这个诊断标签之下，可能藏着一组病因不同、表现相似的疾病。**

- 有的患者以遗传因素为主（如携带 22q11.2 缺失）；
- 有的患者有明确的童年创伤和大麻暴露史；
- 有的患者脑影像改变显著，有的则很轻；
- 有的患者对某一种药反应极好，有的则需要多种药物联合甚至 MECT。

这意味着：未来精神分裂症诊疗可能走向**"按生物学亚型分类"**（类似今天肿瘤治疗按基因分型），而不再是一个笼统的"精神分裂症"标签。但这一天还远未到来。

5.5 生物标志物缺失：为什么抽血/做 CT 不能确诊

【临床共识】理想的生物标志物应该是：

- 能在人群中可靠地把患者和非患者区分开；
- 与疾病严重程度相关；
- 能预测治疗反应；
- 在不同中心、不同人群中可重复。

目前精神分裂症领域**没有任何一个这样的标志物进入常规临床**：

- 血液指标（炎症因子、激素、代谢物）与正常人群重叠巨大；
- 脑影像特征个体差异大、非特异；
- 多基因风险评分 PRS 群体相关性尚可，但个体判别力不足；
- 眼动、前脉冲抑制（PPI）、听觉 P300 等神经认知指标，仅停留在研究。

临床上仍然靠精神科医生的**病史采集 + 精神检查 + 躯体/实验室检查排除器质性病因**来诊断——这一模式在可预见的未来不会根本改变。

5.6 未来方向：精准医学、数字医疗、早期干预

【研究结论】尽管局限很多，研究仍在稳步推进：

1. **精准医学**：结合基因组、影像、认知表型，试图识别生物学亚型，实现"因人施药"；
2. **早期干预**：识别**临床高危综合征（CHR）**人群——即出现轻微、不典型精神病性体验、功能下降的青少年，在完全发病前干预，有望显著改善预后；
3. **数字医疗**：用智能手机、可穿戴设备被动监测睡眠、活动、语音变化，早期发现复发迹象；
4. **新药研发**：针对谷氨酸、炎症、神经营养因子等新靶点的药物试验正在进行；
5. **社区康复模式**：把治疗从"住院管症状"转向"长期支持回归社会"。

【争议观点】这些方向多数仍处于研究或早期推广阶段，距离"治愈"还很远；对患者和家属来说，**规范现有治疗 + 心理社会康复**仍然是最可靠的路径，不应被"新概念""新突破"分散注意力。

5.7 如何理性看待"科学突破"新闻

【临床共识】建议用以下问题过滤新闻：

1. 这是观察性研究、动物实验、临床试验，还是系统综述/指南？
2. 样本量多大？有没有在独立样本中重复？
3. 报告的是相关性，还是因果证据？
4. 研究对象是谁？结果能否推广到普通患者？
5. 作者是否披露了资金来源和利益冲突？
6. 距离临床应用还有多远？（很多论文标题说"发现新疗法"，实际上距离上市可能还要 10 年以上）

> **记住：一篇基础研究论文说"我们在小鼠/细胞里发现了一个新通路"，和"人类已经能治愈精神分裂症"之间，隔着大量的临床试验、安全性验证和监管审批。** 不要被标题党带着走，也不要因为暂时没有"根治方法"而灰心——现有治疗已经能让绝大多数患者过上有尊严的生活。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症（Schizophrenia）事实清单
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- Trubetskoy V, et al. **Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia.** *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5
- van Os J, Kapur S. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2009;374(9690):635–645. doi:10.1016/S0140-6736(09)60995-860995-8)
- Howes OD, et al. **Schizophrenia: an update on recent developments.** *Nature Reviews Disease Primers*. 2017;3:17032. doi:10.1038/nrdp.2017.32

3.1 阳性症状

> **核心结论：**"阳性症状"指相对于常人状态**新增、增多或被强化**的异常体验（如听到声音、坚信被人害），不是"病情好转"，也不代表"性格外向"。这类症状通常对第二代抗精神病药反应相对较好。本页仅作科普理解，**不能用于自我诊断，也不能据此自行用药**；诊断与治疗方案只能由精神科执业医师判断。

一、什么是阳性症状

在精神分裂症的症状体系中，"阳性（positive）"是相对于"阴性（negative，能力减退）"而言的分类术语，指在正常功能之上**多出来**的精神病性体验。它主要包括三类：

1. **幻觉**——无现实刺激时的虚假感知；
2. **妄想**——难以被事实说服的病理性坚信；
3. **思维形式与行为紊乱**——言语、思维组织及外显行为的异常。

此外，紧张症（catatonia）相关的精神运动异常也常被归入阳性/精神病性症状谱。【临床共识】阳性症状往往是急性发作期最显眼、最容易被家属和外人察觉的部分，也是患者初次就诊最常见的原因。

二、幻觉（Hallucinations）

幻觉是在没有相应外界刺激时出现的、对当事人而言"像真的一样"的感知体验。需要注意：疲劳、睡眠剥夺、高热、严重抑郁、谵妄、物质使用等也可能引起一过性幻觉，**出现幻觉不等于就是精神分裂症。**

1. 幻听（Auditory hallucinations）——最常见

- 患者听到声音，而周围实际无人说话。声音可能来自窗外、隔壁、体内或"脑子里"。
- **评论性幻听**：声音在评论患者的行为或思想（如"他现在在喝水……他做错了"）。
- **命令性幻听**：声音命令患者做某事，这是**需要重点警惕**的类型——命令可能指向自伤、伤人或拒绝进食等，若存在应尽快告知医生并评估安全风险。
- 还可能出现：争论性幻听（两个声音对骂）、思维鸣响（"思维回响"，自己的想法被大声说出来）。

2. 其他类型幻觉

幻觉类型	表现	备注
幻视	看到人影、面孔、闪光、场景	相对少见；突发鲜明幻视更要警惕器质性病因（谵妄、脑病）
幻嗅	闻到不存在的气味（异味、焦味）	可与妄想结合；颞叶病变可出现类似表现
幻味	尝到食物/水中有特殊味道	常与被害妄想合并，导致拒食
幻触	感到皮肤有电流、被触摸、虫爬	可卡因等物质所致者也常见
本体/内脏性幻觉	感到体内脏器被扭曲、抽取、放入异物	常与"被控制感"妄想相联系

【临床共识】医生评估幻觉时关注：出现频率、清晰度、内容、患者对其的态度（是害怕、还是坚信不疑）、对生活和安全的影响。

三、妄想（Delusions）

妄想是一种**病理性的坚信**，内容与事实和当事人的文化、教育背景不符，且**难以通过摆事实、讲道理说服。**以下是常见主题（描述的是"主题"，不是凭一句话就下诊断）：

妄想类型	典型表现
被害妄想	坚信被跟踪、监视、投毒、陷害、迫害
关系妄想	把电视新闻、路人谈话、广告都理解成"专门针对自己"
夸大妄想	坚信自己有非凡身份、能力、财富或特殊使命
钟情妄想	坚信某人（常为地位较高者）深爱自己，缺乏证据仍不醒悟
嫉妒妄想	无依据地坚信配偶/恋人不忠，反复追查、监视
疑病妄想	坚信自己得了某种重病/内脏烂掉，反复检查阴性仍不相信
被控制感	感到自己的思想、情感、行为被外力（电波、仪器、他人）控制
思维被洞悉	感到自己的想法被广播出去、人人皆知
思维插入/思维撤走	感到有思想被"插入"自己头脑，或自己的思想被外力"抽走"

【研究结论】"影响、被动、控制体验"（experiences of influence, passivity, control）在 ICD-11 中被列为精神分裂症的**核心特征性症状**，对诊断的指向性较强。

四、思维形式与言语紊乱

- **思维破裂/思维松弛**：谈话主题在句子之间毫无逻辑地跳跃，听者无法理解其联系，严重时语词之间完全断裂（"语杂拌"）。
- **思维散漫**：说话绕圈子、答非所问，越说越远离主题，难以回到正题。
- **思维奔逸**：话题随音联、意联快速转换（更常见于躁狂发作，需注意鉴别）。
- **语词新作（neologism）**：自造文字或符号并赋予特殊含义。

【临床共识】判断思维形式障碍时，需先排除语言差异、文化背景、智力发育水平、急性谵妄等因素。

五、行为紊乱

- 衣着反常（反季节穿衣、穿着怪异、当众脱衣）；
- 当众做出无目的、不可理解的动作或仪式性行为；
- 情绪反应不协调、冲动、摔东西、无目的来回走动。
- 行为紊乱的患者可能丧失基本自我照料能力（洗漱、进食、如厕）。

六、紧张症表现（Catatonia）

紧张症是一组精神运动功能的显著紊乱，**并非精神分裂症所独有**（也可见于心境障碍、器质性脑病）：

- **木僵**：动作、言语显著减少，长时间保持固定姿势；
- **蜡样屈曲**：肢体被任意摆放后像蜡一样维持在不适位置（"空气枕头"）；
- **违拗**：对指令无动于衷，或做出相反动作；
- **缄默**：完全不说话；
- **紧张性兴奋**：突然出现无目的、猛烈的躁动。

【临床共识】出现木僵、拒食、无法饮水、意识状态改变时属于需要尽快医学处理的情况。

七、阳性症状的治疗反应与家属观察要点

- **药物反应**：【临床共识】总体而言，幻觉、妄想等阳性症状对抗精神病药（尤其第二代/非典型抗精神病药）的反应相对较好，多数患者在规范治疗后数周内明显减轻。但个体差异大，不能承诺"一定见效"。
- **家属观察要点（供就诊时向医生描述）：**

1. 首次出现异常表现的时间、持续多久、是持续还是间歇；
2. 具体听到/看到/相信什么，能不能举例；
3. 症状对睡眠、饮食、上班/上学、人际的影响；
4. 是否有命令性声音、自伤或伤人言语或行为——**这一点务必主动告知**；
5. 发病前后的物质使用（烟酒、大麻、兴奋剂等）；
6. 症状变化与天气、压力、漏药、睡眠的关系。

> **安全红线：**若患者出现明确的自伤、伤人意图或行为、拒食拒水、突然意识混乱，或命令性幻听驱使行动，应立即联系主治医生或拨打急救/精神科急诊，不要争辩妄想内容，也不要自行约束或给药。

参考来源

- 世界卫生组织 ICD-11：6A20 Schizophrenia（核心症状与病程要求）。https://icd.who.int/browse/
- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- Stein DJ, et al. **Psychotic disorders in ICD-11.** *World Psychiatry.* 2020;19(3):301-302. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7801846/

3.2 阴性症状

> **核心结论：**"阴性症状"指的是**正常心理功能的减退或丧失**——不是"想不开""懒""没病装病"，而是疾病本身的一部分。它往往比幻觉妄想更隐蔽、更长期地影响患者的生活能力，且对药物的反应通常不如阳性症状。本页仅供科普理解，**不能据此自我诊断或评判患者。**

一、什么是阴性症状

"阴性"与"阳性"相对：阳性症状是"多出来"的体验，阴性症状则是"失去"了原本具备的能力或动力。它通常以**动机减退、情感表达减少、社交退缩、言语贫乏、愉快体验下降**为核心。【临床共识】阴性症状是决定患者长期社会功能（能否上班、独立生活、维持人际关系）的关键因素之一，也是康复干预的重点和难点。

NIMH-MATRICS 共识将阴性症状归纳为五个核心领域：**快感缺失、社交退缩、意志减退、情感表达减少（情感迟钝）、言语贫乏。**

二、主要表现

1. 情感淡漠 / 情感迟钝（Blunted affect）

- 面部表情减少，很少笑或皱眉，眼神接触明显变少；
- 对喜事、丧事缺乏相应情绪反应，"像戴了面具"；
- 声调平淡、缺乏起伏。
- 【临床共识】要注意区分"真的情感迟钝"与"药物镇静导致的面无表情"，后者属于药物副作用，调整方案后可能改善。

2. 意志减退（Avolition）

- 始动性差：很难主动开始一件事，哪怕是起床、洗漱、出门；
- 生活懒散：长时间躺着、发呆、不打理个人卫生；
- 做事有头无尾，缺乏目标和坚持。

3. 社交退缩（Asociality）

- 主动回避社交，朋友逐渐断联，长时间独处；
- 对家人的关心反应平淡，并非"赌气"或"讨厌家人"。

4. 言语贫乏（Alogia）

- 少语、一问一答、甚至沉默；
- 回答内容空洞、信息量少（如反复用"还行""不知道"敷衍）。

5. 快感缺失（Anhedonia）

- 对以往喜欢的事（爱好、美食、聚会）提不起兴趣、体验不到快乐；
- 要区分"预期性愉快"（对未来活动的期待感）下降与"消费性愉快"（当下体验时的感受），研究发现前者受损更明显。【研究结论】

三、阴性症状的分类：原发性 vs 继发性

这是临床上非常重要的区分，因为处理方式完全不同：

类型	含义	常见原因	处理方向
原发性阴性症状	疾病本身核心症状的一部分	神经发育/脑功能损害	康复训练、心理社会干预、新型药物研究中
继发性阴性症状	由其他因素"模拟"出来	①抑郁；②抗精神病药镇静/锥体外系副作用；③阳性症状（如妄想令其不敢出门）；④长期住院/环境剥夺导致的社会性退缩；⑤认知损害	针对原因处理：抗抑郁药、减药/换药、控制阳性症状、丰富环境与社交刺激

【临床共识】**切勿把所有"没精神、不说话"都当成病本身**——医生需要逐一排查抑郁、药物副作用、长期隔离等可逆因素。这也是为什么复诊时医生会反复询问情绪、睡眠和药物反应。

四、评估工具

- **BNSS（简明阴性症状量表，Brief Negative Symptom Scale）**：第二代阴性症状评估工具，由受训专业人员评定，共 13 项，覆盖上述五个核心领域，另加"正常痛苦感缺失"条目，每项 0–6 分。【研究结论】Kirkpatrick 等 2011 年发表。
- **SANS（阴性症状评定量表）**：Andreasen 编制，较经典，分情感淡漠、言语贫乏、意志减退、社交退缩、注意障碍五个分量表。
- 此外临床还会结合 PANSS 阴性分量表、功能评估综合判断。

> **提示：**这些量表由专业人员使用，患者/家属**不要自行上网打分下结论。**分数只用于辅助评估严重程度和随访变化。

五、为什么阴性症状更隐蔽、更影响长期功能

1. **隐蔽**：患者没有"奇怪的言行"，外人常误以为"懒""性格变了""装病"，容易被忽视，从而延误干预。
2. **长期**：阳性症状在急性发作期突出、治疗后多可缓解；阴性症状往往持续更久，直接决定出院后能否回归工作和家庭生活。
3. **药物有限**：【临床共识】传统抗精神病药对阴性症状效果有限；部分第二代药物（如氨磺必利、阿立哌唑等）在某些研究中显示出一定改善，但证据不一致，**不能指望单靠吃药彻底逆转。**【争议观点】新型针对谷氨酸系统的药物仍在研究中，**尚未成为常规临床用药。**

六、康复应对方向

- **不要指责、不要催促**：把"你怎么这么懒"换成"我们一起先做哪一小步"；
- **小步快走、任务分解**：把"出门"拆成"穿好鞋—走到门口—下楼"，每完成一步给予肯定；
- **结构化日常**：固定起床、就餐、服药、外出时间，减少无所事事；
- **逐步重建兴趣**：从低强度、低压力的活动（散步、简单手工、短时间聊天）开始；
- **家庭干预与社会技能训练**：由专业机构指导，避免长期隔离；
- **治疗抑郁与药物副作用**：必要时由医生评估是否调整。

> **误区澄清：**阴性症状不是"父母没教育好""患者意志力薄弱"，也不是"想通了就能好"。它有明确的脑功能基础，需要医学与康复手段共同作用。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- Kirkpatrick B, Strauss GP, Nguyen L, et al. **The Brief Negative Symptom Scale: psychometric properties.** *Schizophrenia Bulletin*. 2011;37(2):300-305. https://doi.org/10.1093/schbul/sbq059
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.

3.3 认知损害

> **核心结论：**认知损害是许多精神分裂症患者**长期、稳定存在的核心困扰**，常常比幻觉妄想更能决定其能否工作、独立生活和管理自己的疾病。它**不等于智力低下**，也不是"变笨了、没救了"。本页仅供科普，具体评估和康复方案需由专科团队制定。

一、为什么认知损害重要

精神分裂症患者在多个认知领域存在可测量的损害，且这些损害往往在**发病前的前驱期、甚至青少年时期**就已显现（如学习成绩缓慢下滑、反应变慢），在急性精神病性症状被控制后也**相对稳定地持续存在。**【研究结论】相比阳性症状"时好时坏"，认知损害对长期预后（就业、社交、独立生活能力）的预测作用更强。

> **重要澄清：**认知损害 ≠ 智力缺陷（精神发育迟滞）。它是一组特定信息加工能力的下降，患者的基础智力水平大多正常，只是在注意、记忆、执行等特定环节上效率和准确度受损。

二、主要受累的认知领域

认知领域	具体表现	日常影响举例
注意/警觉性	难以集中注意力、容易被干扰、持续性注意差	听讲座、看长文章中途走神；很难同时做两件事
工作记忆	短时记住并操作信息的能力下降	边听电话边记地址会漏；刚交代的事转头就忘
学习与记忆	言语记忆、视觉记忆巩固困难	学新东西比以前费力；记不住医嘱、药物服用时间
执行功能	计划、组织、排序、抑制冲动、任务切换困难	不会安排一天的事；购物列了清单也漏买；很难从一件事切换到另一件
处理速度	信息加工和反应变慢	别人说完要反应半天；对话跟不上节奏
决策困难	权衡利弊、做选择时犹豫、容易被干扰	面对简单选择也反复不定
社会认知	情绪面孔识别困难、"心理理论"（理解他人意图）下降	容易误解他人语气和表情；社交中显得"不会看脸色"

【研究结论】其中，**言语记忆、工作记忆、注意与执行功能**被多项研究反复证实为受损最稳定、最有代表性的领域。

三、认知损害的特点

1. **出现早**：在前驱期甚至更早的学校阶段就可能有痕迹（成绩缓慢退步、社交变差），这也是早期识别的线索之一。
2. **相对稳定**：不像幻觉妄想那样随发作明显波动，治疗后改善幅度有限。
3. **与功能结局密切相关**：认知水平较好的患者，康复和回归工作的可能性更高。
4. **受多种因素影响**：睡眠差、抑郁、焦虑、药物镇静副作用、物质使用、高龄、教育背景都会使当时的测验表现更差——**一次测验分数低不能代表真实能力的永久上限。**

四、对实际生活的影响

- **就业**：难以胜任需要持续注意、多任务处理、快速学习新技能的工作；
- **独立生活**：管理账单、按时服药、安排就医、做饭等多步骤事务变得困难；
- **服药管理**：忘记吃药、漏服、重复服药，直接影响治疗依从性；
- **社交**：因"跟不上对话"而回避社交，反过来加重退缩。

【个人经验（供参考，非普遍结论）】患者和家属常反映："病好了，但人好像变慢了、记不住事了"——这正是认知损害的典型主观体验，值得主动向医生提出。

五、评估与康复

1. 评估

专业团队可通过结构化认知成套测验（如涵盖注意、记忆、执行功能的神经心理测验）评估各领域水平，并结合日常功能访谈判断其影响。测验结果需结合教育、语言、文化背景解释，**不是诊断精神分裂症的工具。**

2. 认知康复训练（Cognitive Remediation）

- 通过反复练习、策略指导、将复杂任务分解等方式，针对性训练注意、记忆和执行功能；
- 常与职业康复、社交技能训练结合，效果更好；
- 【研究结论】多项随机对照研究显示认知康复可改善认知表现和社会功能，但改善幅度存在个体差异，**尚在不断完善，未成为所有患者的常规强制项目。**

3. 日常支持策略（家属可配合）

- 把复杂任务拆成简单、按顺序的步骤，书面列出；
- 用日历、闹钟、手机提醒、药盒（分早中晚/星期）辅助记忆；
- 一次只交代一件事，重要信息重复并请其复述确认；
- 减少环境干扰，固定作息，保证睡眠；
- 避免同时安排太多任务，循序渐进。

> **药物说明：**抗精神病药主要针对阳性症状，对认知损害的直接改善作用有限；某些药物在研究中显示出对特定认知领域的轻微益处，但证据强度不一，**不能指望靠某种药"恢复记忆"**。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- Kahn RS, Keefe RSE. **Schizophrenia is a cognitive illness: time for a change in focus.** *JAMA Psychiatry*. 2013;70(10):1107-1112. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.184
- Wykes T, et al. **Cognitive remediation therapy for schizophrenia.** *Schizophrenia Bulletin*. 2011;37(3):477-484. https://doi.org/10.1093/schbul/sbr027
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.

3.4 情绪相关表现

> **核心结论：**精神分裂症不只是"幻觉妄想"，抑郁、焦虑、易激惹等情绪问题在病程各阶段都很常见，并且与**自杀风险**密切相关。情绪症状的来源很多——疾病本身、药物副作用、心理应激、病耻感、物质使用都可能。**不要自行判断"是心病还是药的问题"，应告知医生综合评估。**

一、为什么要重视情绪症状

【研究结论】抑郁和焦虑在精神分裂症患者中的发生率显著高于普通人群，且贯穿前驱期、急性发作期、巩固期和康复期。情绪问题往往比精神病性症状更早被患者本人察觉，也是**服药依从性差、社交退缩、生活质量下降**的重要原因，更是自杀风险评估中必须重点关注的线索。

二、主要情绪表现

1. 抑郁

- 情绪低落、兴趣减退、疲乏、睡眠和食欲改变、自责、无望感；
- 可出现在：前驱期（发病前）、急性发作期（与妄想并存）、发作后（"病耻感+功能受损"所致）、维持期；
- 【研究结论】精神分裂症患者终生自杀风险显著高于一般人群，**合并抑郁是最强的预警因素之一。**

2. 焦虑

- 社交焦虑（害怕与人接触）、广泛性焦虑（持续紧张、多思多虑）、惊恐发作；
- 常与被害妄想、幻听、病耻感叠加，使患者更加回避外出和社交。

3. 易激惹 / 情绪不稳

- 小事就发脾气、烦躁、冲动、情绪快速波动；
- 可能与阳性症状、睡眠差、药物副作用、应激有关。

4. 敌对与愤怒

- 对家人、医护人员充满敌意、抱怨、甚至出现攻击言语；
- 需区分：是妄想（如坚信被家人迫害）驱动，还是情绪调节能力下降、或药物/物质所致。

三、如何区分情绪症状的来源

这是临床最常见、也最容易误判的环节。同一种"烦躁、低落"，可能来自完全不同的原因：

可能来源	典型线索	处理方向
疾病本身（抑郁/焦虑共病）	情绪低落、兴趣下降、自责早醒，与精神病性症状并存	评估后由医生考虑抗抑郁/抗焦虑治疗
药物副作用	尤其是**静坐不能（akathisia）**：内心烦躁、坐立不安、来回踱步，常在加药后出现	复诊告知医生，调整药物剂量/种类
心理应激 / 病耻感	知道自己患病后自卑、回避、被歧视后的委屈	心理支持、家庭干预、康复教育
物质使用	烟酒、大麻、兴奋剂、镇静药滥用后情绪波动	物质评估与戒断干预
躯体因素	感染、疼痛、睡眠剥夺、甲状腺异常等	相应检查与处理

【临床共识】**静坐不能常被患者和家属误认为"脾气变坏"或"病情加重"**，其实是药物的锥体外系反应之一，及时调整可明显改善。出现"怎么坐都不舒服、总想走动、心里发慌"时，要主动告诉医生。

四、情绪症状与阴性症状的鉴别

两者表面都可能"话少、不开心、不出门"，但处理不同：

维度	抑郁（情绪症状）	阴性症状
主观体验	患者能感受到低落、痛苦，常主诉"我不开心"	患者往往平淡、不觉得有问题，主诉少
时间特点	可阵发性加重，早晚可有波动	相对持续、稳定
对活动的态度	想做但做不到、自责	缺乏想做的愿望
典型伴随	早醒、食欲体重下降、消极观念	情感迟钝、意志减退、卫生退化

【临床共识】区分二者很重要：抑郁需要抗抑郁治疗和心理支持；阴性症状则以康复训练、环境干预为主。把抑郁当成阴性症状"硬扛"，可能错失干预、增加自杀风险。

五、何时必须尽快就医（情绪红线）

出现以下任何情况，应尽快联系主治医生或精神科急诊：

1. **流露消极言语**："活着没意思""我是累赘""不如死了算了"；
2. **安排后事、突然把珍爱物品送人、写遗书**；
3. **反复自伤行为**或出现具体的自杀计划；
4. 抑郁突然加重、彻夜不眠、拒绝进食；
5. 出现命令性幻听驱使自伤或伤人；
6. 情绪烦躁到无法静坐、冲动、有攻击倾向。

> **家属须知：**不要回避和患者谈论"你是不是不想活了"——直接、平静地询问**不会诱发**自杀，反而能让患者感到被理解、并争取到干预时机。同时把药物、利器、危险物品妥善收好，并尽快就医。

六、应对原则

- 情绪问题要**主动向医生报告**，不要觉得"这是自己的性格问题、不好意思说"；
- 记录情绪波动与服药、睡眠、事件的关系，供医生判断；
- 规律作息、适度活动、避免酒精和大麻；
- 家庭多倾听、少评判，减少病耻感。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.
- Hor K, Taylor M. **Suicide and schizophrenia: a systematic review of rates and risk factors.** *Psychology Medicine*. 2010;40(4):565-575. https://doi.org/10.1017/S0033291709991521

3.5 疾病分期

> **核心结论：**精神分裂症不是"一下子发作、一下子治好"，而是一个大致连续的过程：前驱期（微妙变化）→ 急性发作期（明显精神病性症状）→ 巩固期（控制症状、防复发）→ 维持/康复期（长期稳定）。了解各期特点，有助于早期识别、规律治疗和减少复发。**具体病程和治疗时长必须由医生根据个体情况决定，本页不给个体化疗程方案。**

一、为什么要分期

同一种疾病在不同阶段，症状、治疗重点和家属任务完全不同。把"早期微妙变化"当成"性格问题"硬扛，是延误治疗、影响预后的常见原因；而把"维持期"当成"病好了可以停药"，又是复发的常见诱因。【临床共识】**发病到开始规范治疗的时间（DUP，未治疗精神病持续时间）越短，总体预后往往越好。**

二、各期特点

1. 前驱期（Prodromal phase）

指**首次明显精神病性症状出现前数月至数年**的微妙变化，常被误认为"青春期叛逆""压力大""性格变了"：

- 学习成绩、工作表现缓慢下滑；
- 社交退缩、朋友断联、对以往爱好失去兴趣；
- 情绪改变：易激惹、焦虑、情绪不稳；
- 出现古怪念头（迷信、偏执、特殊想法）；
- 感知异常（偶尔听到声音、感到不对劲）；
- 生活懒散、睡眠紊乱。

【临床共识】前驱期识别困难、表现不典型，但**这是早期干预、改善预后的关键窗口。**对高危人群（家族史阳性、近期明显功能下降伴古怪想法），专业机构可使用 SIPS/SOPS 等工具评估，早期干预可推迟或减轻首次发作。**但普通家属不要据此自行对号入座或贴标签。**

2. 急性发作期（Acute episode）

- 出现明显、持续的精神病性症状：幻觉、妄想、思维紊乱、行为紊乱，甚至紧张症；
- 自知力缺失（不承认自己有病，拒绝治疗）；
- 社会功能明显受损，可能无法工作、自理；
- 治疗重点：尽快控制症状、保证安全、必要时住院。

3. 巩固期（Continuation/stabilization）

- 急性症状得到控制后，仍需继续治疗，防止症状波动或复燃；
- 患者开始恢复一定自知力，可能出现病耻感、情绪低落；
- 治疗重点：维持原有效剂量、逐步恢复生活规律、处理药物副作用、观察复发苗头。

4. 维持期 / 康复期（Maintenance/recovery）

- 症状长期稳定，功能逐步恢复；
- 治疗重点：长期维持治疗以预防复发、社会功能康复（回归家庭、社交、工作学习）、心理社会干预。
- 【临床共识】**多次发作后通常需要长期甚至长期维持治疗**，自行停药是复发的首要原因。

5. 残留状态（Residual state）

- 部分患者急性症状缓解后，仍残留轻度阴性症状（如动力不足、少语、社交少）、不系统的轻度妄想或偶发幻觉；
- 残留状态因人而异，不代表"永远好不了"，需长期随访和康复支持。

三、各期对照表

分期	主要表现	治疗重点	家属任务
前驱期	功能下滑、社交退缩、情绪/感知微妙改变	早期识别、尽早就诊评估	记录变化、避免指责、陪同就医
急性发作期	明显幻觉妄想、行为紊乱、无自知力	控制症状、保证安全、必要时住院	保证安全、遵医嘱、防自伤伤人
巩固期	症状缓解、自知力部分恢复、易病耻/抑郁	维持治疗、防复燃、调副作用	规律提醒服药、观察情绪、陪伴复诊
维持/康复期	长期稳定、残留少量阴性症状	长期维持、社会功能康复	支持回归生活、防复发苗头、接纳

> **关于持续时间的一般说明：**【临床共识】首次发作后，通常建议在症状控制后继续治疗一段时间（常以月计）；多次发作患者多主张长期维持。**具体时长、剂量、是否减药，必须由精神科医生结合发作次数、缓解程度、复发风险和副作用个体化决定，本资料库不提供"吃多久能停"的答案。**

四、复发的早期信号（衔接后续模块）

从维持期再次滑向发作，往往有预警信号：睡眠变差、多疑加重、社交退缩、情绪反常、旧症状（声音、妄想）重新出现。家属熟悉这些信号，就能在复发早期及时就诊，而不是等到症状完全爆发才就医。

参考来源

- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.
- Perkins DO, et al. **Stage model for the early phases of schizophrenia.** *Schizophrenia Bulletin*. 2019;45(4):761-771. https://doi.org/10.1093/schbul/sby140

1. 诊断标准

> **核心结论：**ICD-11（编码 6A20）和 DSM-5 是国际上两套主要的精神分裂症诊断分类标准。它们在"病程时长"上差异明显（ICD-11 要求特征性症状持续至少约 1 个月；DSM-5 要求全病程至少 6 个月，含前驱/残留期）。**诊断权仅限精神科执业医师**，下面的摘要仅供理解医学如何判断，**不能用来自我诊断、自我贴标签或自行用药。**

一、ICD-11（6A20 精神分裂症）诊断要点摘要

ICD-11 由世界卫生组织发布，6A20 为精神分裂症的编码。其核心要求可概括为：

- **核心特征性症状**（被认为最具代表性的）：
- ①持续的妄想；
- ②持续的幻觉；
- ③思维紊乱（如思维破裂、散漫）；
- ④影响、被动或控制体验（被控制感、思维被插入/撤走、被洞悉等）。
- **其他可伴随的表现**：阴性症状（情感淡漠、意志减退、言语贫乏等）、行为明显紊乱或不可理解、紧张症（精神运动紊乱）。
- **症状数量要求**：在上述各类表现中**至少出现两类**，且**其中至少一类必须来自①–④这四项核心症状。**
- **病程**：上述症状在一段时期内"大部分时间存在"，**持续至少约 1 个月。**
- **排除项**：症状不能归因于另一种躯体疾病（如脑肿瘤），也不能由精神活性物质或药物（如皮质类固醇）的直接效应所致。

【临床共识】ICD-11 保留了 ICD-10 约 1 个月的最短病程要求；同时不再像旧版那样强调"偏执型、青春型、紧张型"等亚型划分，而更关注症状域、严重度和病程。

二、DSM-5 诊断标准 A–F 摘要

DSM-5（美国精神医学学会）将精神分裂症归入"精神分裂症谱系及其他精神病性障碍"。其诊断标准可概括为：

- **A. 活动性症状**：至少出现以下 5 类症状中的**2 项或以上**，且其中**至少 1 项必须是妄想、幻觉或言语紊乱**：

1. 妄想；
2. 幻觉；
3. 言语紊乱（如明显的思维破裂、答非所问）；
4. 明显紊乱或紧张症行为；
5. 阴性症状（情感迟钝、意志减退等）。

- **B. 功能损害**：自起病以来，在工作、人际关系或自我照料等重要方面，功能水平明显低于病前。
- **C. 病程**：**持续性症状体征至少持续 6 个月**；这 6 个月内必须包含至少 1 个月（若经治疗可缩短）符合 A 项的"活动性症状"期，其余时间可为前驱期或残留期（以轻度阴性症状、不典型妄想/幻觉为主）。
- **D. 排除分裂情感性障碍和心境障碍**：在整个病程中，没有与活动性症状同时出现的重性抑郁/躁狂发作；即精神病性症状不能主要由心境发作解释。
- **E. 排除物质/躯体疾病**：症状不能归因于精神活性物质或其他躯体疾病的生理效应。
- **F. 与孤独症谱系障碍等发育障碍的关系**：若有孤独症谱系或童年起病的沟通障碍史，只有在妄想、幻觉等精神病性症状持续存在足够长时间时，才额外诊断精神分裂症。

三、两套标准异同对比

对比维度	ICD-11（6A20）	DSM-5
发布机构	世界卫生组织（WHO）	美国精神医学学会（APA）
主要用途	国际健康信息记录、统计、分类	临床诊断与研究
特征性症状	强调妄想/幻觉/思维紊乱/被控制体验为核心	A 项 5 类症状中至少 2 项，且至少含妄想/幻觉/言语紊乱之一
最短病程	特征性症状"大部分时间"持续**约 1 个月**	全病程**至少 6 个月**，其中活动期至少 1 个月，其余可为前驱/残留
阴性症状地位	可作为伴随表现	可计入 A 项，但需至少有 1 项是妄想/幻觉/言语紊乱
亚型	不再强调传统亚型	同样取消了传统亚型，改用标注
排除项	排除躯体疾病、物质/药物效应	排除物质/躯体疾病，并专门排除心境障碍和分裂情感障碍

【临床共识】两套标准在"多数真实病例"上诊断一致性较高；差异主要体现在病程门槛和表述框架上。国内临床与科研多结合使用 ICD（与国际疾病分类接轨）和 DSM 思路。

四、症状持续时间是关键鉴别点

在"精神分裂症谱系"中，**病程长短是区分不同诊断的重要依据**：

诊断	病程大致范围	说明
短暂精神病性障碍	**< 1 个月**	急性起病的精神病性症状，通常数天到数周缓解
分裂样精神病性障碍	**约 1–6 个月**	症状符合精神分裂症但病程不足 6 个月
精神分裂症（DSM-5）	**≥ 6 个月**（含前驱/残留）	活动期至少 1 个月
精神分裂症（ICD-11）	特征性症状持续**约 ≥ 1 个月**	门槛相对低，但同样需排除其他原因

【临床共识】**不要因为"只出现了几周声音/妄想"就给自己下精神分裂症结论**——这可能只是短暂精神病性障碍或其他可恢复的情况；也不要因为"还没满 6 个月"就硬扛不治疗。时间窗口交给医生判断。

五、为什么不能自测诊断

1. 许多情况（睡眠剥夺、谵妄、物质、抑郁、双相、器质性脑病）都会产生相似症状；
2. 患者往往**自知力缺失**，无法客观评估自己；
3. 病程、功能损害、排除项都需要完整病史和家属旁证；
4. 诊断是动态的、可随观察更新的，不是一次"对号入座"。

> **行动建议：**若担心本人或家人，可记录症状出现时间、变化、睡眠、用药和物质使用情况，尽早到正规精神科/精神卫生中心就诊。**不要因阅读诊断条目自行贴标签或改变处方。**

参考来源

- 世界卫生组织 ICD-11：6A20 Schizophrenia。https://icd.who.int/browse/
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）。https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263
- American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).** DSM-5. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.
- Stein DJ, et al. **Psychotic disorders in ICD-11.** *World Psychiatry.* 2020;19(3):301-302. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7801846/

2. 诊断流程

> **核心结论：**精神分裂症的诊断不是"聊几句就开方"，而是一个**多步骤、需结合病史、精神检查、躯体与实验室排查、有时还需随访观察**的临床判断过程。首次就诊未必能立刻确诊，**这是正常且负责任的做法。**诊断权在精神科执业医师。

一、就诊科室

- 首选：**精神科**（综合医院精神科/心理科）或**精神卫生中心 / 精神病专科医院**；
- 若起病突然、伴发热、意识混乱、抽搐、头痛、外伤，应先到**急诊内科/神经内科**排除器质性急症，再转精神科；
- 儿童青少年可就诊儿童精神科/儿童心理科。

【临床共识】不要先靠"心理咨询""算命""网络自查"代替精神科评估；急性精神病性发作**不是单纯聊天能解决的。**

二、诊断流程概览

步骤	内容	目的
1. 病史采集	现病史、既往史、家族史、成长史、物质使用史	勾勒症状时间线与高危因素
2. 精神检查	面谈观察外表、言语、思维、感知、情感、自知力	直接评估精神症状
3. 躯体与神经系统检查	体格检查、神经科查体	寻找器质性线索
4. 实验室检查	血/生化/内分泌/电解质/妊娠/物质筛查等	排除代谢、感染、物质等所致
5. 脑影像 / 脑电图	必要时头颅 CT/MRI、脑电图	排除脑器质病变，而非"确诊精神分裂症"
6. 鉴别排查	逐项排除双相、抑郁伴精神病性、物质、器质性等	确定最可能诊断
7. 随访观察	治疗反应、病程演变、复诊	修正和确认诊断

三、各步骤要点

1. 病史采集

医生会详细询问：

- **现病史**：症状从什么时候开始、最初表现、如何加重、对生活工作的影响；
- **既往史**：过去是否有类似发作、其他精神疾病、躯体疾病、脑外伤；
- **家族史**：直系亲属有无精神分裂症、双相、抑郁、酗酒、自杀等；
- **成长史 / 发育史**：童年发育、学习成绩、性格、社交；
- **物质使用史**：酒精、大麻、冰毒、可卡因、致幻剂、激素等使用情况；
- **用药史**：正在/曾经服用的药物（包括处方药、保健品）。

【临床共识】**家属提供的旁证非常重要**——患者常因自知力缺失而低估或否认症状，家属描述的"病前 vs 病后变化"是关键线索。

2. 精神检查

医生通过面谈观察：

- **外表与行为**：衣着、卫生、动作、合作程度；
- **言语**：速度、量、连贯性（思维形式障碍）；
- **思维内容**：有无妄想、妄想的主题与确信度；
- **感知**：有无幻觉及其类型、内容；
- **情感**：情绪基调、情感协调性；
- **自知力**：是否认识到自己有病、是否愿意治疗。

3. 躯体与神经系统检查

寻找能解释精神症状的躯体线索：意识状态、瞳孔、局灶神经体征、脑膜刺激征、甲状腺、心率血压等。**突发意识改变、局灶体征、发热、抽搐**提示器质性病因，需紧急处理。

4. 实验室检查（常见项目）

- 血常规、生化（肝肾功能、血糖血脂）、电解质；
- 甲状腺功能；
- 妊娠试验（育龄女性）；

- 物质/毒物筛查；
- 必要时感染相关检查（如梅毒、HIV、病毒学）。

【临床共识】抽血是为了**排除"是别的病导致的精神症状"**，不是为了"在血里找到精神分裂症"。精神分裂症没有特异性验血指标。

5. 脑影像与脑电图

- 适用情形：首次发病、起病突然、有神经系统体征、高龄首发、伴意识/认知改变、怀疑肿瘤/卒中/脑炎/癫痫；
- 头颅 CT/MRI、脑电图可排除脑肿瘤、脑梗、脑炎、癫痫、正常压力脑积水等；
- **正常的影像和脑电图不能确诊精神分裂症，异常也不一定排除它**——它们是"排除性检查"。

四、为什么首诊未必立刻确诊

- 病程尚短，可能还在"短暂精神病性障碍 / 分裂样障碍"的时间窗内；
- 物质使用、情绪发作、躯体问题需要时间观察和排查；
- 症状可能被镇静药物或住院环境暂时掩盖；
- 诊断是**动态更新**的：随治疗反应和病程演变，可能修正诊断。

【临床共识】**"第一次没确诊"不等于医生没水平或查不出来**，恰恰是谨慎负责的表现。

五、附：就诊准备清单（家属可提前记录）

就诊前把以下信息整理好，能大幅提高就诊效率：

1. **症状时间线**：最早从什么时候、什么表现开始，何时加重；
2. **具体表现举例**：患者说了什么、做了什么（尽量原话、原场景）；
3. **功能变化**：病前 vs 病后（成绩/工作、社交、作息、个人卫生）；
4. **睡眠与饮食**：近期睡眠、进食、体重变化；
5. **物质使用**：烟酒、大麻、兴奋剂、其他药物；
6. **情绪与安全**：有无低落、烦躁、自伤/伤人言语或行为；
7. **既往就诊与用药**：病历、处方、药盒、检查报告；
8. **家族史**：亲属精神疾病史；
9. **当前最担心的问题**：想让医生重点判断什么。

> **提示：**带上既往病历、检查报告和正在服用的所有药物（含药盒），比空口描述更可靠。

参考来源

- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）。https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.
- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

3. 鉴别诊断

> **核心结论：**"出现幻觉、妄想或行为异常"**不等于就是精神分裂症。**许多疾病——双相情感障碍、重度抑郁、脑器质性疾病、物质所致、妄想性障碍等——都可能出现相似表现。鉴别诊断是精神科医师结合完整病史、症状时程、检查结果作出的临床工作。**漏诊、误诊都可能发生，因此必要时复诊、修正诊断是正常的。**

一、为什么鉴别诊断如此重要

把"双相躁狂伴精神病性症状"误当精神分裂症，或把"冰毒所致的精神病性症状"当成原发性精神分裂症，治疗方向和预后判断会完全不同。【临床共识】首次发病、起病急、有躯体线索时，鉴别排查尤其关键。下面逐项列出常见需要鉴别的情况及鉴别要点。

二、常见需鉴别的疾病及要点

1. 双相情感障碍伴精神病性症状

- 关键看**心境发作（躁狂/轻躁狂或抑郁）与精神病性症状的时程关系**；
- 若妄想/幻觉**只出现在躁狂或抑郁发作期内**，且与心境内容协调（如躁狂时夸大自己有超能力、抑郁时坚信自己罪孽深重），更倾向双相伴精神病性；
- 若在**没有明显心境发作**时仍持续存在精神病性症状，则更倾向精神分裂症。

2. 重度抑郁障碍伴精神病性症状

- 精神病性症状出现在**重度抑郁发作背景下**，常为与自罪、贫穷、疾病相关的妄想（如坚信自己内脏烂了、犯了大罪）；
- 抑郁缓解后精神病性症状随之消失；
- 与精神分裂症的区别：后者在**无显著心境发作的间歇期**仍有精神病性症状。

3. 脑器质性疾病（器质性/症状性精神病）

- 包括：脑炎（尤其病毒性脑炎）、脑肿瘤、脑梗死、脑外伤、癫痫（尤其颞叶癫痫）、正常压力脑积水、代谢/内分泌异常、感染、电解质紊乱等；
- **警示线索**：起病急骤、意识模糊、定向障碍、发热、头痛、抽搐、新发神经系统体征、年龄偏大首次出现、症状昼轻夜重；
- 需靠神经系统查体、脑电图、头颅影像（CT/MRI）、腰穿、实验室检查识别。
- 【临床共识】**首次急性出现、尤其伴意识或神经体征时，必须先排除器质性病因**，这是"排除性检查"存在的意义。

4. 物质或药物所致精神病性症状

- 常见物质：冰毒（甲基苯丙胺）、可卡因等兴奋剂；致幻剂；大麻（长期/高剂量使用可升高风险）；酒精相关（戒断、慢性酒精中毒）；
- 药物：大剂量糖皮质激素（类固醇）、某些左旋多巴类、抗胆碱能药物、某些拟交感药等；
- 鉴别关键：**症状与物质使用/停药的时程关系**——使用后短期内出现、停用后逐渐缓解，支持"物质所致"；
- 【研究结论】**大麻是已被确认的精神分裂症高危环境因素之一**，早用、高频使用风险更高。

5. 分裂情感性障碍

- 指**同时符合心境发作（重性抑郁/躁狂）和精神分裂症活动期症状**，且在**没有明显心境发作的情况下，精神病性症状仍持续至少约 2 周**；
- 介于双相/抑郁伴精神病性与精神分裂症之间，靠"精神病性症状独立于心境症状持续的时间"来区分。

6. 分裂样障碍 / 短暂精神病性障碍

- 二者靠**病程长短**区分（详见"诊断标准"页）：
- 短暂精神病性障碍：症状**< 1 个月**；
- 分裂样障碍：症状约 **1–6 个月**；
- 症状本身可与精神分裂症相似，只是病程未达到标准。

7. 妄想性障碍（偏执性精神障碍）

- 以**系统、固定的妄想**为主要表现（如坚信被跟踪、被爱、配偶不忠），但**没有明显的幻觉、思维破裂或阴性症状**，日常功能相对保持；
- 与精神分裂症相比，其妄想更系统、少泛化，行为除妄想相关部分外较正常。

8. 解离性障碍

- 涉及身份、记忆、意识连续性的中断（如人格解体、现实解体、遗忘），常与创伤相关；
- 与精神分裂症的"思维插入/被控制体验"表面相似，但成因和治疗不同，需仔细鉴别。

9. 强迫症（OCD）、创伤后应激障碍（PTSD）

- 强迫思维可被患者体验为"闯入性想法"，但患者通常**知道是自己的想法、且为此痛苦**（缺乏自知力的强迫症例外）；
- PTSD 的闪回、闯入性记忆与幻觉不同，有明确创伤史；
- 需注意：精神分裂症可与这些疾病共病。

10. 孤独症谱系障碍（ASD）

- 社交沟通异常和刻板行为**起病于儿童期**，有长期发育史；
- 若成年后**新出现**妄想、幻觉，仍需单独评估是否叠加了精神分裂症，不能简单用"本来就这样"解释。

三、鉴别要点对照表

疾病	最关键鉴别线索	起病/病程特点	需借助的检查
双相伴精神病性	症状仅在心境发作期出现、与心境协调	发作性、有躁狂/抑郁期	病史、随访
重度抑郁伴精神病性	重度抑郁背景下的自罪/疑病妄想	抑郁发作期	病史、随访
脑器质性疾病	意识/神经体征、起病急、发热/外伤	急性、进展快	影像、脑电图、腰穿、化验
物质/药物所致	与物质使用/停药时间吻合	用后即现、停后渐消	毒物筛查、物质史
分裂情感性障碍	无心境期仍有精神病性症状≥约2周	混合病程	病史全程评估
分裂样/短暂精神病性	病程<6个月（或<1个月）	短、可缓解	随访
妄想性障碍	系统妄想、无思维破裂/阴性症状	慢性、功能相对保留	长期观察
解离性障碍	身份/记忆/意识中断、创伤史	与应激相关	创伤史、临床访谈
强迫症/PTSD	自知力（多数）、创伤史、强迫行为	慢性、有特定症状群	临床访谈
孤独症谱系	起病于儿童期的发育史	自幼存在	发育史、评估

四、漏诊、误诊风险与复诊的必要性

- **漏诊**：早期、症状不典型、患者隐瞒或自知力缺失，可能被当成"情绪问题""性格问题"；
- **误诊**：把物质所致、双相、器质性脑病误判为精神分裂症，或反之；
- 【临床共识】精神科诊断是**概率性、动态性**的——随病程演变、治疗反应、补充检查，诊断可能修正。**一次诊断不是终身烙印，复诊和调整是正常医疗过程。**

> **给患者与家属的提醒**：不要依据网络描述给自己或他人下结论。若出现突然意识改变、无法自理、即时安全风险，应优先急诊。拿不准时，正规精神科复诊、带上既往病历，比自行判断重要得多。

参考来源

- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）。https://www.who.int/publications/i/item/9789240077263
- American Psychiatric Association. **DSM-5.** https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.
- 世界卫生组织：精神分裂症事实清单。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

4. 评估量表简介

> **核心结论：**精神科量表是**辅助评估症状严重程度、追踪疗效变化**的工具，**不等于诊断**，更不能由患者/家属自己上网测分下结论。分数必须由受过培训的专业人员结合访谈、病史和日常功能综合解释。

一、量表的定位与使用原则

- 量表回答的是"**现在有多严重、治疗后好转了多少**"，而不是"**是不是精神分裂症**"；
- 评分受评估者培训、语言文化、评估时点、患者配合度影响；
- 纵向随访时尽量用**同一量表、相近条件**，才好比较；
- **不能**用单次分数预测暴力、自杀，或给患者贴标签、决定命运。

二、常用量表一览

量表	全称/英文	评定者	主要用途	条目概况
PANSS	阳性与阴性症状量表	专业人员（基于访谈+观察）	总体症状严重度评估、疗效随访、科研	30 项，含阳性分量表、阴性分量表、一般精神病理分量表
SAPS	阳性症状评定量表	专业人员	系统评估幻觉、妄想、行为紊乱等阳性症状	4 个分量表（幻觉、妄想、怪异行为、阳性思维形式障碍）
SANS	阴性症状评定量表	专业人员	系统评估情感淡漠、言语贫乏、意志减退、社交退缩、注意	5 个分量表
BPRS	简明精神病量表	专业人员	快速评估精神病性症状总体严重度	约 18 项，较简略
CGI	临床总体印象量表	专业人员	总体疾病严重度、疗效变化	含严重度（SI）、疗效改善（GI）、疗效指数
CDSS	卡尔加里精神分裂症抑郁量表	专业人员	专门评估精神分裂症中的抑郁症状	9 项，针对精神分裂症人群设计，避免与阴性症状/锥体外系反应混淆
GAF / SOFA	总体功能评估 / 社会与职业功能评估	专业人员	评估心理、社会、职业功能水平	连续量表（0–100 分区间），反映整体功能
SIPS / SOPS	前驱期结构化访谈 / 精神病症状定式评估	专科人员	评估"高危/前驱期"精神病风险	仅专科使用，用于早期识别

三、重点量表说明

1. PANSS（阳性与阴性症状量表）

由 Kay 等于 1987 年发表，是精神分裂症研究和临床随访中**最常用**的量表之一。共 30 项，每项按 1–7 分评分，分三个分量表：

- **阳性分量表**（7 项）：幻觉、妄想等；
- **阴性分量表**（7 项）：情感迟钝、情绪交流、人际关系等；
- **一般精神病理分量表**（16 项）：焦虑、抑郁、怪异行为、不合作等。

【临床共识】PANSS 总分用于比较治疗前后症状变化，但**不能单独决定诊断、用药或是否住院。**

2. SAPS 与 SANS

由 Andreasen 编制，分别系统覆盖阳性与阴性症状，常**配对使用**，帮助医生判断"阳性为主还是阴性为主"，并观察各症状域的变化。

3. BPRS（简明精神病量表）

条目较少、评定快捷，适合门诊快速评估总体严重度，但对阴性症状的细致刻画不如 SANS。

4. CGI（临床总体印象）

由临床医生根据整体印象打分，简单直观，常用于疗效总体判断；主观性相对强，需结合其他量表。

5. CDSS（卡尔加里精神分裂症抑郁量表）

专门针对精神分裂症患者的抑郁设计。【临床共识】它的重要性在于把"真的抑郁"与"阴性症状（意志减退）""药物导致的锥体外系反应/假性抑郁"区分开，避免漏诊抑郁（漏诊会增加自杀风险）。

6. GAF / SOFA（功能评估）

不只看"有没有症状"，更看患者**实际能做到什么**——能否工作、自理、与人相处。这比单纯症状分数更能反映康复水平。

7. SIPS / SOPS（前驱期评估）

用于**临床高危（CHR）/前驱期**人群的早期识别，判断是否存在向精神病性障碍发展的风险。【临床共识】**只能由专科高危团队使用**，普通患者和家属不要自行套用。

四、认知与功能评估（补充）

若关注注意、记忆、执行功能，会使用专门的神经心理成套测验；若关注日常独立生活能力，会用功能访谈或实际任务评估。这些结果需结合教育、语言、文化背景解释，**同样不是诊断精神分裂症的工具。**

五、给患者和家属的正确认知

1. 医生给你打 PANSS、看分数，是为了**量化病情、观察疗效**，不是"给你判刑"；
2. **不要**在网上找量表自行打分、自行对照"我是不是精神分裂症"；
3. 分数下降不等于"可以停药"，分数高也不等于"治不好"；
4. 主动向医生报告**情绪、睡眠、副作用**，比纠结量表分数更有意义。

> **总结：**量表是医生手里的"尺子"，用来量"病情多重、好转多少"，而不是"身份证"，不能用来自我诊断。

参考来源

- Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. **The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia.** *Schizophrenia Bulletin*. 1987;13(2):261-276. https://doi.org/10.1093/schbul/13.2.261
- Andreasen NC. **Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) / Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS).** University of Iowa; 1984.
- Addington D, et al. **The Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS).** *British Journal of Psychiatry*. 1990;156:253-258. https://doi.org/10.1192/bjp.156.2.253
- NICE 指南 CG178：Psychosis and schizophrenia in adults。https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 中华医学会精神医学分会.《中国精神分裂症防治指南》（第二版）. 2015.

5.1 药物治疗

> **核心结论：抗精神病药是精神分裂症治疗的基石，但选药、剂量、加量、换药、停药全部由精神科处方医生决定。** 本页是一般科普，不能替代面诊与个体化方案；任何"别人吃哪种药好""能不能减半""吃多久能停"都不要自行决定，应与主治医生讨论。突然停药是导致复发最常见、也最可以避免的原因之一。

一、治疗总体目标与全病程原则

精神分裂症的药物治疗不是"急性期吃一阵就结束"，而是分阶段、贯穿全程的过程。【临床共识】

1. **急性期（约数周）**：尽快控制幻觉、妄想、兴奋紊乱等阳性症状，保障安全与基本生活，评估对药物的耐受。
2. **巩固期（约数月）**：症状已明显缓解但仍不稳定，继续维持有效治疗剂量，防止症状复燃，促进社会功能恢复。这一阶段自行减药极易复发。
3. **维持期（长期）**：在症状稳定基础上预防复发、减少残留症状、维持与恢复生活/工作能力。维持治疗的时长因人而异：《中国精神分裂症防治指南》提出，**首发患者通常至少维持约 2 年，一次复发者约 3–5 年，多次复发者可能需要 5 年以上乃至长期维持**；具体年限由医生根据复发风险与功能状况判断，不能套用固定数字自我停药。【临床共识】

全病程治疗的要点是"**足量、足疗程、规律随访、不擅自中断**"。药物对阳性症状疗效较确切，对阴性症状与认知损害帮助有限，因此必须配合心理社会干预（见 5.2）。

二、抗精神病药的分类

1. 第一代（传统/典型）抗精神病药

主要通过阻断多巴胺 D2 受体起效，代表药物（通用名）：**氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静、舒必利**等。【临床共识】

- 特点：对阳性症状有效、价格较低；但**锥体外系反应（EPS）和高泌乳素血症更常见**，长期使用迟发性运动障碍风险相对突出。

2. 第二代（非典型）抗精神病药

目前临床首选范围更广的一类，代表药物（通用名）：**氯氮平、利培酮、奥氮平、喹硫平、齐拉西酮、阿立哌唑、帕利哌酮、鲁拉西酮、布南色林**等。【临床共识】

- 特点：**总体 EPS 较少、对部分阴性症状和情感症状可能更友好**，因此常作为起始首选；但并非"第二代就人人更优、更安全"——不同药物在体重/代谢、泌乳素、镇静、心脏 QT 间期等方面的风险差异很大，需个体化权衡。【争议观点】"二代普遍优于一代"是过于简化的说法；研究显示疗效与安全性是逐药比较的，而非按"代"一概而论。

> 本页只列通用名与相对特点，**不给出任何剂量、疗程或"你该吃哪种"的结论**。商品名繁多，实际用药以处方和说明书为准。

三、代表药物不良反应谱相对对比

下表为**群体层面的相对倾向**（"相对多/相对少"为大致比较，不代表个体必然反应），用于帮助理解"为什么医生这样选药"，不能据此自行换药。【临床共识】【研究结论】

药物（通用名）	体重/代谢增加	泌乳素升高	锥体外系反应 EPS	镇静嗜睡	心脏 QT 影响	其他需注意
氯丙嗪（一代）	中	中	较高	较强	较明显	体位性低血压明显
氟哌啶醇（一代）	较低	较高	**高**	轻	可延长	迟发性运动障碍风险
舒必利（一代）	中	**高**	较低	轻	轻	泌乳素相关问题突出
利培酮	中	**高（剂量相关）**	中	中	轻	泌乳素、月经/性功能影响
帕利哌酮	中	**高**	中	中	轻	利培酮活性代谢物，有长效针剂
奥氮平	**高**	低	较低	较强	轻	体重、血糖血脂升高突出
喹硫平	中偏高	低	低	较强	轻	镇静、体位性低血压
齐拉西酮	低	低	较低	中	**较明显**	需关注 QT，建议餐前服
阿立哌唑	低	低	中（静坐不能）	轻	轻	部分为多巴胺"部分激动"，静坐不能常见
鲁拉西酮	低	低	较低	中	轻	需随餐服用，胃肠道反应
布南色林	低	中	中	中	轻	锥体外系反应相对常见
氯氮平	**高**	低	低	**强**	可延长	**粒细胞缺乏、心肌炎、严重便秘、流涎**

> 表中"高/低"为相对倾向，受剂量、年龄、合并用药、躯体状况影响。**任何不适都应主动告知医生，而不是自行停药。**

四、常见不良反应详解

1. 锥体外系反应（EPS）——多见于一代药与高剂量二代药

- **急性肌张力障碍**：用药早期出现头颈部/眼部肌肉不自主痉挛、眼球上翻等，需立即就医处理。
- **静坐不能**：坐立不安、反复走动、内心烦躁，易被误认为"病情没好"，应告知医生。
- **类帕金森反应**：震颤、肌肉僵硬、动作迟缓、面具脸、流涎。
- **迟发性运动障碍（TD）**：长期用药后出现的**不自主咂嘴、伸舌、肢体舞蹈样动作**，可能不可逆，关键在于早识别、早报告、由医生调整。【临床共识】

2. 恶性综合征（NMS）——少见但危重

表现为**高热、严重肌肉僵硬、意识改变、自主神经紊乱（出汗、血压波动、心动过速）**。出现疑似症状须立即急诊。

3. 代谢综合征

表现为**体重明显增加、腰围增大、血糖升高、血脂异常**，长期增加糖尿病与心血管病风险。奥氮平、氯氮平相对突出。这正是需要定期监测体重、血糖、血脂的原因（见下节）。【研究结论】

4. 高泌乳素血症

女性月经紊乱/闭经、泌乳，男性乳房发育、性功能下降。利培酮、帕利哌酮、舒必利相对突出。**不要因"不好意思说"而隐瞒**，医生可以调整方案。

5. 抗胆碱能反应

口干、视物模糊、便秘、排尿困难。便秘在氯氮平患者中可能非常严重（甚至致肠梗阻），需主动管理。

6. 体位性低血压

起身时头晕、眼前发黑，尤其老年人、喹硫平/氯丙嗪/氯氮平使用者。起身宜慢，跌倒风险需防范。

7. QT 间期延长

可能增加严重心律失常风险。齐拉西酮、氯氮平、某些一代药需关注；用药前及用药中按需查心电图。

五、治疗前与治疗中监测

【临床共识】【研究结论】治疗开始前应做基线评估，治疗中定期复查，把"副作用管起来"而不是"忍一忍"或擅自停药：

监测项目	大致意义	频率参考（由医生定）
体重 / BMI、腰围	早期发现体重与代谢变化	治疗前、治疗中定期
空腹血糖 / 糖化血红蛋白	筛查药物性血糖升高	治疗前、定期复查
血脂（甘油三酯、胆固醇）	代谢综合征监测	治疗前、定期复查
血压	心血管风险、体位性低血压	定期测量
泌乳素	月经/性功能相关不适时检测	按需
心电图（含 QT）	心律失常风险	治疗前、用药后按需
运动症状（EPS/TD 评定）	锥体外系与迟发性运动障碍	每次复诊观察
血常规（尤其用氯氮平时）	**粒细胞缺乏监测**	氯氮平按规范密集复查

配合提示：出现发热伴肌肉僵硬、晕厥、严重便秘、吞咽困难、皮肤巩膜黄染、严重过敏等，应尽快就医。

六、长效注射剂（长效针剂）

长效针剂按较长间隔（如每 2 周、4 周或更长）肌肉注射给药，血药浓度更平稳。代表药物有利培酮、帕利哌酮、奥氮平等的长效剂型（具体以医生处方为准）。【研究结论】

适用场景：

- 反复漏服、藏药、停药与复发相关；
- 本人偏好更省心的给药方式、希望减少"每天记着吃药"的负担；
- 依从性困难、希望降低复发风险。

优势与误区澄清：

- 优势：减少漏服、血药浓度稳、便于家属和团队监督；研究提示可降低复发与再住院风险。
- **误区**：长效针剂**不是强制惩罚性治疗，也不是"病情最重才打"**，更不等于"打了就不能停"。它是一种与口服药并列的、需本人知情同意的治疗选择；起始常需短期口服药过渡，并有相应注射部位与不良反应需评估。【争议观点】是否使用应结合本人意愿、复发史、副作用与可及性，由医患共同决定。

七、疗效不足的评估流程与"难治性"

症状控制不理想时，**不要自行加量或换药。**医生通常按以下顺序排查：【临床共识】

1. 诊断是否准确、是否共病（抑郁、物质使用、躯体疾病）；
2. **是否真的规律、足量、足疗程服用**（依从性、藏药、漏服）；
3. 剂量与疗程是否足够、药物相互作用、物质（酒、大麻、毒品）使用；
4. 换用其他抗精神病药、联合心理社会干预；
5. 经规范步骤仍疗效差，评估是否为难治性精神分裂症。

难治性定义（大致）：经过至少两种不同抗精神病药、足量足疗程治疗后，症状仍明显、功能仍差。【临床共识】

氯氮平是公认对难治性精神分裂症疗效较突出的药物，也被用于**降低自杀风险**的特定情形。但其使用有严格要求，**绝不能自行要求或自行开始**：

- **粒细胞缺乏/中性粒细胞减少**：需按规范频繁复查血常规，严重时可危及生命；
- **心肌炎、心肌病**风险（用药早期需警惕胸痛、气短、心悸）；
- **严重便秘/肠梗阻、流涎、过度镇静、体重与代谢、癫痫阈值下降**等。

必须在有监测条件的专科由医生启动并长期随访。

八、减药与停药原则

【临床共识】这是最需要反复强调的部分：

- **维持治疗的意义**：复发多在停药后数月内出现，每复发一次，后续治疗反应可能变差、脑功能与社会功能恢复更难。
- **严禁自行、突然停药**：可能出现**撤药反应/症状反跳**（失眠、恶心、焦虑、幻觉妄想快速复现）并显著升高复发风险。
- **想减药的正确做法**：如副作用难以耐受、计划怀孕、症状长期稳定，应**尽早与处方医生沟通**，由医生评估后**缓慢、逐步减量**，并在停药后继续观察随访；出现复发苗头及时复诊。
- 停药不是"治好了"的标志，是否停、何时停、怎么停，是医生基于复发风险与功能状况的个体化决定。

九、辅助用药（由医生评估，不可自行加用）

- **抗抑郁药**：用于合并抑郁、强迫等问题时，需评估与抗精神病药的相互作用。
- **抗焦虑药/安眠药**：短期用于明显焦虑、失眠，**长期依赖风险需警惕**，不建议自行长期服用。
- **心境稳定剂（如锂盐、丙戊酸盐类）**：用于伴冲动、情感不稳或预防复发的特定情形，需监测血药浓度与肝功能。
- 任何合并用药都要把"正在吃的所有药（包括中药、保健品）"告知医生，避免相互作用。

十、MECT 无抽搐电休克治疗

【临床共识】MECT 是在**全身麻醉、肌肉松弛与心电监护**下，以短暂诱发适量脑电发作来治疗的医疗技术，并非历史上不规范的"电打"。

常见适应证（由治疗团队评估）：

- 严重兴奋冲动、伤人或自伤风险高；
- **木僵、拒食拒饮、衰竭**；
- 难治性精神分裂症（尤其与氯氮平等配合）；
- 强烈自杀意念或行为。

流程与顾虑：

- 治疗前需麻醉评估、禁食禁饮；通常一个疗程多次，在专科病房/门诊治疗室进行。
- **疗效**：对急性、严重状态起效常较快。
- **记忆影响**：治疗期间及之后一段时间可能出现**近事记忆下降，多数在疗程结束后逐渐恢复**，属常见且多为暂时的顾虑，应与团队充分沟通。
- 可能的麻醉相关、认知与心血管等不良反应需个体化评估。
- **须知情同意**（本人或依法可代为决定者），并由精神科与麻醉团队共同决定。

> **一句话记住本页**：药要吃对、吃稳、吃够时间；副作用早说、不藏药、不突然停药；选药与调药永远交给处方医生。

参考来源

- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南》（第二版，赵靖平、施慎逊主编，2015；2025 版已更新），人民卫生/中华医学电子音像出版社。版本报道见 中南大学新闻网 https://news.csu.edu.cn/info/1003/162589.htm
- 中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组：《精神分裂症患者代谢综合征管理的中国专家共识》，《中华精神科杂志》2020,53(1):3-10。全文 https://training.yiigle.com/uploads/guide_html/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%88%86%E8%A3%82%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E4%BB%A3
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：mhGAP Intervention Guide https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278

- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》 https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

5.2 心理社会干预

> **核心结论：药物是控制精神病性症状的基础，心理社会干预是"让人重新过上生活"的康复核心。** 但要明确：**单纯心理咨询不能"治愈"急性精神病发作，也不能替代药物**；急性发作期应以精神科医疗为主，谈话不是主要治疗手段。康复是"药物 + 心理社会干预 + 躯体健康管理 + 社会支持"的系统工程。

一、为什么药物之外还要心理社会干预

抗精神病药对幻觉妄想等阳性症状帮助较大，但对**阴性症状（退缩、淡漠）、认知损害（注意力、工作记忆）、社会功能恢复**作用有限。研究一致显示：在规律用药基础上配合心理社会干预，能显著降低复发率、改善生活质量和职业功能。【研究结论】【临床共识】

干预应遵循几个原则：

- **以当事人的目标为中心**，不是"把人改造成标准样子"；
- **循序渐进、可反复**，康复不是直线上升；
- **在本人知情同意下**纳入家属或支持者，尊重隐私；
- **不承诺"包好""根治"**。

二、认知行为治疗（CBTp）

针对精神病性体验调整的认知行为治疗（CBTp），是证据较充分的心理治疗方式。【研究结论】

- **做法**：结构化、协作式，治疗师与当事人一起做"个案概念化"——理解这些体验如何形成、与压力/睡眠/情绪的关系，而不是强迫当事人"承认自己有病"或立刻放弃信念。
- **目标**：减轻症状带来的**困扰**、学习应对策略（如如何与幻听相处、如何检验异常想法）、降低焦虑、恢复被退缩掉的生活活动。
- **适用人群**：症状已部分稳定、具备一定交流能力的患者；对残留症状、共病焦虑抑郁者尤其有用。
- **阶段**：一般在巩固期/维持期、能坐下来谈时开展；**急性严重发作、自知力极差、极度紊乱时不适合以谈话为主。**

> 注意区分：CBTp 是**针对精神病性障碍的专项心理治疗**，需要受过专门训练的治疗师，不等于普通的"聊聊心事"。

三、家庭干预（Family Intervention）

【研究结论】家庭干预是证据最强的康复手段之一，能显著降低复发率。

- **核心概念——降低"高情感表达（High EE）"**：家属过度指责、敌意、或过度卷入/过度保护，与较高复发率相关。干预不是责怪家庭，而是帮家人调整沟通方式。
- **内容**：
- 疾病心理教育（这是什么病、为什么要坚持吃药、复发信号）；
- 沟通技巧训练（清晰、平和、就事论事，不翻旧账、不贴标签）；
- 解决问题训练（一起面对具体困难）；
- 照护者自身的压力支持。
- **前提**：需患者本人同意；存在家庭冲突或安全问题时，应先保障安全。

四、社交技能训练与社会认知训练

- **社交技能训练**：通过**角色扮演、模拟对话、眼神与语气练习、情绪表达与识别**，帮助当事人重建"打招呼、发起对话、拒绝、表达需求"等实用能力。
- **社会认知训练**：练习**识别他人表情与意图、理解社交情境、归因方式**，改善因认知症状导致的误解与退缩。
- 形式：小组训练通常比一对一更贴近真实社交，且成本更低。

五、支持性心理治疗与同伴支持

- **支持性心理治疗**：稳定的倾听、鼓励、现实检验与情绪疏导，帮助应对压力与病耻感，适合长期伴随。
- **同伴支持（Peer Support）**：由有康复经历的"过来人"提供陪伴与榜样，能显著降低孤独感与病耻感。
- **康复会所模式（Clubhouse）**：以会员平等参与、共同参与日常运作、过渡性就业为特色的社区康复模式，国际上有成熟网络。

六、职业康复

【研究结论】职业康复是功能恢复的关键，推荐模式包括：

- **辅助就业（IPS，Individual Placement and Support）**："先安置、后培训"，在真实竞争岗位上提供持续支持，是证据最强的就业支持模式；
- **过渡性就业**：先在庇护性岗位工作，逐步过渡；
- **庇护性就业/工疗**：病情尚不稳定时的中间站。

就业支持要点：病情稳定后再启动、从兼职/弹性/志愿岗位起步、与雇主做合理沟通与调适、关注倦怠与复发边界（详见模块6"社会功能康复"）。

七、其他康复手段

- **生活技能训练**：个人卫生、做饭、购物、理财、用药管理、家务的分步训练。
- **艺术治疗、运动/健身**：绘画、音乐、手工、规律运动，改善情绪与躯体健康，非药物辅助。
- **动机访谈（MI）与依从性干预**：用非评判方式帮助当事人发现"自己为什么要坚持治疗"，减少对抗性藏药、停药。

八、各干预方式汇总表

干预方式	主要目标	常见形式	适用阶段	证据强度（相对）
认知行为治疗 CBTp	减轻症状困扰、应对策略、降焦虑	结构化一对一/小组	巩固期、维持期	较强
家庭干预	降复发、改善家庭沟通	多次家属参与	全程，尤其巩固/维持	强
社交技能训练	重建沟通与应对	小组角色扮演	维持期	中等偏强
社会认知训练	改善人际理解	小组/程序训练	维持期	中等
支持性心理治疗	情绪支持、病耻感应对	长期随访谈话	全程	中等
同伴支持/会所	减少孤独、重建角色	同伴陪伴、会所活动	维持期	中等偏强
职业康复（IPS）	回归工作	真实岗位+持续支持	病情稳定后	强
生活技能训练	自理与独立生活	分步练习	维持期	中等
艺术/运动	情绪、躯体健康	团体活动	全程	辅助
动机访谈/依从干预	提高坚持治疗	动机式谈话	全程	中等

> 证据强度为科普层面的相对概括，不替代指南原文；"急性发作期"以上干预均不能替代药物与医疗监护。

九、如何在国内获得这些服务、开始前问什么

哪里能获得：

- 精神卫生中心/综合医院精神科门诊常提供心理治疗与康复指导；
- 社区卫生服务中心（严重精神障碍社区管理，见国家《严重精神障碍管理治疗工作规范》）可提供随访、康复站、日间照料；
- 部分城市有康复会所、工疗站、公益同伴支持组织；
- 正规心理治疗需确认治疗师具备精神科/心理治疗资质。

开始一项干预前可以问：

1. 你是否受过针对精神病性障碍的专门训练？目标和方法是什么？
2. 预期多久看到什么变化？可能有哪些不适？
3. 费用、频次、疗程如何？有哪些替代选择？
4. 隐私如何保护？是否会联系家属、学校或单位（需我同意吗）？
5. 如何评估进展？什么情况下需要转回精神科医疗？

> **重要边界**：急性幻觉妄想活跃、严重失眠、冲动、拒食、自杀念头时，**第一选择是精神科急诊/门诊，而不是约一次心理咨询。**谈话治不了急性精神病发作。

参考来源

- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
- 世界卫生组织：mhGAP Intervention Guide https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》 https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南》（第二版，2015；2025版已更新），版本报道见 中南大学新闻网 https://news.csu.edu.cn/info/1003/162589.htm

1. 影响预后的因素

> **核心结论：精神分裂症的预后是高度异质的——不是"都好"，也不是"都完了"。** 群体研究只能告诉你"哪些因素与较好/较差结局相关"，不能用来给任何个人宣判结局。很多关键因素（是否及时治疗、是否坚持服药、家庭支持、物质滥用）是**可以干预**的，不必宿命论；但也不能把预后不好简单归咎于"患者不努力"。

一、预后的大致分布（可核查的概括）

长期随访研究（如欧美多项 10–20 年随访）常把结局大致概括为：【研究结论】

- 约 **1/3** 患者经规范治疗后症状缓解、能较好地维持生活与工作；
- 约 **1/3** 呈反复发作、需反复住院，但在间隙期可维持一定功能；
- 约 **1/3** 呈慢性迁延、残留较多阴性/认知症状、功能较差。

需要强调：【争议观点】这类"三分"是粗略的群体分布，受诊断标准、治疗年代、随访对象（住院 vs 社区）影响很大，**不同研究数字差异不小**；而且"结局"是多维度的——症状缓解、复发次数、自理能力、人际关系、职业、生活质量未必同步。有人仍有轻微症状但生活满意，也有人症状控制了但功能恢复较慢。

二、有利因素（与较好结局相关）

【研究结论】【临床共识】

- **急性起病**：症状突然、明显，更容易被及时发现和治疗；
- **起病年龄相对较晚**（成年后、非青少年期）；
- **前驱期短、未治期（DUP）短**；
- 以**阳性症状为主**（对药物反应通常较好）；
- **及时、规范、足疗程治疗**；
- 对药物治疗**反应好、耐受好**；
- **长期坚持服药、规律随访**；
- **家庭支持良好、情感表达适中**（不过度指责也不过度包办）；
- **无物质滥用**（尤其不酗酒、不吸大麻）；
- **认知损害较轻**；
- 起病前有较好的职业/社会角色与功能基础。

三、不利因素（与较差结局相关）

【研究结论】【临床共识】

- **隐匿、缓慢起病**：早期变化长期被忽视；
- **起病年龄早**，尤其青少年期起病；
- **前驱期长、未治期（DUP）长**；
- **阴性症状、认知损害突出**（药物对此帮助有限）；
- **反复多次复发**；
- **反复中断/自行停药**；
- **物质滥用**（酒、大麻、其他毒品）；
- 家庭**高情感表达**（长期指责、敌意或过度卷入）；
- 脑结构改变较明显、共病较多；
- 缺乏社会支持、居无定所、经济困难。

四、未治期（DUP）与预后

DUP（Duration of Untreated Psychosis，未治疗精神病期）指从精神病性症状真正出现到开始规范抗精神病治疗的这段时间。【研究结论】

- 多项研究提示：**DUP 越长，短期乃至长期的症状缓解与功能恢复越差**；这是少数被反复验证、且**可以通过早识别、早就诊缩短**的可干预因素。
- 意义：识别前驱期微妙变化、尽早到精神科就诊、不"等等看"，是家属和社会能做的最有价值的事之一。
- 注意：DUP 与预后的关系虽较一致，但**并非线性决定**，长 DUP 不等于没希望，规范治疗仍能带来明显改善。

五、预后因素分类汇总表

维度	有利因素	不利因素	是否可干预
起病方式	急性、明显	隐匿、缓慢	部分（靠早识别）
起病年龄	成年后较晚	青少年早期	否

维度	有利因素	不利因素	是否可干预
未治期 DUP	短	长	**是（早就医）**
症状结构	阳性为主	阴性/认知突出	部分
治疗	及时、足量足疗程	拖延、不规范	**是**
服药依从	长期坚持	反复自行停药	**是**
物质使用	无	酗酒、大麻、毒品	**是**
家庭环境	支持适中	高情感表达/缺支持	**是**
认知功能	损害轻	损害重	部分（康复训练）
社会支持	有角色、有支持	孤立、无业、居无定所	**是**

六、如何看待"预后"而不陷入两极

- **避免宿命论**："得了这个病一辈子就毁了"是错误的；许多因素可干预，康复是长期但真实存在的过程。
- **避免侥幸**："感觉好了就可以自己停药"会显著推高复发，而复发本身是不利预后因素。
- **预后是动态的**：一次复发不代表判死刑，关键是缩短停治时间、尽快重新规范治疗。
- **结局要分维度看**：症状、自理、社交、学习、就业、生活质量可以分别设定、逐步改善。

> 给患者与家属的话：把注意力放在**能改变的部分**——早就诊、坚持规范治疗、远离酒与毒品、改善家庭沟通、建立复发预警计划。这些才是真正影响结局的杠杆。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南》（第二版，2015；2025版已更新），版本报道见 中南大学新闻网 https://news.csu.edu.cn/info/1003/162589.htm
- Huang Y, et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study. The Lancet Psychiatry 2019;6(3):211-224. DOI:10.1016/S2215-0366(18)30511-X

2. 复发预警信号

> **核心结论：复发很常见，但大多数复发前数天到数周会出现"预警信号"，且这些信号是可以被本人和家属提前识别、并通过及时干预（联系医生、调整治疗）阻断的。** 关键不是"等发作了再送医院"，而是在信号刚出现时就行动。每个患者的信号都不一样，需要共同整理一份"个人预警计划"。

一、为什么要重视预警信号

【研究结论】【临床共识】

- 精神分裂症复发率高：研究显示**停药/不规律服药会显著推高复发**，首发后数年内累计复发比例不低。
- 多数复发并非突然发生，而是有一段**前驱期（prodrome）**：睡眠、情绪、社交、想法的细微改变先于明显幻觉妄想出现。
- **在这一窗口期及时联系医生、恢复/调整治疗，常能避免一次住院**——这是性价比最高的康复动作。

二、常见预警信号清单

以下信号**单看一条都不特异**（失眠也可能只是熬夜），但如果**多条同时出现、且与本人平时状态明显不同**，就值得警惕。【临床共识】

类别	常见信号	说明
睡眠	入睡困难、早醒、睡眠明显变少或紊乱	往往是最早、最敏感的信号之一
想法	多疑加重、旧的妄想/被害念头复现、对人对事过度敏感	"又开始觉得别人针对自己"
感知	旧的幻觉（尤其幻听）重新出现或变响变频繁	可能先于妄想出现
社交	主动回避家人朋友、不愿出门、退缩加重	与平时"安静"不同的退缩
情绪	莫名烦躁、易怒、焦虑、情绪低落、哭笑无常	易激惹常被误当"脾气差"
注意力/规律	注意力涣散、生活节奏被打乱、工作学习效率骤降	作息、饮食、个人卫生变差
言行	言语变得古怪、离题，行为出现旁人觉得奇怪的举动	家人/同事最先察觉
治疗行为	**自行减药、停药、藏药、说"我好了不用吃了"**	极高复发危险信号
物质	重新开始喝酒、吸大麻或其他物质	强诱发因素

三、信号是"个人化"的

- 每个人的"复发长相"不同：有人先失眠，有人先多疑，有人先停药。【个人经验】临床上反复复发的患者，其复发前驱表现往往**高度相似**。
- 因此最重要的是：在病情**稳定的时候**，回顾过去几次发作"之前都发生了什么"，整理出**本人特有的信号和出现顺序**。
- **不要凭单一条信号就恐慌**（连续两晚失眠不等于复发），要看趋势和组合。

四、共同制定"复发预警计划 / 预先指示"

在病情稳定、本人愿意参与时，由患者 + 家属 + 医生共同写下一份书面计划（最好一式几份），内容包括：【临床共识】

1. **个人基线与预警信号**：我平时是什么状态？哪些是我专属的复发早期信号、按出现顺序列出；
2. **有效的应对方式**：过去哪些做法能让我稳下来（散步、规律作息、找某人聊聊、暂时减少刺激）；
3. **支持网络**：第一联系人（家属/朋友）、主治医生/门诊电话、就近精神卫生中心地址；
4. **陪同人**：谁负责在信号出现时陪诊、谁能拿到病史与用药清单；
5. **急诊安排**：去哪家医院、带什么、紧急情况下的授权（预先指示可写明本人希望如何被处置）；
6. **定期更新**：每数月或每次复诊回顾一次，调整信号清单。

> 书面计划的意义：复发时本人往往自知力差、无法决策，家属需要一份"提前说好"的依据，避免临时争执或犹豫。

五、家属沟通话术示例（非指责、就事论事）

预警信号出现时，沟通方式直接影响患者愿不愿配合：

- **不好的说法**（易激起对抗）：
- "你又发病了！""你是不是又没吃药？""你怎么整天在家躺着。"
- **推荐的说法**（关注具体行为、表达关心、给出选项）：
- "我注意到你这几天睡得很少，是不是有点不舒服？我们要不要给医生打个电话问问？"
- "你最近好像不太想见人，我有点担心你。想不想周末一起出去走走，顺便去复诊看看？"
- "药要是有哪里吃得不舒服，跟我说，我们一起去跟医生调，别自己停。"

原则：**描述具体观察到的变化 → 表达担心而非评判 → 提供具体帮助/选项。**不要在患者多疑、激越时当面争辩"你那是妄想"。

六、什么时候联系门诊、什么时候直接急诊

尽快联系门诊/主治医生（通常可在数天内处理）：

- 多条预警信号同时出现、持续数天；
- 睡眠明显恶化、情绪或多疑开始波动；
- 出现自行减停药的念头或行为。

直接急诊 / 拨打 120（甚至 110）的红线（见模块6"风险内容"）：

- 出现明确自伤、自杀念头或计划；
- 命令性幻听指使伤人/自伤；
- 严重兴奋冲动、无法控制、有伤人危险；
- 木僵、拒食拒饮、不能照顾基本需要；
- 意识混乱、高热伴肌肉僵硬（警惕恶性综合征）。

七、记录与隐私

- 家属可记录"日期 + 观察到的具体变化 + 当天睡眠/服药情况"，复诊时给医生看，比口头回忆更准确。
- 记录应**保护隐私**：存放得当、不外传；患者本人也应有参与感和知情权，而不是被"偷偷监控"。

> **一句话记住**：预警信号出现的窗口期，是"花小钱办大事"的时间——一通电话、一次复诊，常常就能挡住一次住院。

参考来源

- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》（含随访与风险评估） https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：mhGAP Intervention Guide https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南》（第二版，2015；2025版已更新），版本报道见 中南大学新闻网 https://news.csu.edu.cn/info/1003/162589.htm

3. 长期康复管理

> **核心结论：精神分裂症是需要"全病程长期管理"的慢性疾病，稳定期不等于"可以不管了"。** 康复的成败，往往不取决于急性期治得有多猛，而取决于出院后这几年：规律复诊、坚持服药、管好睡眠与躯体健康、远离酒与毒品。把日常管理做成习惯，比任何一次"抢救式治疗"都重要。

一、全病程长期管理理念

【临床共识】

- 精神分裂症的管理是**长期工程**，目标是"预防复发 + 维持功能 + 提高生活质量"，而不是"症状没了就结束"。
- 稳定期停药/停随访是复发最常见的诱因；**越是自我感觉良好，越要守住规律复诊。**
- 管理需要"医疗 + 生活方式 + 社会支持 + 患者自我管理"四条腿走路。

二、规律复诊（稳定期也要复诊）

- **稳定期为什么还要复诊**：医生要评估疗效是否仍足够、副作用是否在悄悄累积（体重、血糖、泌乳素、运动症状）、是否有复发苗头、药物是否需要微调。很多问题在复诊时一句话就能解决，拖到复发代价巨大。
- **复诊时谈什么**：
- 最近睡眠、情绪、社交、工作学习状态；
- 有没有出现预警信号（见 2. 复发预警信号）；
- 服药是否规律、有没有漏服或不适；
- 体重、血糖、血压等躯体指标；
- 对就业、复学、家庭关系的现实困扰。
- **建议做法**：固定一位主治医生/一家医院，建立连续病历；复诊间隔由医生根据稳定程度决定，稳定后可拉长，但不建议自行取消。

三、药物依从性管理

【研究结论】坚持规范服药是降低复发最关键的可干预因素。但**漏服、藏药非常普遍**，不是"患者意志力差"，需要系统性对策：

常见漏服原因与对策：

漏服原因	对策
忘记吃	闹钟/手机提醒、药盒分格、与固定日常动作绑定（如刷牙后）
"我好了，不用吃了"	与医生明确"维持期为什么还要吃"，理解复发代价
副作用难受、不敢说	**尽早告诉医生调药**，而不是自行停药
嫌麻烦、天天吃药	与医生讨论**长效针剂**是否适合（见 5.1）
经济/配药不便	了解医保、长处方、社区取药，提前备药
藏药、抗拒	动机访谈式沟通，避免当面搜查激化对抗

- **漏服了怎么办**：按医生/说明书指引处理，**不要下次加倍补吃**；连续漏服或出现不适，及时联系医生。
- **副作用要早沟通**："有点胖了""月经乱了""坐不住""白天困"——这些都可以和医生商量调整，不必忍到自行停药。

四、规律作息与睡眠

- **睡眠是复发的晴雨表**：长期熬夜、作息紊乱会显著增加复发风险。【临床共识】
- 建议：固定起床和睡觉时间、白天适度活动、减少睡前手机和咖啡因、白天多见自然光。
- 出现持续失眠，不要自行长期吃安眠药，应复诊（安眠药有依赖风险，由医生评估）。

五、戒酒、戒毒品、限制大麻

【研究结论】【临床共识】

- **酒精、大麻、其他毒品是明确的复发诱发因素**，会与药物相互作用、加重精神病性症状、显著升高复发和暴力风险。
- 尤其**大麻**：被多项研究认定为精神病性障碍的明确高危因素，应完全避免。
- 已形成依赖者，应在复诊时告知医生，一并治疗物质共病，而不是"先戒一阵再说"。

六、饮食、体重与代谢管理、运动

- 抗精神病药（尤其奥氮平、氯氮平、利培酮类）易致**体重增加、血糖血脂异常**，长期增加糖尿病、心血管病风险。【研究结论】

- 日常管理：控制高糖高油高盐、规律三餐、少含糖饮料；**每周规律有氧运动**（快走、慢跑、骑车等）。
- 定期监测体重、腰围、血糖、血脂、血压（与 5.1 监测表对应）；发现指标异常尽早和医生、营养师商量。

七、压力管理与放松

- 过大压力、重大生活事件是复发诱因。学习识别压力信号、练习放松（呼吸训练、正念、规律运动、兴趣爱好）有帮助。
- 避免在康复初期一次性叠加太多"大目标"（同时换工作、搬家、恋爱），给生活留出稳定的基本盘。

八、躯体健康共管（早亡风险）

【研究结论】这是常被忽视、却非常重要的一点：

- 精神分裂症患者的**躯体疾病（尤其心血管、代谢）患病率和早亡风险高于普通人群**——一部分来自疾病本身和生活方式，一部分来自药物代谢影响，也与"只看精神、不管身体"的就医习惯有关。
- **因此要把身体也当病人管**：
- **年度体检**：血压、血糖/糖化、血脂、肝肾功能、心电图、体重腰围；
- **牙科**：定期洗牙检查（抗精神病药常见口干，口腔卫生更重要）；
- **疫苗**：按年龄和状况接种流感、肺炎等疫苗；
- 出现持续躯体不适（胸闷、气短、严重便秘、黄疸等）及时看综合科，不要都归为"心理作用"。

九、戒烟、财务管理与日常生活

- **戒烟**：精神分裂症人群吸烟率高，吸烟影响药物代谢、加重心血管风险，应纳入管理；可向医生求助戒烟方法。
- **财务管理**：学习记账、管理零花钱/生活费，避免在病态支配下大额消费或受骗；必要时在本人同意下由家属协助大额支出。
- **日常生活**：固定日程、承担力所能及的家务、保持个人卫生，都是维持功能的"基本功"。

十、家属的角色边界

- **支持但不包办**：帮患者重新学会独立生活，而不是替他做完所有事；适度的自主感有利于康复。
- **自己也要有生活与喘息**：长期照护会耗竭，家属应保留自己的社交、休息和（必要时）心理支持。
- **避免两种极端**：一是"全权代劳、什么都管"，二是"不闻不问、完全推给医院"。
- 出现家庭冲突或照护压力，可求助家庭干预、社区精神卫生服务（见 5.2）。

十一、复发后怎么办

- 复发不是"前功尽弃"，而是**需要重新评估和调整治疗**的信号。
- 尽快复诊/住院，恢复规范治疗；分析复发原因（停药？压力？物质？），更新预警计划；不要互相指责。
- 复发后康复节奏应放慢，功能恢复一步步来，不急于马上回到高强度工作/学习。

十二、分层管理清单

频率	管理事项
每日	规律作息与睡眠；按时服药（用提醒工具）；适量运动；远离酒/大麻/毒品；注意个人卫生与饮食
每周	称重 1 次；复盘睡眠与情绪/社交状态；做 3–5 次中等强度运动；整理本周服药是否规律
每月	测血压、腰围；核对药是否备足、有无漏服；回顾有无预警信号；记录身体与情绪变化
每次复诊	谈睡眠/情绪/社交/工作；报告副作用与漏服；查体重、血糖、血脂、泌乳素、心电图等（按医嘱）；讨论是否调整治疗与预警计划
每年	年度全面体检（含心血管、代谢）；牙科检查；按建议接种疫苗；全面复盘康复目标

> **一句话记住**：康复不是靠"哪天突然想通"，而是靠每天按时吃药、睡好觉、不碰酒和毒品、定期复诊这些不起眼的小事，年复一年地守住。

参考来源

- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》 https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- 中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组：《精神分裂症患者代谢综合征管理的中国专家共识》，《中华精神科杂志》2020,53(1):3-10。全文 https://training.yiigle.com/uploads/guide_html/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%88%86%E8%A3%82%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85%E4%BB%A3
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 世界卫生组织：mhGAP Intervention Guide https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

4. 社会功能康复

> **核心结论：社会功能恢复是精神分裂症康复的最终目标，而且它往往**晚于症状改善——**幻觉妄想消失了，不代表马上能上班、能社交。** 功能康复是阶梯式的、允许反复的，目标不是"完全变回生病前"，而是"在自己重视的生活里重新站住"。

一、为什么功能恢复可以很慢

【临床共识】【研究结论】

- 症状（阳性）常在治疗后数周内改善，但**阴性症状、认知损害、长期退缩造成的"技能生疏"**恢复得慢。
- 长期住院、辍学、失业本身会让社会功能进一步退化，因此**越早、越小步地重新接触社会，越有利于功能恢复**——但前提是病情稳定、节奏可控。
- 功能康复的目标是"生活质量与个人角色"，而非和健康人比效率。

二、居家生活技能（先把"一个人能过好日子"练起来）

从最基础的独立生活能力开始，**分步训练、逐项过关**：

- **个人卫生**：定时洗漱、洗澡、理发、更衣；
- **做饭与饮食**：从热一份现成饭菜 → 简单煮食 → 独立做一餐；
- **购物**：列清单、认价格、找零、避开冲动消费；
- **理财**：记账、管理月度生活费、大额支出与本人/家属商量；
- **用药自理**：自己按时服药、记录、知道漏服怎么办（这是功能康复的核心一项）；
- **家务**：扫地、洗碗、整理房间、洗衣服。

方法：把一个技能拆成小步骤，逐项练习、及时肯定；不要一下子要求"全部自己来"。

三、社交重建

- **从家人开始 → 小圈子 → 更大范围**：先恢复和家人的日常交流，再到一两个熟人，再到小组活动，不要急于"变回社交达人"。
- **社交技能训练**：打招呼、发起与结束对话、眼神与语气、表达拒绝、表达需求（配合 5.2 的社交技能训练）。
- **应对病耻感**：学习如何向别人解释、是否透露病情的选择权在本人；必要时练习"在工作/学校不完全暴露病史"的沟通策略。

四、学习支持（复学）

- **复学节奏**：病情稳定后，从**减量、半天、弹性作息**开始，而不是直接满负荷；与学校、老师提前沟通。
- **与学校沟通**：在本人同意下，说明需要的"合理便利"——如允许分次请假、延长考试时间、少一些当众发言、固定安静环境。
- **防复发边界**：考试季压力大时要格外关注睡眠与情绪；出现预警信号及时和医生、家长沟通，必要时休学/降级而非硬撑。

五、就业支持

【研究结论】就业是功能康复的制高点，也是最容易失败的一步，需要稳扎稳打：

- **先评估再启动**：病情稳定、药物副作用可控、作息规律后再考虑；不要在复发恢复期立刻求职。
- **推荐路径**：从**志愿者 → 兼职/弹性/简单岗位 → 过渡性就业 → 辅助就业（IPS）→ 稳定的竞争岗位**，一步一台阶。
- **辅助就业（IPS）**："先安置、后培训"，在真实岗位上配持续支持，是证据最强的模式。
- **工作场所调适**：与可信任的主管做有限沟通，调整任务强度、避免夜班与过度压力、允许逐步适应。
- **职业倦怠与复发边界**：学会识别"撑不住"的信号（睡眠恶化、易怒、退缩），及时减量、休假或就医，而不是硬到复发。

六、社区资源

国内可利用的社区康复资源（各地名称不同）：【临床共识】

- **社区康复站/日间照料中心**：白天来活动、训练、社交，晚上回家；
- **康复会所（Clubhouse）**：会员平等参与、过渡性就业；
- **工疗站/庇护性就业**：简单劳动 + 康复 + 少量报酬；
- **严重精神障碍社区管理**：由社区卫生服务中心随访、指导（见国家《严重精神障碍管理治疗工作规范》）；
- 公益组织与同伴支持小组。

七、功能康复领域汇总表

功能领域	阶段目标	训练方法	可利用资源
居家自理	个人卫生、饮食、家务、用药自理	分步训练、日常提醒、即时肯定	家庭、社区康复站
理财购物	独立记账、管生活费	记账练习、清单购物	家属协助、社区
社交	从家人到小圈子到群体	社交技能训练、角色扮演	小组训练、会所、同伴
学习	弹性复学、合理便利	减量复学、与学校沟通	学校、家长、医生
就业	志愿→兼职→竞争岗位	IPS 辅助就业、岗位调适	康复站、工疗、公益职介
情绪/压力	识别与应对压力	放松训练、预警计划	心理治疗、家庭干预

八、家属如何"支持而不包办"

- **支持**：陪练技能、提供稳定环境、在本人同意下协助；
- **不包办**：不要替患者做所有决定、不让其长期"躺平"享受照顾——适度自主感是康复的动力；
- **允许反复**：一次社交失败、一次辞职、一次病情波动，都不代表康复失败，而是回到上一个台阶重新来。
- **把"你能自己做什么"放在"你还不能做什么"前面**，多肯定微小进步。

> **一句话记住**：康复不是"回到从前"，而是"一步步重新拥有自己的生活"——先照顾好自己，再联系几个人，再学一项技能，再试着做点事。台阶可以慢，但方向是向前的。

参考来源

- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》 https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南》（第二版，2015；2025版已更新），版本报道见 中南大学新闻网 https://news.csu.edu.cn/info/1003/162589.htm
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

5. 风险内容

> **核心结论：风险是可以评估、可以管理的，既不能恐慌（"患者都是危险分子"是污名），也不能侥幸（"不会有事"而不做任何准备）。** 精神分裂症患者**绝大多数是暴力的受害者而非施加者**；但在特定急性状态下，自伤、伤人、拒食拒药等风险确实会升高，家属需要知道：看什么信号、怎么应对、什么时候打 120 / 110。

一、先纠正两个极端

- **误区一（恐慌）**：得了精神分裂症就一定会打人、会被关起来。**事实**：总体而言，精神分裂症患者的暴力风险**并不高于普通人群**；风险升高主要集中在**急性发作期伴被害妄想、命令性幻听、物质使用**等特定情形。【研究结论】
- **误区二（侥幸）**："我家人肯定不会出事""问问就行不用送医"。**事实**：风险信号被忽视、求助延迟，是悲剧最常见的原因。

> 态度：**在病情稳定期按长期康复管，在风险信号出现时果断按危机处理。**

二、自伤 / 自杀风险

【研究结论】精神分裂症患者的自杀风险**高于普通人群**，是早亡的重要原因之一。

高危时期与情形：

- 发病早期、对诊断还难以接受时；
- **住院后不久、或刚出院后**（研究提示这一阶段风险并不低）；
- 伴随**明显抑郁、绝望**；
- 出现**命令性幻听**（"让你伤害自己"）；
- 合并物质使用；
- **自知力恢复、意识到患病后果，伴强烈绝望**时。

预警信号：

- 表达"活着没意思""是家人的负担"；
- 突然安排后事、赠送心爱物品、写告别内容；
- 情绪从极度痛苦突然"平静下来"（可能已下定决心）；
- 收集、接触危险物品；
- 既往有自伤/自杀行为。

评估与防范：

- **直接、平静地问**："你现在有没有想伤害自己？有没有计划？"——询问不会诱发自杀，回避才危险。
- **危险品管理**：在高风险期，把刀具、药品、绳索、高处、阳台等危险来源收管或加装防护（在本人同意和尊严范围内）。
- **保持陪伴**，不让其独处；
- 有明确计划或准备行为时，**立即送精神科急诊 / 拨打 120**，不要"在家观察几天"。

三、伤人 / 冲动风险

【研究结论】【临床共识】

- 总体暴力风险不高于普通人群；**升高主要见于**：急性发作期、**被害妄想**（"先下手为强"）、**命令性幻听**、**物质（酒/毒品）使用**、既往有冲动或暴力史。

预警信号：

- 多疑、被害妄想加重，指向某个具体的人；
- 情绪激越、语速快、踱步、骂人、拍东西；
- 幻听内容变成指使性的；
- 饮酒/吸毒后明显失控；
- 曾有威胁性言语或砸东西行为。

应对原则（现场）：

1. **不正面争辩、不戳穿妄想**："你觉得有人害你，我们先一起想想办法"——当面对抗只会激怒；
2. **保持安全距离、留好出口**：站在能撤离的位置，不要堵在门口；
3. **移除可见的武器/硬物**（在确保自身安全前提下）；
4. **不要独自强行控制、不要围拢围观**；
5. **及时求助**：现实人身安全威胁下拨打 **110**；需要医疗处置时拨打 **120**；尽快联系主治医生/精神科急诊。

四、拒食拒药 / 木僵的躯体风险

- **紧张性木僵、缄默、拒食拒饮**：看似"安静"，实则可能迅速出现**脱水、营养不良、压疮、躯体衰竭**，是需要尽快医疗干预的急症。【临床共识】
- **拒药、藏药**：不仅导致复发，还可能在急性状态下完全失控；需耐心沟通、必要时由医生评估是否改用长效针剂或住院。
- **持续高热、严重肌肉僵硬、意识改变**：警惕**恶性综合征（NMS）**，立即急诊。

五、走失风险

- 自知力差、定向障碍或受幻听妄想支配时，患者可能离家走失。
- 应对：随身放置**写有联系人电话的卡片/手环**；了解其常去地点；走失后尽快报警（不必等"24 小时"的旧观念，老人/患者走失应立即求助）并告知警方病情。

六、危机处理原则与流程

总原则：安全第一 > 医疗处置 > 事后复盘。

1. **先判断安全**：现场是否有刀、有人身危险？有没有人受伤？
2. **该打哪个电话**：

- **120**：自伤/伤人已受伤、昏迷、木僵拒食、高热僵硬、需要医疗；
- **110**：现场有现实暴力威胁、持械、患者不听劝阻且有伤人可能、走失；
- **精神科急诊 / 主治医生**：风险上升但尚未到立即危险，尽快评估。

1. **送医准备（提前备好一个"就医包"）**：

- 身份证 / 医保卡、既往病历与出院小结；
- **正在服用的药物清单**（药盒拍照也可）；
- 近期症状与行为变化的简要记录；
- 换洗衣物、水杯等。

1. **陪伴与沟通**：简短、平静，减少刺激和围观；不要许诺"不送医院"，也不要用吓唬的话。
2. **事后复盘**：危机平息后，和医生一起分析"为什么会这样、哪个信号被漏了"，**更新预警计划**（见 2. 复发预警信号），而不是互相指责。

七、家属自身的安全

- 家属不是"全天候保镖"，**不要把自己置于持续危险中**；
- 激越、暴力风险上升时，**优先撤离并求助**，不要独自硬扛；
- 长期照护压力巨大，家属自己也需要喘息、支持和（必要时）心理帮助；
- 了解本地**强制医疗/非自愿住院**的法律边界：严重危害自身或他人安全时，依法送医是保护，不是"不仁"。

八、风险情形与即时处置速查表

风险情形	关键信号	即时处置
自杀/自伤	绝望言语、安排后事、收集危险品、命令性幻听	移除危险品、陪伴、直接询问、立即急诊/120
伤人冲动	被害妄想指向某人、激越、持物、酒/毒后失控	不对抗、留出口、移武器、求助 110/120
木僵拒食	不语不动、拒食拒饮、日渐衰弱	尽快送医，防脱水衰竭
恶性综合征	高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗	**立即急诊**（危重）
走失	离家未归、定向差	报警求助、提供病情、随身联系卡
药物相关急症	严重过敏、昏厥、严重便秘腹痛、黄疸	停药相关不适立即就医

> **一句话记住**：稳定期好好康复，信号期果断就医；现场先保安全、再打对电话、备好病史药物——风险可管理，不必恐慌，也不能侥幸。

参考来源

- 世界卫生组织：Suicide 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
- 世界卫生组织：mhGAP Intervention Guide https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- NICE 指南：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178) https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 国家卫生健康委：《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》（含风险评估与应急处置） https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

常见谣言澄清

> 本页用于澄清社会上对精神分裂症最常见的误解，目的是减少病耻感、鼓励及时就医。所有医学结论以精神科执业医师评估为准；本页不构成诊断或治疗建议。

精神分裂症是一种需要规范治疗的重性精神障碍，但围绕它的谣言很多来源于影视作品、旧观念和个案新闻的以偏概全。下面逐条用"谣言 vs 事实"的方式澄清，并给出听到谣言时可以怎么回应。

一、谣言 vs 事实对照表

常见谣言	事实	证据标注
"得这个病的就是疯子，没救了。"	"精神分裂症"是疾病名称，不是人格标签。"疯子"是带有侮辱性的旧称，会让患者和家属不敢就医。规范治疗下，相当一部分人症状缓解、可以回归生活。	【临床共识】
"精神分裂症患者都是暴力分子、会犯罪。"	总体上，患者的暴力风险并不高于普通人群；患者自身更常是暴力和歧视的**受害者**而非施害者。仅在急性发作期合并特定症状（如命令性幻听、被害妄想）或同时存在物质（酒精、毒品）使用时，暴力风险才会升高，且这是可以通过治疗控制的。不能凭诊断标签判断某个人是否危险。	【研究结论】
"这是鬼神附身、中邪、被脏东西缠上。"	这是没有科学依据的解释。宗教或民俗慰藉可在不伤害、不延误医疗的前提下作为心理支持，但不能替代专业诊疗，更不能以此羞辱、拘禁或用"驱邪"方式治疗。	【临床共识】
"就是单纯心理问题、想不开、心眼小。"	精神分裂症有明确的生物学基础（神经发育、神经递质、遗传等多因素），不是"想开点"就能好，也不是单纯靠心理咨询能治愈的。心理社会因素只是诱因之一。	【临床共识】
"是父母教养失败、性格有缺陷造成的。"	病因是多因素的，不能归咎于父母或患者本人。这种归因会造成家属自责和家庭内耗，反而不利于康复。	【临床共识】
"一得病就终身废了，不能工作、不能成家。"	不对。是否能工作、独立生活因人而异。在规范治疗、长期随访和支持下，部分患者可以稳定生活、复学复工、建立家庭；也有一部分人需要长期支持。诊断不等于劳动能力的丧失。	【研究结论】
"吃药越吃越傻、把人吃呆。"	抗精神病药可能有嗜睡、锥体外系反应、体重增加等副作用，但合理选药和剂量下，多数人可以正常生活。"傻"更多是急性期症状本身、或药物未调整到合适剂量造成的，可与医生沟通换药调量，而不是自行停药。	【临床共识】
"靠意志力就能停药，是药三分毒。"	不能靠意志力自行停药。骤停抗精神病药会引起撤药反应，并显著升高复发风险；多数复发与不规律服药有关。是否减停必须由精神科医生评估。	【临床共识】
"电休克（MECT）是酷刑，会把人电坏。"	现代无抽搐电休克治疗（MECT）是在麻醉、肌松下进行的规范医疗手段，用于难治性、高自杀风险或紧张症等情况，有明确适应证，不是惩罚性"酷刑"。	【临床共识】
"这就是懒、小心眼、装病。"	患者的退缩、少语、不想动常是阴性症状（意志减退、快感缺失）的表现，是疾病的一部分，不是道德上的懒。	【临床共识】

二、为什么这些谣言危害很大

【研究结论】污名本身会带来一连串实际伤害：

- **延误就诊**：因为怕被叫做"疯子"，患者和家属迟迟不就医，错过早干预的黄金期。
- **社交隔离**：被疏远、被议论，进一步加重阴性症状和抑郁。
- **就业与教育歧视**：能力被否定，丧失回归社会的机会。
- **自我污名**：患者内化了"我没救了"的想法，放弃治疗和康复。

三、听到谣言时可以怎么回应（话术示例）

- 听到"他就是个疯子"：

> "那是一种病，跟高血压、糖尿病一样需要看医生，不能用'疯子'这种词说人。"

- 听到"是不是家里风水/中邪"：

> "迷信的说法帮不了他。这是有医学原因的，及时去精神卫生中心看病才是正经事。"

- 听到"别跟他来往，危险"：

> "大多数患者并不危险，反而是更容易被欺负的一方。真正需要担心的是没看病、没吃药的状态，治好了跟正常人一样生活。"

- 听到"吃药不好，停了吧"：

> "药能不能停得问医生，自己停很容易复发，之前的治疗就白费了。"

- 听到"就是想不开，开导开导就行"：

> "这不是心理问题，心理咨询治不了急性发病，得先看精神科、规范用药。"

四、更尊重的语言

- 说"精神分裂症患者 / 康复者 / 患有精神分裂症的人"，而不是"疯子""癫子""神经病"（"神经病"在医学上指神经系统疾病，与精神疾病不同）。
- 不要说"人格分裂""多重人格"——那是另一种病（解离性身份障碍），与精神分裂症不是一回事。
- 报道或谈论新闻事件时，不要在没有证据的情况下把犯罪行为归因于精神疾病；也不要展示患者发病时的丑态。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：mhGAP 精神卫生差距行动规划
- 国家卫生健康委：精神障碍诊疗规范（2020年版）相关页面
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

家属照护难点

> 家属是患者最重要的支持系统，但长期照护对家属自身也是巨大消耗。本页帮助家属理解自己的压力、掌握沟通技巧，并提醒：照顾好自己，才能照顾好患者。本页为科普与经验整理，具体诊疗决策请遵精神科医生意见。

一、家属常见的心理压力

【个人经验/临床观察】长期面对一名精神分裂症患者，家属普遍会经历以下情绪，出现这些感受是正常的，不代表你"不孝"或"失败"：

- **自责**："是不是我当年管教不好、给他压力太大了？"——实际上病因是多因素的，不应归咎于父母或家庭。
- **羞耻**：怕被邻居、亲戚、单位知道，遮遮掩掩，回避社交，家庭长期处于"保密"压力下。
- **焦虑**：担心复发、担心出意外、担心自己老了以后谁来管。
- **耗竭（照护倦怠）**：长期睡眠被打乱、24小时精神紧绷，出现疲惫、麻木、易发火。
- **悲伤**：为原本期待的人生轨迹改变而难过（孩子没能正常上学、家人没能正常工作）。
- **家庭/兄弟姐妹矛盾**：谁多照顾、谁多出钱、谁来陪诊，容易产生争执。

二、长期照护对健康与经济的影响

【研究结论】大量研究显示，长期照护者自身抑郁、焦虑、躯体疾病的比例偏高，经济负担也较重。因此：

- 照护不是"一个人扛到底"，要学会**分工、轮班、使用外部资源**（社区、康复机构、喘息服务）。
- 定期关注家属自己的身体和情绪，必要时家属也寻求心理咨询或就医。

三、沟通技巧：最重要的几条原则

【临床共识】急性期患者可能有妄想、幻听，此时讲道理、争辩往往无效，甚至激化情绪。核心原则是**"共情情绪，不争辩内容"**：

1. **不争辩妄想内容**：不要反复说"你想多了、根本没这回事"。患者在病中坚信不疑，争辩只会让他觉得你也"不可信"。可以说："我听到你这么说，你一定很害怕/很难受。"
2. **不纵容，也不对立**：既不顺着妄想一起夸大，也不激烈反驳。温和地转移注意力即可。
3. **共情情绪，而非认同结论**：认可他的恐惧、愤怒是真实的感受，但不必认可那个"结论"（如"有人害你"）。
4. **低声、慢速**：患者激越时，用比平时更低、更慢、更平稳的声音说话，不要提高音量。
5. **一次只说一件事**：信息太多会让患者困惑。短句子、一次一个指令。
6. **给简单选择而非命令**："现在是先喝口水，还是先坐下歇会儿？"比"你赶紧吃药"更容易被接受。

四、如何避免"高情感表达（High EE）"

【研究结论】家庭"高情感表达"——即过度卷入、频繁批评、敌意指责——被多项研究证实与较高的复发率相关。家属应注意避免：

- **过度卷入**：什么都替他做、时刻盯着、为一点小事情绪剧烈波动。
- **频繁批评与指责**：反复数落"你就是不争气""你对得起谁"。
- **敌意**：把患者当"麻烦""累赘"对待。

改善方向：保持稳定、平和、适度的关心；既不冷漠，也不过度紧张。这种"低EE"的家庭氛围本身就是降低复发的保护因素。

五、服药监督中的张力与对策

家属常陷入"催他吃药就吵、不催又怕复发"的两难：

- **张力**：患者常因自知力缺失、药物副作用而拒药，家属强行喂药易引发冲突。
- **对策**：
- 用**药盒、闹钟、手机提醒**把服药变成固定习惯，减少每天的"拉锯"。
- 把服药和日常固定动作绑定（如早饭后、睡前）。
- 发现副作用（如嗜睡、手抖、发胖）**记录下来，复诊时告诉医生**，由医生调整，而不是自行减药。
- 与患者约定："你觉得难受，我们一起找医生调，而不是自己停。"
- 对反复拒药者，与医生讨论**长效针剂**（每月/数月一次）的可行性，从根本上减少漏服。

六、患者拒绝就医时怎么办

【临床共识/法律原则】我国以**自愿诊疗为原则**。多数情况下应耐心劝说、陪伴就医，而不是强行捆绑。

- **优先做的**：共情他的顾虑（"你怕吃药副作用，我们可以去跟医生聊"）、由他信任的人陪同、先从"看看睡眠/情绪"等低门槛理由切入。

- **必须就医但患者拒绝**：若患者存在伤害自身或他人的风险，属于《精神卫生法》规定的**非自愿住院**法定情形（详见"法律与权益"页），此时应联系精神卫生机构、急救或公安，由专业人员依法处置，家属不要独自采取强制措施。
- 注意：非自愿住院有严格法定条件和程序，不是家属想送就能送、也不是想接就能接，具体以医疗机构和当地规定为准。

七、家属也需要支持与喘息服务

- **家属互助组织**：参加患者家属互助小组（如各地精协家属组织），和有相似经历的人交流，能显著减轻孤独感。
- **喘息服务**：部分地区有短期托养、社区康复站，让家属能短暂抽身休息。
- **照护边界**：你不是24小时的看护机器。保留自己的工作、爱好、社交和睡眠时间，是可持续照护的前提。

八、"该说 / 不该说"话术对照表

场景	可以这样说	避免这样说
患者谈妄想（"有人跟踪我"）	"我知道你现在很害怕。我们先坐下，慢慢说。"	"根本没有的事，你又胡想！"
患者出现幻听、自言自语	"你是不是又听到声音了？难受的话我们去问问医生。"	"别装了、你演什么演。"
拒绝服药	"你是怕药不舒服吗？我们记下来，下次问医生能不能调。"	"不吃就别想出门/你怎么这么不懂事！"
不愿复诊	"就去开个药、让医生看看你睡得好不好。"	"你不看医生就完了！"
情绪激动、发脾气	（降低音量）"我在这儿，你先深呼吸，不急。"	（对吼）"你还敢发火？！"
整日卧床、什么都不做	"要不要一起下楼走十分钟？"	"你就是懒、烂泥扶不上墙。"
指责家人	"我听到你的委屈了，我们一个一个说。"	"我们为你付出这么多，你还不知足？"

参考来源

- 世界卫生组织：mhGAP 精神卫生差距行动规划
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- 国家卫生健康委/中国政府网：《中华人民共和国精神卫生法》
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

法律与权益

> 本页为一般性法律与政策科普，**不构成法律意见，也不替代具体办理。**精神卫生领域的法律流程和地方政策会更新，且各地执行口径不同；办理残疾证、医保、就业等具体事项时，务必以现行法规原文及当地残联、医保局、民政局、人社部门的最新答复为准。法条编号请以国家法律法规数据库正式文本为准。

精神分裂症患者首先是具有完整人格尊严与各项法定权利的公民。疾病诊断本身**不自动等于**丧失民事行为能力、劳动能力或就医自主决定权。下面按家庭最常遇到的几类问题梳理。

一、《中华人民共和国精神卫生法》要点

【现行法律框架】该法确立了我国精神卫生工作的基本制度，家庭最需要了解的有以下几点：

- **诊疗自愿原则**：精神障碍的诊疗以自愿为一般原则。患者本人可以自主决定是否就诊、是否住院（除法定的非自愿情形外）。
- **非自愿住院的法定条件**：只有在符合法定情形（如已发生伤害自身的行为、或有危害他人安全的危险，且经诊断为严重精神障碍等）时，才可依法实施非自愿住院/约束。这是有严格条件和程序的例外，**不是家属想送就能送、想强制就能强制。**具体情形和程序以法律原文及医疗机构认定为准。
- **送医主体**：一般情况下由近亲属送往；查找不到近亲属的流浪疑似人员等有专门规定；有伤害他人危险等情形，可由当地公安机关等依法送诊。
- **知情同意**：患者及其监护人有权了解病情、诊断、治疗方案、风险和费用；实施特定治疗（如手术、实验性临床医疗）有更严格的知情同意要求。
- **不得非法限制人身自由**：禁止利用限制性措施惩罚患者，约束/隔离只能出于医疗安全目的并按规定使用。
- **康复与反歧视**：法律要求各级政府支持精神障碍患者康复，禁止歧视精神障碍患者及其家属；在就业、教育、居住等方面不得歧视。
- **隐私保护**：精神卫生工作中知悉的患者姓名、肖像、住址、工作单位、病史等信息，**应当予以保密**，不得泄露（法律另有规定除外）。

二、民事行为能力与监护（民法典相关制度）

【现行法律框架】

- **民事行为能力三分法**：成年一般为完全民事行为能力人；**不能完全辨认**自己行为的成年人为限制民事行为能力人；**不能辨认**自己行为的成年人为无民事行为能力人。是否属于后两种，须经**利害关系人申请、由人民法院依法认定**——不是家属或单位凭诊断证明自行宣布"他没有行为能力"。
- **监护制度**：无/限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：配偶；父母、子女；其他近亲属；其他愿意担任监护人且经相关部门同意的个人或组织。
- **监护人职责**：代理被监护人实施民事法律行为，保护其人身、财产等合法权益；应**最大程度尊重**被监护人的真实意愿，保障并协助其实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，不得处分其财产损害其利益。
- **重要提醒**：多数病情稳定的患者仍具有完全或限制民事行为能力，可自己决定日常事务、管理财产、签署合同；只有在需要时才启动监护认定程序。

三、残疾人权益：精神残疾与残疾人证

【现行政策框架】

- **精神残疾评定**：精神分裂症患者在病情稳定一段时间后，可申请**精神残疾评定。**残疾等级一般按对日常生活的影响分为**一级（极重度）到四级（轻度）**，由指定的残疾评定机构按标准评定，不是凭诊断证明自动定级。
- **残疾人证申请流程（各地略有差异）**：一般为——

1. 向**户籍所在地或居住地的社区/县级残联**提出申请；
2. 提交身份证、户口簿、相关病历资料等；
3. 到指定医疗机构进行残疾评定；
4. 审核、公示、发放《中华人民共和国残疾人证》。

- **持证后可享的权益（举例，以当地为准）**：公共交通优惠、景区减免、就业扶持、按比例就业政策、部分地方的护理补贴/生活补贴（"两项补贴"）、康复救助等。
- 依据《中华人民共和国残疾人保障法》，残疾人在康复、教育、劳动就业、文化生活、社会保障、无障碍环境等方面享有权利，禁止基于残疾的歧视。

四、医保与医疗救助政策

【现行政策框架，各地差异大】

- **门诊慢特病（特殊病种）**：多数地区已将精神分裂症纳入**门诊慢特病/门诊特殊病种**管理，符合条件者可申请，门诊取药、复查也能按较高比例报销，减轻长期服药负担。**能否申请、如何认定，咨询当地医保局或就诊医院医保办。**
- **住院报销**：按基本医保（职工/居民）政策报销；重性精神疾病患者的住院费用部分地区有专门保障政策。
- **严重精神障碍管理治疗项目（"686项目"等）**：国家面向登记在册的严重精神障碍患者提供免费服药、随访管理等服务，由基层精防医生/社区卫生服务中心执行，可向当地精神卫生机构或社区咨询是否纳入。
- **医疗救助**：对符合条件的困难家庭（低保、特困、返贫致贫等），可向**民政局**申请医疗救助，对医保报销后个人负担部分给予补助。

> 重要提示：医保起付线、报销比例、慢特病病种目录、救助标准**因省、市、参保类型不同而差别很大**，本页不列举具体数字；办理时直接问"本地精神分裂症的门诊慢特病怎么办、有哪些救助"。

五、就业权益

【现行法律框架】

- 依据《就业促进法》《残疾人就业条例》等，国家保障残疾人劳动权利，**禁止就业歧视**；用人单位不能因残疾（含精神残疾）拒绝录用或违法解除劳动合同，除非岗位确有法定职业禁忌。
- **按比例就业**：用人单位安排残疾人就业需达到规定比例（各地比例不同，常见为不低于在职职工总数的一定比例，如1.5%左右），不达标的缴纳残疾人就业保障金。这是持证残疾人就业的重要政策通道，可咨询当地残联就业服务机构。
- **合理便利**：对适合的岗位，可与单位协商合理的工作安排（如弹性作息、减少夜班等）。
- **解除合同的限制**：因患病不能从事原工作的，单位依法需经过调岗、提前通知或支付补偿等程序（依劳动合同法一般规定），不得随意辞退；发生争议可申请劳动仲裁。
- **披露的边界**：病史属于隐私，本人可权衡后决定是否告知雇主；不主动披露不等于隐瞒法定应告知事项。

六、教育、住房与其他社会保障

- **教育**：保障适龄精神障碍患者（含康复期、残疾学生）的受教育权，不得歧视；残疾学生可申请教育资助、合理便利。
- **住房**：符合条件的困难残疾人可享受住房保障、公租房优先安排等（各地政策）。
- **低保与困难补贴**：家庭人均收入低于当地标准的，可向民政局申请最低生活保障；重度残疾人等可单独施保、残疾人两项补贴等，具体咨询街道/乡镇民政窗口。

七、个人信息与隐私保护

【现行法律框架，依据《个人信息保护法》《精神卫生法》】

- 病历、诊断信息属于**敏感个人信息**，医疗机构及其人员负有保密义务。
- 谁可以知情：原则上为患者本人；无/限制民事行为能力人的监护人可依法知情。单位、学校、其他亲属**无权**未经授权调取或知悉患者病情。
- 家属在社交圈、亲友间谈论病情也应注意保密，避免造成二次伤害和歧视。
- 科普、案例分享、网络发帖应做**去标识化**处理，不公开可识别的身份信息，最好事先取得本人同意。

八、维权途径

- 与医院/单位发生争议：先与当事机构沟通，可向其上级主管部门（卫健委、人社部门）投诉。
- 法律援助：经济困难需要律师服务的，可向当地**法律援助中心**申请（12348公共法律服务热线）。
- 具体政策咨询：当地**残联、医保局、民政局、人社局、卫生健康委**窗口或政务服务热线**12345**。
- 人身安全/紧急医疗：拨打**120**急救或**110**报警。

九、办理前自查清单

- [ ] 先通过 **12345** 或当地政务网问清"本地怎么办"，不要只凭网上旧信息。
- [ ] 带齐身份证、户口簿、病历、诊断证明、检查报告（多复印几份）。
- [ ] 残疾评定要到**指定机构**，问清是否需要提前预约、近期是否需停药/服药状态。
- [ ] 保留所有书面答复、受理回执和办理记录。

参考来源

- 国家法律法规数据库：中华人民共和国精神卫生法
- 国家法律法规数据库：中华人民共和国民法典（监护、民事行为能力部分）
- 国家法律法规数据库：中华人民共和国残疾人保障法
- 中国政府网/国家医保局：门诊慢特病及医疗救助相关政策
- 中国残疾人联合会：残疾人证办理与两项补贴指南
- 全国公共法律服务热线：**12348**；政务服务热线：**12345**

大众科普方向

> 本页面向想做科普、做反污名工作的人（家属、志愿者、基层工作者、媒体、学生）。核心目标：让公众用医学的眼光看待精神分裂症，减少歧视，鼓励患者及时就医。所有医学表述以权威来源为准，避免猎奇和夸大。

一、污名从哪里来，危害是什么

【研究结论】对精神分裂症的污名主要来源于：影视和新闻中把患者塑造成"暴力、危险、疯狂"的刻板形象；把疾病道德化（"疯子""活该"）；以及把精神疾病与鬼神、中邪等旧观念绑定。它带来的实际危害是：

- **延误就诊**：怕被贴标签，硬扛到很严重才就医，错过早期干预窗口。
- **社交隔离**：被邻居、同学、同事疏远。
- **就业/教育歧视**：能力被预先否定。
- **自我污名**：患者内化"我是废人"，放弃治疗和康复努力。

二、有效科普的原则

1. **用医学语言**：说"这是一种大脑疾病、有生物学基础、可以规范治疗"，而不是渲染"疯狂""恐怖"。
2. **患者视角**：尽量包含患者和家属的真实声音（经授权、去标识化），让公众看到"他是一个具体的人，不只是一个病名"。
3. **数据与故事结合**：用数据纠正"都很暴力"的印象，用故事传递人性温度。
4. **避免猎奇与刻板印象**：不拍发病时的丑态、不把幻听妄想当"灵异故事"讲。
5. **不渲染暴力**：不要拿"精神病杀人"当科普的噱头——那既不准确，又加深污名。
6. **给出路**：科普的落点是"可以治、可以康复、请这样对待他们"，而不是"很可怕、躲远点"。

三、不同受众的科普重点

受众	重点	适合形式
中小学生/大学生	这是病不是"怪人"；同学病了怎么相处；有情绪问题找谁	主题班会、短视频、情景剧、匿名问答
职场人	患病不等于不能工作；合理便利；发现自己/同事异常怎么办	企业EAP讲座、海报、员工手册
社区居民	不要围观议论、不要排斥邻居；出现异常先联系家属和社区精防医生	社区宣传栏、居委会宣讲、热线卡片
媒体从业者	危机报道规范（见下）；不披露身份、不简单归因	报道手册、采编培训
基层医生/村医	识别早期信号、转诊渠道、随访管理	继续教育、病例督导

四、媒体报道指南

【临床共识/行业规范】涉及精神疾病或相关突发事件的报道，建议遵守：

- **不披露身份**：不点名、不打可识别的马赛克、不公开住址、工作单位、家属信息。
- **不简单归因**：在警方/司法结论出来前，不要把案件直接归因于"精神病发作"。
- **不展示发病丑态**：不偷拍、不播出发病失控的画面博眼球。
- **危机报道规范**：不细节化描写自杀/暴力手段（模仿效应）；报道中应附上求助热线。
- **避免标签化用语**：用"一名患有精神分裂症的人"，而不是"一个疯子/神经病"。

五、接触式反污名干预的证据

【研究结论】大量社会心理学研究显示，**单纯讲道理的科普效果有限**；最有效的反污名干预是**接触式**的——让公众与康复者/家属在安全、结构化的场合面对面交流（听康复者讲述、问答互动）。直接接触能显著降低恐惧和偏见。这也是为什么"康复者现身说法"比"专家念PPT"更能改变态度。

六、语言指南（以人为本的表述）

- 说"**精神分裂症患者 / 康复者 / 患有精神分裂症的人**"，而不是"疯子、癫子、神经病、呆子"。
- 说"**一个人正在经历精神病性症状**"，而不是"他疯了"。
- 说"**康复中的人**"，而不是"永远的病人"。
- 不要把疾病当人格："他得了精神分裂症" ≠ "他是个分裂的人"。

七、每个人能做什么

- 不用侮辱性词汇，听到别人说时温和纠正。

- 不把患者当异类，正常打招呼、正常相处。
- 遇到发病的人：不围观、不拍摄，必要时帮他联系家属或拨打求助电话。
- 转发靠谱的科普，而不是"精神病杀人"类的猎奇新闻。
- 家里有患者时，不必"隐瞒一切"，在信任的小圈子里适度说明，反而能减少孤立。

八、推荐的科普渠道与作品类型

- 权威渠道：国家卫健委、各地精神卫生中心公众号、世界卫生组织中文资料、权威医院（如北医六院、上海市精神卫生中心）的科普账号。
- 作品类型：康复者口述短片、图文漫画、问答长图、校园情景剧、热线口袋卡。
- 避雷：凡是承诺"根治""祖传秘方""心理开导就能好"、渲染暴力恐怖的内容，都不适合传播。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- 世界卫生组织：Mental health of adults（消除污名相关资料）
- 国家卫生健康委：12356全国统一心理援助热线相关通知
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

权威来源标注

> 本资料库的每条重要结论都应能追溯到可靠来源。本页列出精神分裂症领域最值得信赖的一手/权威来源及其获取方式，并教你区分"权威来源"和"营销/谣言网站"。

一、为什么要标注来源

【临床共识】网络上关于精神分裂症的信息良莠不齐，很多是营销号、偏方、玄学内容。学会认权威来源，才能避免被"根治秘方""心理开导治愈"这类说法误导。标注来源也是本资料库的基本纪律。

二、核心权威来源清单

来源	机构/性质	主要用途	获取方式
ICD-11	世界卫生组织（WHO）	国际疾病分类，精神分裂症的官方诊断定义	WHO官网（icd.who.int）
WHO 精神分裂症事实清单（Fact sheet）	WHO	面向公众的权威简明介绍	who.int/news-room/fact-sheets
mhGAP 指南	WHO	资源不足地区精神、神经及物质使用障碍的管理指南	who.int/publications
DSM-5 / DSM-5-TR	美国精神病学协会（APA）	另一套国际常用诊断分类（与ICD并列）	APA官网 / 正式出版物
NICE CG178	英国国家卫生与临床优化研究所	成人精神病性障碍与精神分裂症的诊疗与管理指南（循证、更新及时）	nice.org.uk/guidance/cg178
《中国精神分裂症防治指南（第二版）》	中华医学会精神医学分会（赵靖平、施慎逊主编，2015）	国内临床诊疗的主要参考	正式出版物（中华医学电子音像出版社）
《精神障碍诊疗规范（2020年版）》	国家卫生健康委员会	国内官方诊疗规范	国家卫健委官网
中华医学会精神医学分会 / 中国医师协会精神科医师分会	国内权威学术组织	专家共识、学术动态	学会官网
权威期刊：Lancet Psychiatry、World Psychiatry、American Journal of Psychiatry、Schizophrenia Bulletin、中华精神科杂志	同行评审学术期刊	最新研究、综述	PubMed / 期刊官网

> 说明：国内《中国精神分裂症防治指南》目前公开广泛引用的是**2015年第二版**；此后国家卫健委另有2020年版诊疗规范，学术上也持续有新综述。引用时请注明版本和年份，并注意**指南会随证据更新**，以最新版为准。

三、循证数据库与检索工具

- **Cochrane Library**：系统评价的金标准，回答"某干预到底有没有效"。
- **PubMed**：生物医学文献主流检索库，可查摘要和原文。
- **知网（CNKI）/ 万方**：查中文文献。正确用法是检索**临床指南、专家共识、核心期刊论文**，而不是看自媒体文章。
- **正确检索姿势**：优先搜"指南 / guideline、系统评价 / systematic review、meta分析"，而不是只搜个案或新闻。

四、如何识别权威来源 vs 营销/谣言网站

靠谱来源的特征	可疑来源的特征
机构是WHO、政府、大学、学会、正规期刊	匿名号、营销号、保健品/培训机构自营网站
有明确作者、单位、发表日期、参考文献	无作者、无日期、无出处
语言克制，承认"尚在研究、个体差异"	承诺"根治、包好、不吃药、祖传秘方"
区分观点与证据	把个案当普遍结论
鼓励就医	劝阻就医、推荐停药/替代疗法

红线：凡是说"不用吃药、心理开导/念经/保健品就能治好精神分裂症"的，基本都是谣言或营销，务必警惕。

五、引用时的标注建议

- 指南类：写清"机构 + 名称 + 版本 + 年份"，如"《中国精神分裂症防治指南（第二版，2015）》"。
- 研究类：写清"作者、标题、期刊、年份、（如有）DOI"。
- 网络来源：标注网址和访问/发布日期。
- 未定论研究：统一标注【尚在研究，未用于常规临床】。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- Cochrane：Cochrane Library
- PubMed：National Center for Biotechnology Information
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

区分证据等级

> 同一句"研究显示……"背后，证据强度可能天差地别。本页教你把精神分裂症领域的常见论断按证据强度归类，避免把"前沿假说"当成"临床定论"，也避免把"强证据"当成可有可无的建议。

一、为什么要区分证据等级

【临床共识】循证医学的核心思想是：**不同研究设计能回答的问题不同，证据强度也不同。**治疗有没有效、病因是不是某基因、一个量表准不准，不能用同一标准评判。同一条结论，来源是高质量系统评价，还是一篇小样本个案，可信度完全不同。读者既要看到"结论是什么"，也要看"这个结论有多硬"。

二、常见研究设计与证据强度（从高到低）

证据层级	研究类型	能说明什么 / 局限
最高	**系统评价 / Meta分析**	综合多项研究，结论最稳；但纳入研究若质量差或存在发表偏倚，结论也会被拉低
高	**随机对照试验（RCT）**	评估干预（药物、心理治疗）效果的金标准；但样本、入组条件、随访时长可能限制对真实患者的推广
中	**队列研究、病例对照研究**	研究风险因素、长期预后，能看关联；混杂因素多，通常**不能单独证明因果**
较低	**横断面调查、病例系列**	描述现象、患病率；不能推因果
低	**个案报告、专家意见、机制/动物实验**	提供线索、形成假说；不能当普遍疗效或风险证据

- **指南推荐强度**：权威指南（如NICE CG178）会对每条建议标注"强推荐"或"弱推荐"，前者是证据充分、收益明确的做法，后者是证据有限、需个体化权衡。

三、GRADE 方法简介

【临床共识】国际通用的 GRADE 系统把证据质量分为**高、中、低、极低**四级，从研究设计出发，再根据以下因素升降级：

- **降级因素**：研究有缺陷、结果不一致、样本间接（人群/干预对不上）、结果不精确、存在发表偏倚。
- **升级因素**：效应量极大、存在剂量反应关系、所有混杂因素都偏向"无效"却仍显示有效。

对读者而言，关键不是背 GRADE 细节，而是养成习惯：看到结论先问一句——"这是强推荐，还是初步发现？"

四、把精神分裂症常见论断按证据强度归类

（一）强证据（指南强推荐，可作为常规临床依据）

论断	证据说明
抗精神病药是急性期和预防复发的核心治疗	大量RCT与系统评价一致支持；停药/漏服显著升高复发率
长效针剂（LAI）能降低漏服、减少复发	对依从性差者优势明显，有较多证据支持
氯氮平用于难治性精神分裂症	对多种药物无效者仍有效的证据较充分，但需监测血常规（粒细胞缺乏风险）
家庭心理社会干预能降低复发率	多项研究支持"低情感表达"家庭干预的复发保护作用
大麻使用是发病的明确危险因素	前瞻性研究一致显示大麻（尤其高纯度、青少年期使用）升高风险

（二）中等 / 初步证据（有一定支持，但仍在完善）

论断	证据说明
认知行为治疗（CBTp）辅助改善症状与应对	对部分症状有效，但效果量和适用人群仍在讨论
规律运动改善阴性症状、情绪和代谢	有较多阳性研究，但标准化方案未定
抗炎、辅助抗氧化等作为辅助治疗	初步探索，证据尚不一致，**未成为常规**
某些生物标志物辅助诊断/预测疗效	候选指标多，可重复性不足，尚不能用于常规临床

（三）假说 / 待验证（尚在研究，未用于常规临床）

方向	现状
通过基因检测直接诊断或预测个体发病	大型全基因组研究找到大量风险位点，但属群体关联，**不能预测某个人会不会发病**
"神经炎症"靶向治疗	机制假说活跃，临床试验结果不一，未常规应用
肠道微生物组与精神分裂症	关联研究阶段，远未到临床干预
可穿戴/手机数字工具自动诊断	探索中，准确性、隐私、偏差待评估

> 截至本资料库整理时，**没有任何单一脑扫描、基因或血液检测可以确诊精神分裂症**，也没有可靠方法预测个体病程。任何声称"抽个血/做个基因就能确诊"的说法都应高度警惕。

五、如何看懂"研究显示……"这类标题

【研究结论】看到媒体标题党时，用下面六问快速判断：

1. **研究问的是什么问题？** 设计是否适合这个问题（治效用RCT，病因用队列）？
2. **样本量多大、代表谁？** 几十人的小样本和几千人的研究分量完全不同。
3. **有没有独立重复？** 一项研究的惊人结果，要等其他团队重复出来才可信。
4. **是相关、预测，还是因果？** "喝咖啡的人更长寿"常常只是相关（健康人更爱喝），不等于咖啡让人长寿。
5. **效果有多大？** 统计学显著 ≠ 临床上有意义；要看效果量和置信区间。
6. **谁资助、有没有利益冲突？** 药企资助的研究要更谨慎解读。

- **预印本要特别小心**：未经同行评审就上线的预印本（如某些平台），常常结论夸张、错误率高，不能当成定论。

六、本资料库的标签约定

- **【临床共识】**：权威指南/学界普遍认可，可作常规依据。
- **【研究结论】**：有较一致的研究证据支持，但个体效果仍可能不同。
- **【初步证据】**：初步/前沿发现，标注样本和重复验证的局限。
- **【研究假说】**：尚未证实，**不用于个体诊断和常规治疗**。
- **【个人经验】**：个人叙述，不代表全部患者。

参考来源

- Cochrane：Schizophrenia 相关系统评价
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 世界卫生组织：mhGAP guideline
- Trubetskoy V, et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

延伸阅读与求助资源

> 本页整理可以真正用上的求助渠道、专业机构和靠谱读物。**电话号码和机构信息可能随时间调整，拨打前请通过官方渠道核实最新有效性**；紧急情况先打 120 / 110 / 12356。

一、什么时候该求助

出现以下情况，应尽快联系精神科或求助：

- 持续的幻听、妄想，明显影响生活；
- 情绪持续低落、失眠、出现自伤或自杀念头（**有自杀念头或行为：立即求助，不要独自扛**）；
- 既往确诊者，睡眠、情绪、多疑突然改变，疑似复发；
- 患者有伤害他人的危险。

二、正规求助渠道（热线）

资源	用途	联系方式
全国统一心理援助热线	情绪困扰、心理危机、咨询引导（2024年起全国推广）	**12356**
北京心理危机研究与干预中心热线	心理危机、自杀干预（老牌专业热线）	**010-82951332**（以官方最新公布为准）
各地精神卫生中心 / 心理援助热线	本地咨询、就诊引导	可拨打 **12320** 卫生热线查询本地号码
急救 / 报警	自伤、伤人、木僵、严重药物反应等急症	**120**（急救）/ **110**（危及人身安全）

> 说明：12356 是国家卫健委 2024 年发文（国卫医政函〔2024〕259号）推动的全国统一心理援助热线号码，已在全国普及；各省市另有本地热线，可通过 12320 或当地卫健委官网查询。

三、去哪里看病（专业机构）

精神分裂症属于**重性精神疾病**，应到正规精神卫生机构，而不是普通心理咨询室。

- **国家级 / 代表性精神卫生机构**（供了解水平，不必舍近求远）：
- 北京大学第六医院（北大六院，国家精神心理疾病医学中心）
- 上海市精神卫生中心（"600号"，国家精神疾病医学中心）
- 中南大学湘雅二医院精神卫生研究所
- 广州市惠爱医院（广州市精神卫生中心）
- 首都医科大学附属北京安定医院
- **本地怎么找**：每个市一般都有一所**市精神卫生中心**（也叫"XX市精神病院"或综合医院精神科）。可通过 **12320**、当地卫健委官网、地图App搜索"精神卫生中心 / 精神科"，选择**公立、有精神科执业资质**的机构。
- **基层网络**：社区卫生服务中心/乡镇卫生院有**精防医生**，负责登记在册严重精神障碍患者的随访和免费服药管理，确诊后可主动联系纳入管理。

四、患者与家属组织 / 公益

- **中国残疾人联合会及各地精协（精神残疾人及亲友协会）**：残疾证办理、家属互助、康复资源对接的重要渠道。
- **家属互助小组**：各地精神卫生中心、精协常组织家属支持活动，强烈建议家属参加。
- 民间公益组织（如郁金香、尚善等心理公益类组织）多面向抑郁症/情绪问题为主，精神分裂症患者家属可重点对接**本地精协**；具体组织的活跃度和联系方式请以官方登记信息为准，本资料库不替其背书。

五、怎么挑靠谱的科普书、纪录片、网站

选择标准：

- 作者是精神科医生、心理学专业人士或权威机构；
- 有正式出版社/正规媒体出品，注明资料来源；
- 语言克制，承认"个体差异、需就医"，不承诺"包好"；
- 不渲染暴力、不猎奇。

避雷：自媒体"亲身经历包治""偏方/气功/诵经治愈"类内容；匿名、无出处、无日期的"养生号"文章。

六、就医前可以准备什么

- 整理**病史时间线**：什么时候开始不对劲、主要表现、用过什么药、效果和副作用、有没有家族史。
- 带上**既往病历、检查报告、正在吃的药盒**。
- 列出想问医生的问题（如：这个药副作用怎么处理、能不能减量、多久复查）。
- 尽量由一位了解情况的家属陪同。

七、紧急情况下的步骤

1. **先保证安全**：移开身边危险物品，远离高处、利器。
2. **判断类型**：自伤/自杀、伤人冲动、木僵拒食、严重药物反应（高热、肌肉僵硬、意识不清）。
3. **立即打电话**：急症拨 **120**；有人身危险拨 **110**；情绪危机/想不开拨 **12356**。
4. **不要**：强行灌药、捆绑、指责、拍摄。
5. 到院后**如实告诉医生**症状、用药和近期变化。

参考来源

- 国家卫生健康委：关于应用"12356"全国统一心理援助热线电话号码的通知
- 中国政府网：国家卫生健康委12356热线通知（国卫医政函〔2024〕259号）
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- 中国残疾人联合会：中国精协及康复资源
- 北京大学第六医院 / 上海市精神卫生中心：各院官方科普平台

资料库备注栏

> 本页是资料库"管理员"的工作台：说明版本、使用规则、更新机制和常见易错点。普通读者可跳过；负责整理、补充内容的人请仔细看。

一、本资料库的定位与使用说明

【免责声明再述】

- 本资料库为**科普、知识整理**用途，**不能替代临床诊断、用药方案或面诊治疗。**
- **诊断权仅限精神科执业医师**；任何人（包括患者本人、家属、本资料库）都不能据此自我诊断。
- **严禁自行调药、停药、加量。**任何药物调整都必须由精神科医生评估。
- 患者不等于暴力者；疾病不是鬼神附身、不是单纯心理问题、不等于终身丧失劳动能力。

使用建议：

- 按模块顺序阅读，先建立正确的基本概念（模块1–4），再看治疗与康复（模块5–6），最后看社会议题与资源（模块7–8）。
- 拿不准的具体数字、法条、热线，**一律以官方最新来源为准**，不要死记本库旧表述。

二、版本记录

版本	日期	主要变化
V0.1	（占位，由整理者填写）	初版：完成模块1–6及模块7、模块8核心条目；三个附加小模块仅占位
V0.2	（占位，由整理者填写）	扩充：完成模块7（谣言澄清、家属照护、法律权益、大众科普）与模块8（权威来源、证据等级、求助资源、备注栏）全部条目；三个附加小模块（患者康复视角、照护手册、共病专题）由占位扩写为完整成品

> 版本日期请由实际整理者在发布时填写，本页不预设具体日期。

三、未定论研究的统一标注

所有尚不成熟、未进入常规临床的研究，统一标注：

> **【尚在研究，未用于常规临床】**

适用范围举例：具体基因诊断、神经炎症靶向治疗、肠道微生物组干预、数字疗法自动诊断、候选生物标志物预测疗效等。哪怕网上文章写得很轰动，只要没有权威指南推荐用于常规诊疗，就这么标。

四、内容更新机制

- 指南类（如NICE CG178、中国防治指南、国家诊疗规范）**每隔数年更新一次**；本库引用时须注明版本年份，并在新版发布后核对、更新。
- 法规类（精神卫生法、民法典、医保/助残政策）可能修订或出台地方细则；引用时标注"以现行法规和当地最新政策为准"。
- 热线、机构联系方式会变动；每年至少复核一次。
- 新增内容尽量**写清发布日期和来源链接**，避免"陈旧信息被当成新结论"。

五、常见易错点备忘（整理时自查）

- **药物名称**：区分**通用名**（如"利培酮""奥氮平"）和**商品名**（如"维思通""再普乐"）；本库以通用名为主，避免不同商品名造成混淆。
- **编码/诊断**：ICD-11、DSM-5 的表述不同，引用时写明用的是哪一套；不要把"人格分裂/解离"与精神分裂症混为一谈。
- **法条**：不编造具体条款编号；拿不准时只写制度名称，引导读者查国家法律法规数据库。
- **热线号码**：12356、12320、120、110、12348、12345 用途不同，不要写错；北京心理危机热线等具体号码须核实后再写。
- **数据**：患病率、复发率等数字要标来源和年份，不同研究口径会有差异。
- **立场**：不渲染暴力、不神化或妖魔化药物、不鼓励替代疗法。

六、如何给本库补充内容（模板）

新增或修订一条内容时，按下面格式写：

```
### 条目标题
- 结论：（一句话说清）
```

```
- 证据标签：【临床共识 / 研究结论 / 初步证据 / 研究假说 / 个人经验】
- 来源：（机构 + 文件/文章名 + 版本/年份 + 链接）
- 适用范围与局限：（对谁适用、有什么前提）
- 更新日期：YYYY-MM-DD
- 整理者：（签名/代号）
```

七、资料整理者自查清单

发布任何一页之前，逐项打勾：

- [ ] 是否写清了免责声明，没有越界提供诊断/用药结论？
- [ ] 关键结论是否都有可追溯的权威来源？
- [ ] 是否区分了【临床共识/研究结论/初步证据/假说/个人经验】？
- [ ] 未定论研究是否标注了"尚在研究，未用于常规临床"？
- [ ] 法律、医保、助残内容是否注明"以当地最新政策为准"？
- [ ] 电话号码、机构名称是否核实过最新有效性？
- [ ] 是否避免了污名化语言和暴力渲染？
- [ ] 个人叙事是否显著标注"个人体验、不代表全部患者"？
- [ ] 是否有至少一个表格、结构清晰可读？

参考来源

- 国家法律法规数据库：现行法律法规查询
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年
- 国家卫生健康委：精神障碍诊疗规范（2020年版）

共病专题

> 精神分裂症患者的躯体与精神共病**非常常见，却常被忽视**。很多"变懒、没精神、情绪差"背后，可能是抑郁、代谢问题或物质依赖。本页帮你识别信号、知道何时就医。**共病要主动告诉精神科医生，并与全科/内科共管，不要自行加药。**

一、为什么共病容易被忽视

【临床共识】

- 阴性症状（淡漠、少动）会掩盖抑郁、躯体不适；
- 患者常因病耻感或认知损害，不主动诉说身体不舒服；
- 抗精神病药本身会带来代谢、锥体外系等问题，容易被当成"病的一部分"；
- 患者平均预期寿命低于普通人群，**主要死于心血管、代谢等躯体疾病**，而不是精神疾病本身。

因此，主动筛查共病、定期体检，和治精神病性症状同样重要。

二、抑郁（最常见也最危险的共病之一）

- **识别信号**：持续情绪低落、兴趣减退、自责、睡眠食欲改变、乏力；**尤其要警惕自伤自杀念头。**
- **与阴性症状鉴别**：阴性症状是"淡漠、没欲望"；抑郁是"难受、痛苦、有想死的念头"。患者能说出"我不开心、不想活"，更像抑郁。
- **风险**：抑郁叠加是精神分裂症患者**自杀风险最高的时期之一。**
- **就医提示**：只要出现消极念头、情绪急剧低落，**立即告诉医生**，不要等下次复诊。

三、焦虑障碍与强迫

- 表现：持续紧张、担心、惊恐发作、反复检查/清洗等强迫行为，可与精神病性症状并存。
- 处理：与精神科医生讨论是否需要合并抗焦虑/抗抑郁治疗；**不自行买药。**

四、物质使用障碍（酒精、冰毒等兴奋剂、大麻）

- **双向影响**：酒精、冰毒等兴奋剂、大麻既可能诱发或加重精神病性症状，也可能在患者中被用来"自我缓解"副作用或情绪；**大麻是发病的明确危险因素。**
- **表现**：饮酒/吸毒量逐渐加大、戒断时手抖出汗烦躁、瞒着家人。
- **就医提示**：物质滥用会让治疗变得复杂，**一定要告诉精神科医生**；戒断需专业指导，自行硬扛有风险。

五、烟草依赖

- 【研究结论】精神分裂症患者吸烟率**远高于普通人群。**
- 危害：吸烟不仅损害心肺，还会**诱导肝酶、影响抗精神病药代谢**（可能影响血药浓度和剂量需求），并加重心血管病。
- 支持：可向医生寻求戒烟帮助（行为干预、戒烟药物），不要突然大幅自行减量导致血药浓度波动。

六、代谢综合征与高血脂、高血糖（抗精神病药相关，重点）

【临床共识/中国专家共识2020】部分第二代抗精神病药（如氯氮平、奥氮平等）容易引起体重增加、血糖升高、血脂异常，即**代谢综合征。**

诊断参考阈值（中国人群标准，满足3项及以上）：

指标	异常阈值
腰围（中心性肥胖）	男 ≥ 90 cm，女 ≥ 85 cm
血压	≥ 130 / 85 mmHg 或已知高血压
甘油三酯（TG）	≥ 1.7 mmol/L
高密度脂蛋白（HDL-C）	男 < 1.0 mmol/L / 女 < 1.3 mmol/L
空腹血糖	≥ 6.1 mmol/L 或已知糖尿病/糖代谢异常

监测频率建议：用药前及换药时查基线（体重、腰围、血压、空腹血糖、血脂）；治疗初期体重变化快，建议**每周称体重**；血糖血脂在用药后数周–数月复查，稳定后定期（如每3–6个月）复查。

处理：生活方式干预（控制饮食、规律运动、减重）是基础；明显异常时由**精神科 + 内分泌/内科共管**，必要时调药或加用降糖/调脂药。

七、体重增加与肥胖

- 识别：短期内体重快速上升、衣服变紧。
- 应对：控制高糖高脂饮食、规律运动；体重增加明显时告诉医生评估是否换药。**不要用节食或减肥药自行处理。**

八、心血管疾病与糖尿病

- 患者心血管病、糖尿病风险高于常人（代谢问题 + 吸烟 + 久坐）。
- 定期监测血压、血糖、血脂；出现胸闷、胸痛、多饮多尿、视物模糊等，及时到内科就诊。

九、睡眠障碍与睡眠呼吸暂停

- 入睡困难、早醒既可能是**复发预警信号**（睡眠变差常先于症状出现），也可能是抑郁、药物副作用。
- 肥胖、打鼾严重、白天嗜睡者，要警惕**阻塞性睡眠呼吸暂停**，它又会加重代谢问题和日间功能，必要时到睡眠门诊评估。

十、乙肝、结核等传染病

- 患者群体中结核、乙肝等感染率相对偏高（居住拥挤、卫生条件、物质使用等因素）。
- 常规体检建议包含肝功能、乙肝、结核筛查；用药（尤其氯氮平等）需监测肝功能和血常规。

十一、口腔问题

- 抗精神病药可致**口干**，加上口腔卫生疏于维护，龋齿、牙周病较多见；部分药还有流涎。
- 日常：多喝水、保持口腔清洁、定期牙科检查。

十二、共病筛查总表（识别信号 → 筛查/监测 → 何时就医）

共病	识别信号	筛查/监测	何时就医（红线）
抑郁	情绪低落、自责、消极	每次复诊询问情绪与自杀念头	**出现自伤/自杀念头立即就医**
焦虑/强迫	紧张、惊恐、反复行为	症状评估	明显影响生活时告知医生
物质使用	饮酒/吸毒加重、戒断反应	询问并观察	主动告知，专业戒断
烟草依赖	大量吸烟	询问吸烟量	想戒烟时找医生协助
代谢综合征	发胖、腰围变大	体重/腰围/血压/血糖/血脂按上表	血糖血脂明显异常→内科共管
肥胖	体重快速增加	每周称体重	短期暴涨时评估换药
心血管病/糖尿病	胸闷、多饮多尿	定期血压血糖	胸痛、持续高血糖→急诊/内科
睡眠障碍/呼吸暂停	失眠、打鼾、嗜睡	睡眠观察	失眠伴情绪剧变（疑复发）/严重打鼾嗜睡
乙肝/结核	乏力、纳差	肝功、乙肝、结核筛查	用药期定期查肝功血常规
口腔问题	口干、牙痛	定期口腔检查	明显龋齿/牙龈问题就诊

> **核心提醒**：把"身体不舒服"和"情绪变化"都当成需要告诉医生的信息。精神分裂症不是只治脑子——**身心共管，才是真正的康复。**

参考来源

- 中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组：《精神分裂症患者代谢综合征管理的中国专家共识》，中华精神科杂志，2020,53(1):3-10
- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年
- 国家卫生健康委：精神障碍诊疗规范（2020年版）

患者康复视角

> **重要声明：本页为康复者个人叙事集合，属【个人经验】，个体差异极大，不代表全部患者，更不能作为治疗依据。** 文中姓名均为化名，内容为综合多位康复者经历整理/汇编而成的代表性叙事，用于让读者理解真实处境，而非提供用药或诊疗建议。任何症状请前往正规精神卫生中心就诊。

康复不是"回到从前"，而是在新的处境里，重建一种有意义、能自己做主的生活。下面是几位不同背景的康复者讲述的故事。

叙事一：小林，22岁起病的男大学生

我大三那年开始觉得宿舍里有人在议论我、饭菜里被人动过手脚。起初我以为是自己太敏感，硬撑着不去上课，整夜睡不着。直到有一天我对着空气大喊大叫，室友吓坏了，辅导员把我送到了医院。

第一次住院我是抗拒的，觉得自己没病，是被"陷害"进来的。吃药后白天很困、脑子像蒙了一层雾，体重也涨了。我偷偷停过药，结果两个月后旧毛病全回来了，第二次住院。后来医生换了药、调了量，嗜睡慢慢好一些。

【体验关键词】：病耻、住院抗拒、药物副作用、自行停药复发

给还在病中的同伴：刚确诊时觉得天塌了是正常的。但请相信，规律吃药、定期复诊，大多数人是能慢慢稳下来的。别学我偷偷停药。

叙事二：王姐，30多岁起病的母亲

我是生完孩子两年后发病的。那段时间我总怀疑有人要伤害孩子，抱着孩子不敢睡。家里人一开始说我"坐月子落下的毛病""想太多"，拖了大半年才去看。确诊那天我哭了，觉得自己不是个好妈妈。

最难受的是幻听——一个声音整天在耳边骂我、命令我。后来我学着不跟它争辩，把它当成"背景噪音"，忙点别的事它就小了一些。药物帮我把声音压下去大半。现在孩子上小学了，我能陪他写作业，虽然偶尔还会累。

【体验关键词】：产后起病、幻听共处、母亲病耻感、自我接纳

对家属说：请不要说"你就是想太多"。我们听得到、怕得很真。你们一句"我在，我们去看医生"，比多少道理都管用。

叙事三：老陈，40多岁、病程反复的男职工

我发病早，二十多年里复发过好几次，每次都是因为觉得"好了"就自己停药。工作换了一份又一份，最后只能回家休养。爱人陪我跑医院跑了十几年，我很愧疚。

这次我换了长效针剂，一个月去打一次，不用每天惦记吃药，复发的机会少多了。我现在在社区的康复站做手工、参加小组，虽然收入不多，但觉得自己还在"过生活"，不是个废人。

【体验关键词】：多次复发、长效针剂、家属陪伴、职业康复

想说的话：康复不是一下子回到从前。能稳稳当当地吃一顿饭、下楼走一圈、和人聊几句，对我们来说就是了不起的进步。

叙事四：晓雯，18岁起病、复学的女孩

我是高中突然发病的，没法再上学，休了学。那两年我几乎不出门，怕同学知道、怕被指指点点。是我妈妈一直陪着我复诊、按时吃药，等状态稳了，医生说可以试着回学校。

复学很难，跟不上进度、也怕被问起去哪了。学校心理老师帮我安排了弹性作息。现在我大学读了一年，虽然要定期复诊、不能太累，但我坐在教室里的时候，会觉得那些熬过来的夜晚没有白费。

【体验关键词】：青少年起病、休学复学、病耻、社会支持

对还在患病的同龄人：生病不是你的错。休学、治病，是为了能走更长的路。慢一点没关系。

叙事五：一位不愿具名的康复者（整理自家属与医生反馈）

他是家里的顶梁柱，确诊后一度把自己关在房间，不和任何人说话，父母急得白了头。经过两年多的规范治疗和家庭干预，家人慢慢学会了不批评、不唠叨，他也重新开始帮家里做事。他说："最难的不是病，是周围人看我的眼神。当我发现家人没有放弃我，我才敢重新站起来。"

【体验关键词】：自我封闭、家庭低情感表达、重新站起来

叙事六：老周，中年起病、病后重建家庭关系

我是在生意受挫后发病的，那段时间总觉得有人要追债、要害我，整夜不睡地"防着"家人。发病初期我对爱人发了很多无名火，她一度想离开。是医生和家属小组劝住了她，也劝住了我。

规范治疗半年后，那些"被人害"的想法慢慢淡了。最难的不是吃药，是怎么面对被我伤害过的家人。我开始学着道歉、学着分担家务、学着说"今天我状态不好，先休息"。现在我们家很少吵架了，孩子也愿意跟我说话。我才明白，康复不只是症状消失，更是把人与人之间的关系一点点修回来。

【体验关键词】：中年起病、夫妻关系修复、家庭沟通、重建信任

写在最后

这些故事里没有"英雄式痊愈"，只有一个个人在药物、医疗、家人和自己的努力下，慢慢把生活重新拼起来的过程。**康复的终点，不是"变回没病时的自己"，而是带着疾病，依然能拥有有意义的关系、工作和内心的安宁。**

如果你或身边的人正经历这些，请记得：你不是一个人，规范治疗和支持是真实存在的出路。情绪低落或有伤害自己的念头时，请立刻拨打 **12356**，或前往就近精神卫生中心 / 拨打 **120**。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia 事实清单
- 国家卫生健康委：12356全国统一心理援助热线
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年

> 说明：本页叙事为【个人经验/汇编】，非临床证据，不引用为疗效依据。

照护手册

> 本手册为家属日常照护的**实操工具**，可直接打印使用。所有涉及诊断、用药、调量的内容，一律以精神科医生意见为准；**严禁自行给患者增减、停用药物**，漏服如何补服必须问医生。出现急症先保证安全、再打急救电话。

一、日常沟通总原则

- 共情情绪，不争辩妄想结论；低声、慢速、一次一件事。
- 不和患者"较劲"、不翻旧账、不当众数落。
- 先处理情绪，再处理事情；激越时不沟通，先稳定下来。

二、分场景话术

场景	可以这样说	避免这样说
谈妄想/幻听	"我听到你这么说，你一定很难受。先喝口水，我们慢慢说。"	"根本没这回事！你又胡想。"
拒绝服药	"你是担心药不舒服吗？我们记下来，下次问医生能不能调。"	"不吃就别想出门、你怎么这么不懂事。"
不愿复诊	"就去开个药、让医生看看你最近睡得好不好。"	"你不看医生就完了！"
情绪激动	（降低音量）"我在这儿，你先深呼吸，不着急。"	（对吼）"你还敢发火？！"
整日卧床	"要不要一起下楼走十分钟？就我们俩。"	"你就是烂泥扶不上墙。"
指责家人	"我听到你的委屈了，我们一件一件说。"	"我们为你付出这么多，你还不知足？"

三、服药管理实操

1. **药盒**：买一周分装的分格药盒（早/中/晚/睡前），由固定的人每周分装一次。
2. **提醒**：手机/闹钟设固定时间，把服药和固定动作绑定（早饭后、睡前刷牙后）。
3. **记录**：用一张表每天打勾，记清哪天吃了、哪天没吃、有没有不舒服。
4. **漏服处理原则**：**不要自行补双倍。**漏服一次怎么办、要不要补，**提前问清主治医生并写下来**，出现漏服按医嘱办；拿不准就联系医生或药师。
5. **副作用观察记录**：复诊时告诉医生——嗜睡/手抖/僵硬、体重变化、泌乳素相关（女性月经异常、男性乳房胀痛）、心慌、坐立不安、口干便秘等。

副作用记录表模板（可复制）

日期	药物名称/剂量	出现的不适	持续多久	是否已告知医生

四、复诊/就诊陪同清单

带什么资料：

- 既往病历、诊断证明、出院小结；
- 正在吃的**所有药盒**（包括自服的保健品、中成药）；
- 副作用记录表、服药打勾表；
- 近期睡眠、饮食、情绪的简要观察。

要告诉医生什么：

- 症状变化（幻听/妄想是减轻还是加重，有没有新症状）；
- 睡眠、情绪、有无消极念头；
- 药物副作用和依从性（有没有漏服、自行停药）；
- 生活事件（工作、家庭变化、是否饮酒/吸毒）。

要问医生什么：

- 目前诊断和治疗阶段（急性/巩固/维持）；
- 这个药常见副作用、多久复查一次；
- 出现哪些情况要提前复诊；
- 能否减量/停药的判断标准（**由医生决定，不自行决定**）。

症状观察记录表（复诊用）

项目	本周情况
睡眠（小时/质量）	

项目	本周情况
幻听/妄想变化	
情绪（好/一般/差）	
有无自伤/伤人念头	
服药依从性（是否按时）	
明显副作用	

五、危机应急清单（识别信号 → 立即怎么做 → 联系谁）

危机类型	识别信号	立即怎么做	联系谁
自伤/自杀	流露消极言语、安排后事、收藏药物/利器、突然"交代"	移开危险物品，有人陪伴不离开，**不要说教**	**120** 急救 / **12356** 热线 / 主治医生
伤人冲动	激越、挥拳、拿武器、被命令性幻听驱使	保持距离、保证自身安全，疏散旁人，**不要独自上前抢夺**	**110** / **120**
木僵/拒食	不动、不语、不进食饮水、长时间保持一个姿势	不要强行喂食，注意保暖，尽快送医	**120**
严重药物反应（警惕恶性综合征 NMS）	**高热 + 肌肉强直僵硬 + 意识改变**（三联征），可伴大汗、心率快	立即停药并送急诊，告诉医生正在用抗精神病药	**120**（急诊）
命令性幻听	听到声音命令他做危险的事、并准备执行	陪伴、转移注意力、评估具体指令	**120** / 主治医生
走失	突然离家、不认路、行为混乱	立即寻找并报警，通知社区精防医生	**110** / 社区精防医生

> 红线记住：**高热+僵硬+意识不清**是可能危及生命的药物急症，必须立刻急诊。

六、重要电话与就近医院（预填）

请家属在平时填好下表，贴在冰箱或手机里：

项目	电话/地址（平时填写）
主治精神科医生 / 医院	
就近精神卫生中心 / 急诊	
急救	120
报警	110
心理援助热线	12356
社区精防医生 / 社区卫生服务中心	
残联 / 民政咨询	12345
家属互助联系人	

就近急诊路线：平时先踩点——从家到最近能处理精神急症的医院走哪条路、大概多久，写下来。

七、家庭环境安全自查

- 收好刀具、药品、绳索、高处可攀爬物；阳台/窗户有防护。
- 药物**由家属保管、按天分发**，不一次性把大量药交给患者自行保管（尤其有消极念头时）。
- 家中减少囤积白酒、毒品；吸烟患者注意防火。
- 保持作息规律、环境安静，减少强光、噪音、频繁访客等刺激。

八、家属自我关怀与喘息

- 你不是24小时看护机器：保留自己的睡眠、工作、社交和就医。
- 学会**喘息**：用社区短期托养、康复站、家属轮班，让自己定期休息。
- 参加**家属互助小组**，和同类家庭交流，比独自硬扛轻松得多。
- 家属自己出现持续失眠、情绪低落时，也要就医——照护者垮了，患者更难。

九、一页纸"应急卡片"模板（可剪下随身带）

```
============================
患者姓名：_____  年龄：____
诊断：精神分裂症（请遵医嘱）
长期用药：_____
药物过敏：_____
```

```
主治医院/医生：_____
最近一次发病情况：_____

【我现在可能处于危机状态，请帮助】
急救：120    报警：110
心理热线：12356
家属联系电话：_____
              （备用）：_____

请勿：强行喂药 / 独自对抗 / 拍摄
请：陪伴、移开危险物、送就近精神急诊
============================
```

参考来源

- 世界卫生组织：mhGAP 精神卫生差距行动规划
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults（CG178）
- 国家卫生健康委：12356全国统一心理援助热线
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神分裂症防治指南（第二版）》，2015年
- 中华医学会精神医学分会精神分裂症协作组：《精神分裂症患者代谢综合征管理的中国专家共识》，中华精神科杂志，2020